

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР-
СОВЕЩАНИЕ

Искусственный интеллект в домах социального обслуживания

Практическое руководство для руководителей: что внедрять,
чего не делать и с чего начать в понедельник

Санкт-Петербург · 25–27 августа 2026 года

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации · Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга

Доклад для руководителей стационарных организаций социального обслуживания
из 51 субъекта Российской Федерации

Содержание

2. Как читать этот доклад	5
Часть I. Основания для решений	7
3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас	8
4. Шесть направлений на одной странице	10
5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны	19
6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней	23
7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация	26
8. Термины, которые понадобятся в разговоре с вендором	31
Часть II. Шесть прикладных направлений	33
9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь	34
10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона	38
11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны	43
12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы	46
13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей	50
14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций	54
15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей	56
Часть III. Внедрение	59
16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени	60
17. Правовой контур внедрения: пошагово	65
18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения	68
19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение	72
20. Этика и достоинство: где проходит граница	76
21. Безопасность данных и инциденты	82
22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле	85
Часть IV. Честные ограничения	89
23. Где искусственный интеллект не нужен	90
24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона	93
25. Критерии отказа и остановки проекта	96
Частые вопросы директоров: короткие ответы	99
Заключение: что делать в понедельник	101
Часть V. Учебные кейсы	102
Учебные кейсы. Часть 1	103
Учебные кейсы. Часть 2	107

Учебные кейсы. Часть 3	111
Приложения	114
Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)	115
Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)	117
Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»	118
Приложение 4. Библиотека проверенных промптов	119
Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем	121
Приложение 6. Формы уведомлений и согласий	123
Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)	125
Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)	126
Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)	127
Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала	128
Приложение 11. Паспорт показателя (форма)	130
Приложение 12. Формы журналов цифрового контура	131
Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)	132
Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте	133
Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)	134
Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)	135
Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)	136
Список источников	137

2. Как читать этот доклад

Доклад написан для директора, заместителя и врача стационарного учреждения социального обслуживания — человека без технического образования, у которого нет времени на специальную литературу, но есть ответственность за триста жителей, персонал и бюджет. Всё, что здесь написано, проверено по одному правилу: может ли директор после прочтения принять конкретное решение — внедрять, отклонить, отложить или запросить документы.

2.1. Из чего состоит доклад

Доклад делится на пять частей. Первая (разделы 3–8) — основания: что такое искусственный интеллект применительно к нашему учреждению, без мифов в обе стороны; какие задачи он уже решает в социальной сфере и какие не решает; что говорит закон. Вторая (разделы 9–15) — шесть прикладных направлений, разобранных по единой схеме: что это, что подтверждено, что это стоит, какие риски, с чего начать. Третья (разделы 16–22) — внедрение: дорожная карта на 12 месяцев, правовой контур, работа с персоналом и жителями, безопасность данных. Четвёртая (разделы 23–25) — честные ограничения: где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, критерии отказа от проекта. Пятая — учебные кейсы и приложения с формами документов. Завершают доклад заключение, ответы на частые вопросы директоров и список источников.

2.2. Правило маркировки

Как и в докладе о вариативном питании, каждое утверждение здесь имеет один из четырёх статусов: **факт** (проверяемый по источнику), **интерпретация** (вывод из фактов, сделанный авторами), **рекомендация** (что мы советуем делать), **иллюстративный расчёт** (модель, которую нужно пересчитать на своих числах). Где подтверждённых данных нет, прямо написано «данных нет». Это сделано не для осторожности, а потому что тема искусственного интеллекта перегружена непроверенными обещаниями — и директору нужна опора, которая не провалится при первом вопросе учредителя или проверяющего.

2.3. Три читательских маршрута

Если у вас полчаса — прочитайте раздел 4 («Шесть направлений на одной странице» и кандидаты 4.2), раздел 16 («С чего начать: дорожная карта») и раздел 24 («Чего делать не надо»). Если два часа — добавьте разделы о правовой рамке

(10), персонале (19) и безопасности данных (21). Полное чтение нужно тем, кто будет вести проект внедрения, — им доклад даёт формы документов, критерии выбора решений и готовые формулировки для учредителя.

2.4. Чего в докладе нет

Здесь нет обзора «всех технологий», рекламы вендоров и прогнозов на десять лет — и нет утверждения, что ИИ обязателен: внедрение решается по задачам учреждения, а не по моде.

★ Часть I

Основания для решений

Объективка отрасли, три класса искусственного интеллекта, существующие практики, карта задач и рабочий словарь — всё, чтобы говорить о теме без мифов. Разделы 3–8.

3. Объективка: что происходит вокруг и почему это касается нас

3.1. Исходная позиция отрасли

Стационарные организации социального обслуживания работают в условиях трёх устойчивых дефицитов: кадров (санитары, сиделки, повара, социальные работники — по всем регионам), времени персонала (старшая смены тратит значительную часть дежурства на журналы и отчётность) и управленческой информации (решения принимаются по представлениям, а не по замерам — точно так же, как было показано для питания в предыдущем докладе). Искусственный интеллект обсуждается в этом докладе не как «технология будущего», а как набор инструментов, которые претендуют закрыть часть этих дефицитов. Вопрос доклада — какую часть реально, по какой цене и с какими рисками.

3.2. Что изменилось за последние годы

Три изменения сделали тему практической, а не теоретической. Первое: генеративные модели (большие языковые модели) стали доступны без программирования — через браузер и мессенджер, в том числе российские (GigaChat, YandexGPT и другие)¹², что снимает вопрос санкционного доступа. Второе: видеоаналитика (распознавание падений, ухода жителя из зоны, скопления людей) перешла из пилотов в серийные решения, которые уже работают в российских больницах и некоторых учреждениях соцобслуживания. Третье: государство включило социальную сферу в национальную стратегию развития искусственного интеллекта⁴ — а значит, вопрос «внедряете ли вы ИИ» рано или поздно появится в показателях учредителей, и директору лучше встретить его с планом, а не с испугом.

3.3. Что уже делается в социальной сфере страны

На уровне государственных сервисов искусственный интеллект уже применяется: голосовые помощники на линиях социальной поддержки, автоматическая обработка обращений, предиктивные модели в системе соцзащиты ряда регионов (выявление семей, которым положены меры поддержки, но которые не обратились). В медицине — компьютерное зрение для анализа снимков работает в рамках московского эксперимента и ряда региональных программ. Эти практики не переносятся в дом социального обслуживания напрямую — но они создают правовые и организационные прецеденты, на которые можно опереться.

3.4. Почему именно сейчас — и почему не «все сразу»

Соблазн ответить на давление темы двумя крайностями: «внедрить всё» или «у нас это невозможно». Обе крайности дороги. Первая кончается закупкой систем, которые не привязаны к задачам и через год «лежат на складе» — а вместе с ними подорванным доверием учредителя. Вторая кончается тем, что решение примут без учреждения — и привезут готовую систему, к которой не готовы ни люди, ни процессы, ни документы. Рабочая позиция доклада — третья: выбрать одну-две задачи, где эффект измерим и риск управляем, довести их до результата и только потом расширяться. Эта же логика доказала себя в вариативном питании: ступень, замер, закрепление — а не «всё и сразу».

3.3. Контингент и контекст: почему стандартные решения не подходят

Стационарное учреждение социального обслуживания — не «маленькая больница» и не «гостиница для пожилых». Жители — люди старшего возраста и люди с инвалидностью, включая психические нарушения и деменции; значительная часть нуждается в постоянном присмотре; многие не могут сами вызвать помощь или описать, что случилось. Отсюда три следствия для технологий. Первое: ценность систем определяется именно работой с теми, кто не может позвать, — «тихие» события (ночное падение, уход из зоны, резкое изменение сна) важнее «громких». Второе: согласие и информирование у нас сложнее, чем где-либо: часть жителей дееспособна и решает сама, часть — под представительством, и процедуры обязаны различать эти случаи (разделы 18, 20). Третье: персонал перегружен уже сейчас, поэтому критерий «время сотрудника на систему» — не мелочь, а главный экономический показатель любого проекта: система, отнимающая у смены больше времени, чем возвращает, обречена независимо от своей «умности».

4. Шесть направлений на одной странице

Для ориентации — вся карта темы в одной таблице. Оценки зрелости и риска — интерпретация авторов на основе источников раздела 5; детали по каждому направлению — в разделах 9–15.

Направление	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
А. Документооборот и отчётность	Генеративный ИИ помогает писать планы, отчёты, ответы на жалобы, протоколы	Высокая — доступно сегодня	Нулевые или подписка	Утечка персональных данных в внешний сервис	Служебный регламент + обезличивание (раздел 9)
Б. Видеоаналитика безопасности	Камеры распознают падение, уход жителя из зоны, скопление	Средняя — работающие серийные решения	Камеры, сервер, подписка	Ложные тревоги → усталость персонала; биометрия	Пилот на одном отделении (раздел 11)
В. Уход и наблюдение за состоянием	Датчики и модели отслеживают отклонения: активность, сон, вес	Средняя	Датчики, интеграция	Медицинская ответственность без врача	Только в связке с врачом (раздел 12)
Г. Голосовые помощники для жителей	Умные колонки: напоминания, связь, развлечение	Средняя, устройства дешёвые	Устройства, настройка	Приватность, разочарование от «непонимания»	Добровольно, в отдельных комнатах (раздел 13)
Д. Обучение персонала	ИИ-тренажёры: разбор сложных ситуаций, симуляция диалогов	Низкая-средняя	Подписка на сервис или свои сценарии	Формальное «прокликивание»	Сценарии из собственных кейсов (раздел 14)
Е. Управленческая аналитика	Сводка журналов в панель показателей, выявление аномалий	Низкая для нашей отрасли	Аналитик или внешний подряд	Решения по некорректным данным	Начать с журналов, которые уже ведутся (раздел 15)

Главный принцип чтения карты: зрелость технологии и зрелость учреждения — разные вещи, и дорожная карта (раздел 16) строится от меньшей из них.

4.2. Кандидаты за пределами таблицы А–Е

Таблица А–Е — рабочая карта старта, а не закрытый каталог отрасли. Ниже — семь применений, которые в зарубежных домах ухода и смежных стационарах уже обсуждают, но которые **не** становятся «американским биллингом и рефералом». Для российского ДСО это расширения и кандидаты: они проходят те же колонки, что и карта выше, и те же четыре фильтра раздела 7.3. Оценки зрелости — интерпретация; по российским ДСО измеренных рядов нет.

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Ж. Лекарственная логистика	Сверка утверждённого списка врача; напоминания; штрихкод/идентификация дозы; флаги взаимодействий и РИМ медсестре — человек подтверждает. Не смена дозы, не назначение, не депрескрайбинг	Средняя для электронных журналов доз; ИИ-флаги — низкая–средняя	Планшет/ПК у процедурной, справочник назначений, регламент подтверждения	Соблазн «ИИ прописал / отменил» вместо подписи врача	После пилота документов; только контур медсестры/врача (раздел 16)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
З. Расписание смен	Оптимизация по ограничениям учреждения (часы, квалификация, предпочтения) + право старшей отменить и сотруднику обжаловать . Не «ИИ знает, сколько людей нужно»	Средняя в больницах; доказательная база почти вся не-LTC ; для ДСО РФ — низкая	Таблица смен + явные правила учреждения	Непрозрачный алгоритм и «скоринг» сотрудников	Управленческая задача; график утверждает старшая смены (раздел 19)
И. Реминисценция и персональная музыка	Добровольные плейлисты и мягкие подсказки по согласию — не лечение возбуждения и не робот-сиделка	Низкая–средняя; язык практики сильнее доказательной базы	Колонка/плеер, список предпочтений жителя, согласие	Подмена живого общения; обещание «снизит возбуждение»	Добровольно, рядом с персоналом (разделы 13, 18)
К. Дайджесты родственникам	Фиксированные поля из проверенной сводки/карты + человек утверждает до отправки. Чат-бот «обучения родственников» ≠ дайджест учреждения	Высокая как у направления А (тот же генеративный контур)	Регламент канала, шаблон полей, правило утверждения	Утечка ПД и «ИИ рассказал семье диагноз»	После правил обезличивания раздела 9

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Л. Подсветка дыр в журналах	Флаги пропуска, противоречия и просрочки — человеку на разбор. Не автоподпись и не дописывание карты с датчиков/аудио	Средняя как идея индустрии; для ДСО РФ — низкая	Электронные журналы квартала 2	Automation bias; сползание к биллингу/MDS	Расширение A/E; без Referral/Billing/MDS (раздел 9)
М. Питание и кухня	Операционный контур: библиотека утверждённых рецептов + детерминированные поля ограничений; сводка отходов/доедания. Модели недоедания — только алерт на скрининг человеком. Текстуру назначает клиника; ПО выдаёт уже допущенные рецепты	Низкая–средняя для кухни; клинические модели — больничные, в домах ухода не валидированы	Рецептурник, поля ограничений, ведомость отходов	Автономная «лечебная диета»; «диагноз с камеры/урны»	После журналов питания; кухня, не клиника (раздел 4.3)

Кандидат	Что делает	Зрелость решений	Первичные вложения	Главный риск	С чего начать
Н. Целостность кожи: пролежни / IAD	Фото → подсказка стадии или «пролежень / IAD» медсестре; человек подтверждает. Не автолечение. Сначала пакет профилактик и (кожа / поверхности / повороты)	Низкая–средняя: пилоты и feasibility, не масштаб	Смартфон, регламент фото, журнал поворотов	Автолечение; «ИИ закрыл рану»; биометрия лица	После живого графика поворотов; HITL (раздел 4.4)

Факт. Электронная лекарственная логистика в 41 доме ухода Гонконга ускорила раскладку, сверку и выдачу доз — это учёт и контроль дозы, не клинический автопилот⁵⁴. Обзор ИИ в лекарственном сопровождении пожилых (29 работ) держит умные напоминания и подсказки по сложным схемам при человеческом надзоре⁵⁵. Скопинг по полипрагмазии добавляет флаги взаимодействий и PIM — к специалисту, не вместо него⁶⁵. ИИ-расписание смен описано в больничных работах, включая целочисленную оптимизацию в онкологии: ограничения, черновик, утверждает человек; это не дома ухода⁵⁶⁵⁷⁶⁶. Реминисценция и персональная музыка звучат в языке практики и в рамке 4Ms — но прагматическое испытание персональной музыки в 54 домах ухода **не** снизило возбуждение значимо; лечебных обещаний нет⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Пресс PointClickCare (июнь 2026, не рецензия) называет Chart Advisor инструментом «дыры в документации + высокий риск — человеку» и отдельно продаёт Referral, Billing и MDS/PDPM — последние три для наших ДСО не берём⁶⁰. Обзор ИИ-документации в клинике говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи и не о дописывании карты с датчиков⁶⁹.

Интерпретация. Семь строк — не «новая карта вместо А-Е» и не приглашение купить платформу skilled nursing США. Это фильтрованные расширения: логистика лекарств и график смен — после дисциплины документов; реминисценция — мягкий слой направления Г без статуса лечения; дайджесты — документная задача с фиксированными полями; подсветка журналов — продолжение А и Е; питание — кухня и учёт, не «ИИ-диетолог»; кожа — фото медсестре и пакет поворотов, не автолечение и не робот-сиделка.

Рекомендация. Не изобретать строку про биллинг, реферал и скоринг MDS/PDPM. Кандидат, не прошедший фильтры раздела 7.3 или этический фильтр раздела 20.4, остаётся в наблюдении — не в закупке.

4.3. Кандидат М. Питание и кухня: сначала операция, не клиника

Факт. В доме ухода в Буресе (Швеция, 2025) метод «умного» контейнера измерял пищевые отходы операционно: обед в среднем 78 г на порцию (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %); смешанные блюда и картофель давали наибольший вклад. Это учёт и классификация отходов — фундамент для последующей автоматизации, не клинический диагноз недоедания⁶¹. Больничный обзор ESPEN (12 работ) показывает, что модели недоедания в стационаре иногда дают AUC выше 90 % — но это больница, не дом ухода; отдельный систематический обзор фиксирует, что больше 90 % таких моделей не входят в повседневную практику⁶²⁶³. Назначение текстуры при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), а не решение камеры по фото тарелки⁶⁴.

Интерпретация. Для ДСО старт совпадает с логикой доклада о вариативном питании: сначала дисциплина кухни. Библиотека рецептов, которые уже утвердил врач/диетолог, и жёсткие поля ограничений (что нельзя положить в тарелку этому жителю) — детерминированный контур, а не «модель подобрала диету». Сводка отходов и доедания продолжает ведомость остатков и журнал отказов. Модель недоедания, обученная на больничных картах, в наш дом не переносится как диагноз.

Рекомендация. Пилот М — после журналов питания, которые уже ведутся: утверждённый рецептурник + поля ограничений + агрегированная панель отходов. Текстуру назначает врач/логопед; программа только достаёт рецепты, уже допущенные на этот уровень. Исключить из закупки: автономную лечебную диету; компьютерное зрение «по фото — текстура или аспирация»; диагноз недоедания с камеры или урны. Если модель недоедания появится — только алерт: человек проводит скрининг (разделы 12, 20, 23).

4.4. Кандидат Н. Целостность кожи: пролежни / IAD

Факт. Смартфонная постановка стадии пролежня задумана для неспециалиста, когда раневой эксперт не на площадке: на валидации 144 фото общая точность 63,2 %; специфичность по классам высокая (85,1–100 %), чувствительность стадии 2 — 37 %. Это пилот классификации, не лечение⁷¹. Немецкий контур KIADEKU сочетает снимок с сестринским минимумом данных (18 раневых и 4 этиологических

категории — **не** американский MDS/PDPM) и DSS медсестре; регистрация разработки — DRKS00029961⁷². Контролируемый пилот той же линии (88 сеансов ухода, семь отделений университетской клиники LMU, DRKS00031355): среднее время ухода и документации выросло (12,84 против 9,20 мин), соблюдение гайдлайна — выше; нагрузка по NASA-TLX статистически не снизилась, тип раны модель опознаёт лучше, чем категорию. Автолечения нет⁷³. Британский пакет профилактики в доме ухода (feasibility, один дом на севере Англии) держит три практики: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. До пакета в журнале жили в основном повороты; во время внедрения появились осмотр кожи и проверка поверхностей. Это дисциплина ухода, не модель⁷⁴. Канадский сельский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound фиксирует готовность персонала к цифровому учёту ран, не масштаб внедрения⁷⁷. Японский CDSS для патронажных медсестёр оценивает тяжесть по DESIGN-R®2020 и даёт рекомендации человеку — не вместо него⁷⁸.

Интерпретация. Для ДСО старт совпадает с разделом 23.2: сначала график поворотов и контроль старшей сиделки. Фото → подсказка медсестре, когда экспертизы нет на площадке. Пилот ≠ масштаб: 63 % и неровная чувствительность стадии 2 — аргумент против «ИИ поставил стадию». Немецкий пилот честно показал больше времени у постели: человек в контуре дорожке клика, зато ближе к гайдлайну. Матрас с картой давления (один кейс на Тайване) и сенсорные пластыри Fraunhofer EMFT / KIPRODE (feasibility, разработка) — железо позже, не пилот № 1⁷⁵⁷⁶.

Рекомендация. Кандидат Н — после живого пакета профилактики. Пилот: смартфон + регламент фото (рана, не лицо; без биометрии) + журнал поворотов; модель предлагает стадию или «пролежень / IAD», медсестра подтверждает, лечение назначает врач. Исключить из закупки: автолечение; «ИИ закрыл рану»; распознавание лица; матрас или пластырь как первый шаг.

Карта шести направлений: что, зачем и когда

А. Документы

Генеративный ИИ: черновики, сводки, ответы на обращения.

Зрелость: высокая.

Вложения: нулевые / подписка.

Главный риск: утечка персональных данных.

Старт: квартал 1 — регламент (прил. 3) + 5 промптов (прил. 4).

Б. Видеоаналитика

Камеры распознают падение и уход из зоны — события, не лица.

Зрелость: средняя, серийные решения.

Вложения: камеры, сервер, подписка.

Главный риск: ложные тревоги → усталость смены.

Старт: квартал 4 — пилот 90 дней на одном отделении.

В. Наблюдение за состоянием

Датчики сна, веса, активности для жителей из списка врача.

Зрелость: средняя.

Вложения: датчики, интеграция.

Главный риск: медицинская ответственность без врача.

Старт: квартал 3 — только в связке с врачом.

Г. Голосовые помощники

Колонки: напоминания, радио, связь — по добровольному согласию.

Зрелость: средняя, устройства дешёвые.

Вложения: устройства, настройка.

Главный риск: приватность, разочарование.

Старт: кварталы 3–4 — 3–5 добровольцев.

Д. Обучение персонала

ИИ-тренажёр сложных диалогов на собственных кейсах.

Зрелость: низкая-средняя.

Вложения: время тренера.

Главный риск: формальное «прокликивание».

Старт: квартал 2 — 10 сценариев (прил. 10).

Е. Управленческая аналитика

Журналы → таблицы → паспорта показателей → панель.

Зрелость: низкая для отрасли.

Вложения: время ответственного.

Главный риск: решения по некорректным данным.

Старт: квартал 2 — три журнала в таблицы.

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается без своих документов (раздел 17.3).

5. Что такое искусственный интеллект — без магии в обе стороны

5.1. Рабочее определение для директора

Для управленческих решений достаточно такого определения: искусственный интеллект — это программы, которые находят закономерности в больших массивах данных и используют их для предсказания, распознавания или порождения нового текста, изображения или решения. Три класса, которые встретятся вам в предложениях вендоров: **распознающие** (видеоаналитика — «это падение, а это просто человек лёг»; распознавание документов), **предсказывающие** (модели риска — «у этого жителя высокая вероятность падения в ближайший месяц») и **генерирующие** (большие языковые модели — пишут тексты, отвечают на вопросы, обобщают документы). Каждый класс имеет свои сильные стороны, свои типовые отказы и свою цену ошибки.

5.2. Пять мифов, которые мешают решению

Миф 1. «ИИ заменит персонал». В стационарном учреждении — нет: уход, кормление, сопровождение, человеческое присутствие не автоматизируются. Реалистичный эффект — возврат времени: автоматизация пишущей и смотрящей работы (журналы, сводки, ночное наблюдение за монитором) возвращает часы живой работе. Тот, кто продаёт вам «сокращение штата за счёт ИИ», продаёт то, чего в наших условиях не будет; тот, кто говорит «ИИ нам ничего не даст», не видит возврата времени.

Миф 2. «ИИ объективен». Модель наследует смещения данных, на которых училась. Предиктивная модель, обученная на чужих учреждениях, может систематически ошибаться на ваших жителях. Языковая модель уверенно пишет и правильное, и выдуманное — это её штатный режим, называемый «галлюцинацией». Вывод: ИИ — помощник, чей результат проверяет человек, а не судья.

Миф 3. «ИИ — это про роботов». Физическая робототехника (роботы-няни, экзоскелеты) в наших учреждениях — горизонт многих лет и отдельных бюджетов; доклад её не рассматривает как практическую тему. Практическая тема — программный ИИ, который уже живёт в сервисах, доступных через браузер.

Миф 4. «Это незаконно / это запретят». Закон не запрещает искусственный интеллект — он регулирует то, что ИИ делает с данными и решениями. Обработка

персональных данных, биометрия, автоматизированные решения о людях — под особым режимом (раздел 10). Внутри этого режима законное внедрение возможно и делается; вне его — штрафы и, что хуже, потеря доверия жителей и родственников.

Миф 5. «Нужна большая цифровизация сначала». Частично верно только для направлений В и Е. Для направления А (документы) достаточно компьютера и регламента; для направления Б (видеоаналитика) — камер и дисциплины реагирования, а не «цифровой зрелости» вообще.

5.3. Где ИИ силён, а где слаб — применительно к нашему дому

Силён там, где есть рутина с повторяющейся структурой: свести журнал, переписать письмо, заметить отклонение от обычной картины на камере или в графике активности. Слаб там, где нужны ответственность, контекст конкретного человека и этическое суждение: оценить состояние жителя, решить спор, утешить, принять решение о жизни и здоровье. Граница проходит просто: ИИ готовит вариант или сигнал — человек решает. Все архитектуры внедрения в этом докладе построены на этом принципе «человек в контуре» (human-in-the-loop), и отказ от него — первый признак плохого проекта (раздел 24).

5.3. Как модель учится и почему ошибается (объяснение за две минуты)

Понимание двух свойств моделей снимает большинство управленческих ошибок. Первое свойство: модель обучается на примерах, а не на правилах. Ей показали миллионы текстов, и она научилась, какие слова обычно идут друг за другом, — поэтому она бегло пишет «похожие» тексты, но не знает, какое утверждение в них истинно. Второе свойство: модель не различает «помню» и «сочиняю» — оба результата получаются одним и тем же механизмом, поэтому вымышленная статья закона выглядит так же уверенно, как настоящая. Из этих двух свойств следуют три рабочих правила: проверять факты (особенно цифры, нормы, реквизиты), не спрашивать у модели то, чего нет в её обучающих данных (ваши внутренние регламенты она не знает), и не ждать от неё самокритики («а вы уверены?» — она ответит «да» с той же уверенностью). Всё это — не дефект конкретного сервиса, а свойство класса: оно не исчезнет в следующей версии, а значит, регламент проверки — навсегда.

Три класса ИИ, которые вам будут продавать

Распознающие

Видят и слышат: видеоаналитика падений, распознавание документов, речь в текст.

Сильная сторона: не устают, смотрят ночью.

Типовой отказ: ложные тревоги, слепые зоны.

Цена ошибки: пропущенное событие или усталость смены.

У нас: направления Б и В.

Предсказывающие

Оценивают риски: «у этого жителя высокая вероятность падения».

Сильная сторона: раннее внимание к риску.

Типовой отказ: мусор на входе — мусор на выходе.

Цена ошибки: решения по ложным числам.

У нас: рано — нет данных за годы (раздел 23.4).

Генерирующие

Пишут и говорят: черновики документов, сводки, тренажёры диалогов.

Сильная сторона: экономия часов в первую же неделю.

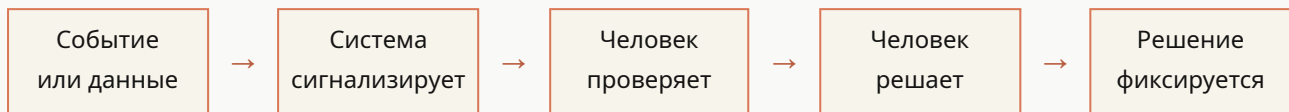
Типовой отказ: уверенная ложь — «галлюцинации».

Цена ошибки: непроверенный факт в официальном письме.

У нас: направления А и Д — старт здесь.

Ни один класс не «думает» и не «понимает» в человеческом смысле: все три находят закономерности в данных. Поэтому два правила неизменны для всех классов: проверка человеком и обезличивание данных. Пять мифов о каждом классе — раздел 5.2.

Принцип «человек в контуре»: как устроено любое наше решение



Что делает система

Смотрит, слушает, считает, черновит, напоминает. Не устаёт, не отвлекается, не спит на ночном посту.

Что делает человек

Проверяет сигнал глазами и опытом, принимает решение, отвечает за него перед жителем, семьёй и законом.

Почему это не только этика

Ст. 16 закона о персональных данных запрещает решения о человеке на основе исключительно автоматизированной обработки². «Человек в контуре» — юридическая необходимость.

Проверка любого предложения вендора: попросите показать, в каком месте схемы человек и успевает ли он проверить. Если человека в схеме нет или он «подтверждает» сто решений в минуту — контура нет.

6. Что уже работает: практики в социальной сфере и рядом с ней

6.1. Социальная защита: обращения и назначение мер поддержки

В системах соцзащиты нескольких регионов искусственный интеллект применяется для приёма и маршрутизации обращений граждан (голосовые помощники на горячих линиях, классификация письменных обращений), а также для проактивного назначения мер поддержки: модель анализирует обезличенные данные и выявляет семьи, которым положены выплаты или услуги, но которые не обратились⁹. Это государственный уровень, не уровень учреждения — но он важен директору по двум причинам. Во-первых, он создаёт ожидания учредителей: «проактивность» и «цифровые сервисы» входят в показатели, и от учреждений будут ждать готовности отвечать в этой логике. Во-вторых, он даёт правовые прецеденты проактивных автоматизированных решений, полезные при разговоре с юристом.

6.2. Медицина: компьютерное зрение и экспериментальные правовые режимы

Самая зрелая российская практика прикладного ИИ — анализ медицинских изображений (московский эксперимент по компьютерному зрению⁸, в рамках которого сервисы помогают врачам-рентгенологам; аналогичные решения развиваются в ряде регионов). Для нас значимы три вывода из этого опыта. Первый: внедрение шло через экспериментальный правовой режим с отдельными актами — то есть «сначала правовой контур, потом технология». Второй: модель работает как «второе мнение» при враче, а не вместо врача — тот же принцип «человек в контуре». Третий: эффект измерялся количественно (скорость обработки, полнота выявления), а не ощущениями. Все три вывода прямо переносимы на внедрение в учреждении соцобслуживания.

6.3. Стационарные учреждения: видеоаналитика безопасности

Видеоаналитика (распознавание падения, ухода человека из зоны, отсутствия движения) — единственный класс ИИ-решений, который уже работает в российских учреждениях, близких к нашим: в больницах и в отдельных домах престарелых. Публичных подтверждённых практик именно в домах социального обслуживания и ПНИ — единицы; подробных публикаций с измеренными результатами (сколько

падений предотвращено, как изменилась нагрузка смены) нет — данных нет, и это честная исходная позиция: директор, внедряющий видеоаналитику, идёт по тонкому льду и обязан мерить эффект сам. Систематические обзоры BMC и JMIR (2025–2026) показывают ту же скромность уже для западного LTC: консенсуса по эффективности нет, качество первичных обзоров низкое — см. 23.6⁴⁹⁵⁰. Техника пилота с точками замера — в разделе 11, критерии, по которым пилот признаётся неудачным, — в разделе 25.

6.4. Что делают коллеги в зале

По материалам подготовки к семинару прямых подтверждённых практик ИИ среди участвующих учреждений не выявлено — в отличие от вариативного питания, где три практики присутствовали в зале. Это нормальная исходная позиция для новой темы, и у неё есть преимущество: первые аккуратные практики получают статус опорных, а их директора — экспертный голос в отрасли. Доклад построен так, чтобы дать участникам инструменты стать такой практикой без типовых потерь: юридических, кадровых и репутационных.

6.5. Международный опыт: что измерено и что не переносится

За рубежом в учреждениях длительного ухода измерены в основном два класса эффектов: падение частоты падений при видеоаналитике и датчиках (в ряде исследований — снижение на десятки процентов на пилотных отделениях, но с высокой вариабельностью и вопросами к устойчивости) и возврат времени персонала при автоматизации документации. Социальные роботы и голосовые помощники показали эффект на одиночество и настроение в малых выборках; устойчивость эффекта за пределами нескольких месяцев не подтверждена — это же место в обзоре BMC названо относительно лучшим по данным, при высоком риске смещения⁴⁹. Umbrella-обзор JMIR добавляет устойчивые барьеры: ложные тревоги, приватность, ломка workflow; качество исходных обзоров — низкое или критически низкое⁵⁰. Переносить эти цифры на наши учреждения нельзя: другой профиль жителей, другое право (биометрия, персональные данные), другая кадровая реальность. Использовать их можно только как указание, **где эффект искать** — с последующим собственным замером.

6.4. Международный опыт: что берём и что нет

В странах с развитым сектором ухода (Япония, Нидерланды, Скандинавия) технологии наблюдения в домах престарелых применяются шире российской практики: датчики движения и сна, системы вызова, роботы-компаньоны,

телемедицина. Из этого опыта доклад берёт три вывода. Первый — масштабирование шло через стандарты и финансирование ухода, а не через «закупку роботов»: технология встраивалась в регламенты ухода. Второй — главным ограничителем везде оказались не технологии, а принятие персоналом и семьями: программы внедрения включали обучение и работу с возражениями как обязательную часть. Третий — прямой перенос невозможен: иная модель финансирования (страхование ухода), иные штатные нормативы, иное право. Поэтому международные публикации используются здесь как источник гипотез («это может сработать»), но не как доказательство («это сработает у нас»): эффект в наших условиях измеряется собственными пилотами.

7. Задачи учреждения, которые претендуют на ИИ: инвентаризация

7.1. Принцип: не «куда пристроить ИИ», а «какая задача болит»

Внедрение, начатое с технологии, кончается складом. Внедрение, начатое с задачи, имеет шанс. Поэтому первый шаг — инвентаризация задач учреждения по трём признакам: задача повторяется (ежедневно/еженедельно), задача съедает заметное время персонала или создаёт риск, задача имеет измеримый результат (часы, число инцидентов, срок ответа). Ниже — типовая инвентаризация для стационарного учреждения; на семинаре она превращается в упражнение (сценарий малых групп, элемент пакета).

7.2. Карта задач по направлениям

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Составление планов, отчётов, ответов учредителю	Часы управленческого состава в неделю	А. Документы	Часы на документ; срок ответа
Заполнение и сверка журналов	Час-два смены в день	А + Е	Ошибки сверки; время смены
Ночное наблюдение за отделениями	Человек у монитора; пропуск событий	Б. Видеоаналитика	Число обнаруженных событий; ложные тревоги
Падения жителей	Каждое падение — травма, расследование, ответственность	Б + В	Частота падений; время обнаружения
Уход жителя из здания/зоны	Риск для дезориентированных жителей	Б	Число инцидентов; время обнаружения
Отслеживание отклонений состояния	Замечается поздно, по жалобе	В	Доля отклонений, замеченных раньше жалобы
Напоминания жителям (лекарства, режим)	Устные напоминания смены	Г	Доля пропусков
Обучение новых сотрудников типовым ситуациям	«Учится на жителях»	Д	Время введения в должность; ошибки новичков

Задача	Время/риск сейчас	Направление ИИ	Измеримый результат
Сводка показателей для учредителя	Ручная сборка раз в квартал	Е	Часы на отчёт; актуальность данных
Лекарственная логистика: раскладка, сверка, выдача, напоминания	Час и больше смены; риск пропуска/перепутания дозы	Ж (кандидат; не «ИИ-врач»)	Время на дозу; пропуски; подсказки врачу, не автоназначение
Сборка и закрытие графика смен	Часы старшей; дыры в покрытии; ощущение несправедливости	З (кандидат; управленческое)	Время сборки; незакрытые смены; жалобы на нагрузку
Реминисценция / персональная музыка	Формальные занятия; одиночество без замены персонала	И (кандидат; добровольно)	Доля добровольцев, кто пользуется; отказ без последствий
Дайджесты и FAQ родственникам	Повторяющиеся звонки; разный рассказ по сменам	К (кандидат; не чат-бот-сиделка)	Срок ответа семье; жалобы на «нас не информируют»
Подсветка дыр в журналах и картах	Пропуски, противоречия и просрочки видны только на проверке	Л (кандидат; расширение А+Е; не автоподпись)	Доля обязательных полей; флаги, ушедшие человеку на разбор
Питание и кухня: рецептурник, ограничения, отходы	Ручной подбор блюд; отходы и отказы видны поздно	М (кандидат; кухня, не «ИИ-диетолог»)	Время сборки меню; доля порций с соблюденным ограничением; кг отходов
Целостность кожи: пролежни / IAD	График поворотов живёт на бумаге; стадии и PU/IAD путают без раневого эксперта	Н (кандидат; HITL-фото, не автолечение)	Доля обязательных поворотов; флаги стадии / PU vs IAD, ушедшие медсестре

7.3. Отбор первой задачи: четыре фильтра

Не все задачи из карты подходят для старта. Первая задача отбирается четырьмя фильтрами: **боль** (все в учреждении согласны, что задача — проблема), **измеримость** (можно посчитать до и после), **обратимость** (если не сработает — можно выключить без последствий), **правовая чистота** (минимум персональных данных и никакой биометрии на старте). По этим фильтрам почти всегда выигрывает направление А (документы и отчётность): боль всеобщая, эффект измеряется в часах, выключить — значит просто перестать пользоваться, а правовые риски закрываются регламентом обезличивания. Именно поэтому

дорожная карта (раздел 16) начинается с него — как доклад о питании начинал с бесплатной ступени 0.

7.4. Чего в карте нет — сознательно

В карту не включены задачи, где ИИ обсуждается публично, но неприменим или недопустим в наших условиях: распознавание эмоций жителей по лицу (научно сомнительно и этически неприемлемо), полностью автоматические решения о людях (например, о переводе, режиме, ограничениях) — это запретная зона, а не направление (раздел 24), и «умные» решения вместо врача. Не включены и американские контуры *skilled nursing* — скоринг реферала, биллинг и MDS/PDPM: это чужая платёжная модель, а не задача российского ДСО (раздел 4.2). Не включены автономная лечебная диета, «текстура/аспирация по фото» и диагноз недоедания с камеры или урны (кандидат М, разделы 4.3, 23). Не включены автолечение раны и робот-сиделка: фото пролежня — медсестре, не «ИИ закрыл рану» (кандидат Н, раздел 4.4). Семь кандидатов Ж-Н в инвентаризации — не отмена этих исключений: лекарственная логистика не становится назначением или отменой дозы, дайджест семье — не чат-бот обучения родственников и не сиделка, подсветка журналов — не «ИИ закрыл карту», кухня — не клинический автопилот, кожа — не автолечение. Возвращаясь к правилу предыдущего доклада: организационные решения принимает директор, клинические — врач; искусственный интеллект это правило не отменяет, а делает его соблюдение ещё более обязательным.

7.4. Задачи, которые обычно называют — и что с ними делать

Чтобы фильтры стали рабочим инструментом, прогоним через них типовой список из совещаний. «Ночные обходы утомляют смену и всё равно что-то пропускают» — боль измеримая (число поздно обнаруженных событий), решение обратимое, правовой контур посильный: кандидат в пилот направления В/Б. «Устали писать однотипные отчёты учредителю» — направление А, старт немедленный, без пилота. «Хотим предсказывать обострения за две недели» — провал фильтра измеримости и данных: в наблюдение, возврат через год дисциплины записей. «Нужна камера в каждой комнате для спокойствия родственников» — провал этического фильтра и раздела 20: вне зависимости от технической доступности. «Робот-сиделка для разговоров с жителями» — провал фильтра боль: проблема одиночества реальна, но этот инструмент её не решает (раздел 13 о реалистичных ожиданиях). «Учредитель просит цифровую панель к отчёту» — задача формально проходит фильтры, но первый квартал уйдёт на дисциплину данных: панель по

неполным журналам нарисует красивую ложь. Такой прогон списка через фильтры — сам по себе полезное совещание: он занимает час и даёт повестку на год.

Четыре фильтра отбора первой задачи

1. БОЛЬ

Есть измеримая проблема: жалобы, минуты, случаи. Назовите число «до».

2.

ИЗМЕРИМОСТЬ

Понятно, как узнать, что стало лучше: метрика и способ замера до старта.

3.

ОБРАТИМОСТЬ

Провал пилота не вредит жителям и не сжигает бюджет: маленький охват, короткий срок.

4. ПРАВОВАЯ

ЧИСТОТА

Без биометрии, без решений о людях алгоритмом, с прозрачным контуром данных.

Прошла все четыре

Задача-кандидат в пилот: оформляется паспорт пилота (приложение 7), назначаются метрики и критерии исхода.

Провалила хотя бы один

Не пилот, а тема для наблюдения: фиксируется в реестре идей и пересматривается через квартал на новых данных.

Почему первым — направление А

Документы проходят все четыре фильтра сразу: боль известна, эффект измеряется в часах, откат — один день, правовой контур — один приказ.

Фильтры работают и в обратную сторону: предложение, не прошедшее фильтры, не становится лучше от приставки «с искусственным интеллектом» (разделы 7 и 23).

8. Термины, которые понадобятся в разговоре с вендором

Вендоры говорят на языке, в котором легко утонуть. Директору достаточно десяти терминов — и умения задавать по каждому один контрольный вопрос.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов, которая генерирует ответ, письмо, сводку. Примеры: GigaChat, YandexGPT, ChatGPT. *Контрольный вопрос вендору:* где физически обрабатываются тексты, которые мы отправляем, — и что происходит с ними после ответа?

Галлюцинация — уверенная генерация фактически неверного содержания. Не дефект конкретной модели, а свойство класса. *Правило:* любой факт, число и ссылка на норму из ответа модели проверяются человеком до отправки документа.

Промпт — инструкция модели. Качество ответа зависит от качества инструкции; библиотека проверенных промптов учреждения — такой же рабочий инструмент, как библиотека бланков (приложение с примерами — в приложениях).

Обезличивание (деперсонализация) — удаление из текста данных, по которым идентифицируется человек, до отправки текста во внешний сервис. *Правило:* во внешний сервис не уходит ни одной фамилии, даты рождения, номера документа или диагноза с именем (раздел 9).

Персональные данные — любые сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому человеку (152-ФЗ). Состояние здоровья — специальная категория с усиленным режимом.

Биометрические персональные данные — изображения лица и иные данные, позволяющие установить личность (572-ФЗ о ЕБС и ст. 11 152-ФЗ). Камера «просто наблюдения» и камера с распознаванием лиц — юридически разные вещи; вторая требует отдельного правового контура (раздел 10).

Компьютерное зрение / видеоаналитика — распознавание событий в видеопотоке: падение, уход из зоны, скопление. Важно: можно распознавать события **без** идентификации личности — и это правовой и этический минимум для нашего учреждения.

Ложная тревога (false positive) — сигнал системы при отсутствии события. Главный убийца видеопроектов: при частых ложных тревогах смена перестаёт реагировать — и система становится хуже её отсутствия. *Контрольный вопрос*

вендору: какая доля ложных тревог у вашего решения в учреждениях нашего профиля, и как она настраивается?

Пилот — ограниченный по времени и масштабу эксперимент с заранее заданными точками замера и критериями исхода. Не «попробовать», а измерить. Форма паспорта пилота — в приложениях.

Человек в контуре (human-in-the-loop) — архитектурный принцип: система готовит сигнал или вариант, решение принимает человек. Всё, что предлагается вам без человека в контуре в вопросах жизни, здоровья и прав жителей, отклоняется сразу.

8.2. Ещё пять терминов — для договоров и совещаний

Оператор персональных данных — тот, кто определяет цели обработки (учреждение), в отличие от обработчика по поручению (вендор). Ответственность перед законом несёт оператор — договором её не передать. **Утечка** — неправомерная передача данных третьему лицу, включая случайную: «отправил не тому» — тоже утечка. **Валидность модели** — мера того, что система распознаёт именно то, что заявлено, на ваших данных, а не на презентационных; проверяется только пилотом. **Слепая зона** — пространство или ситуация, которых система не видит (камера не покрывает санузел; датчик сна не видит дневное падение); слепые зоны документируются в паспорте пилота, чтобы никто не считал покрытие полным. **Время реакции** — интервал от события до действия человека; главная метрика направлений Б и В, потому что ценность системы определяется не тем, что она заметила, а тем, что после её сигнала успели сделать люди. Контрольный вопрос на владение терминами тот же: сможете объяснить каждый своими словами старшей смены — без слов «алгоритм» и «нейросеть»?

Шесть прикладных направлений

Документы, правовая рамка, видеоаналитика, наблюдение за состоянием, голосовые помощники, обучение персонала и управленческая аналитика. Разделы 9–15.

9. Направление А. Документы и отчётность: старт здесь

9.1. Что это и почему первое

Генеративный ИИ (большие языковые модели) умеет: переписать текст официальным языком, свести десять страниц журнала в полстраницы сводки, подготовить каркас плана или ответа на обращение, сделать из протокола список поручений, перевести «с канцелярского на человеческий» для родственников жителя. Это единственное направление с нулевыми капитальными вложениями, эффектом в первую же неделю и обратимостью в один день. Поэтому оно первое — но именно оно чаще всего внедряется неправильно: директор или секретарь вставляет в чат-бот письмо с фамилией жителя и диагнозом — и учреждение получает утечку персональных данных в внешний сервис.

9.2. Правовой минимум: регламент использования

До первого использования издаётся приказ «О порядке использования сервисов генеративного ИИ» (проект — приложение 3). Его ядро — четыре правила: (1) во внешние сервисы отправляются только обезличенные тексты — без фамилий, дат рождения, номеров документов, имён с диагнозами; (2) список допущенных сервисов утверждается приказом, и он короткий; (3) любой текст, подготовленный ИИ, проверяется и подписывается человеком — ответственность за документ несёт подписавший, а не модель; (4) запрещённые сценарии перечислены явно: медицинские заключения, решения о жителях, любые тексты, где ошибка опасна. Регламент — одна страница, но без него использование ИИ в учреждении неуправляемо.

9.3. Рабочие сценарии с промптами

Пять сценариев закрывают большую часть офисной пользы (полная библиотека — приложение 4). **Сводка журнала:** «Сведи следующий текст в 10 строк: что случилось, что сделано, что требует решения руководства». **Ответ на обращение:** «Подготовь каркас ответа на обращение гражданина по такой структуре: подтверждение получения, суть ответа, сроки, контакт. Тон — официальный, без канцеляризмов». **План мероприятия:** «Составь план недельного цикла занятий для отделения милосердия: 5 дней, по 2 занятия, с учётом жителей с нарушениями слуха и зрения». **Разбор протокола:** «Из протокола совещания выдели: решения, поручения с ответственными, открытые вопросы». **Проверка текста:** «Проверь

письмо на канцеляризм и длинные предложения, предложи правки». Каждый сценарий сохраняется как проверенный промпт — коллективная библиотека растёт с опытом.

9.4. Измерение эффекта

Эффект измеряется до и после в течение двух недель: время на подготовку типовых документов (отчёт учредителю, ответ на обращение, план) по самоотчёту трёх сотрудников, занятых документами. Типовой результат внедривших офисов — экономия от трети до половины времени на черновую работу; у вас цифра будет своя, и она — единственная, которая имеет значение для учредителя. Одновременно ведётся журнал инцидентов: каждый случай отправки необезличенных данных или публикации непроверенного текста фиксируется и разбирается — без поиска виноватых, иначе заполнение журнала прекратится.

9.5. Типовые ошибки направления

Первая: отсутствие регламента — «все и так понимают». Не понимают: утечки происходят от неведения, а не от злого умысла. Вторая: отправка в работу текстов без проверки — модель уверенно сочиняет несуществующие нормы и реквизиты; каждая ссылка на закон из текста ИИ проверяется по базе. Третья: попытка «кормить» модель реальными делами жителей «для качества» — запрещено регламентом, точка. Четвёртая: ожидание, что модель заменит специалиста по кадрам или бухгалтера — она ускоряет черновики, а не принимает решения и не несёт ответственности.

9.6. Пример до и после: сводка за смену

До. Старшая смены пишет сводку 25–30 минут, ближе к концу дежурства: «За смену происшествий не было. Жильцов 41. К врачу обращались 2. В столовой всё по расписанию». Такая сводка ничего не даёт управлению, но никого не винит: форма не требовала большего.

После. Журнал смены (без персональных данных) вставляется в проверенный промпт: «Сведи в 8 строк: события, требующие решения; отклонения от распорядка; обращения к врачу; что нужно закупить/починить». Черновик готов за минуту; старшая смены проверяет и правит его 10 минут — и это не «экономия 20 минут», а три конкретных выигрыша: сводка стала содержательной (структура задана промптом, а не настроением), одинаковой по сменам (можно сравнивать недели), и время старшей смены вернулось к жителям. Именно такой пример — со

своими документами, на своей планёрке — убеждает коллектив лучше любой презентации об «эпохе ИИ». Соберите три-четыре таких примера до/после в первый месяц: они станут вашим внутренним отчётом и аргументом для учредителя.

9.7. Открытый кейс ПНИ: локальный ассистент и документы

Факт. Ближайший открытый российский кейс именно из социального учреждения — психоневрологический интернат: on-prem ассистент для персонала в локальной сети, без публичных портов и с запретом отправки персональных данных во внешнюю модель³²; поверх него — поиск по локальным приказам и отчётам (RAG) для черновиков ответов на запросы надзора³³. Тот же класс задачи — поиск по своим документам с контролем данных, без обязательного облака⁴⁴.

Интерпретация. Это иллюстрация из открытого источника, а не поручение копировать стек автора. Для доклада важен контур, а не конкретная платформа: человек проверяет черновик, документы остаются на площадке или уходят только обезличенными, модель не «знает учреждение», а ищет по утверждённой базе.

9.8. Рядом с документами: дыры в журналах и дайджесты семье

Направление А не кончается черновиком ответа учредителю. Два смежных кандидата живут на тех же правилах обезличивания.

Факт. В прессе вендора skilled nursing (июнь 2026, не рецензия) Chart Advisor описан как подсветка пробелов в документации и ситуаций высокого риска — для разбора человеком; в том же пакете продают Referral Advisor, Billing Advisor и MDS/PDPM⁶⁰. Клинический обзор ИИ-документации говорит о качестве и времени черновика, не об автоподписи карты⁶⁹.

Интерпретация. Для ДСО полезна только первая идея: модель ставит флаги пропуска, противоречия и просрочки в журнале смены — старшая смены и врач решают, правда это или шум. Модель не подписывает запись и не дописывает карту с датчиков, аудио обхода или «тишины в комнате». Американский скоринг поступления, счетов и MDS в нашу карту не входит (разделы 4.2, 7.4, 23).

Рекомендация. Дайджест дня или недели для родственников — фиксированные поля из **проверенной** сводки смены (что уже записано и сверено), не свободный рассказ модели. Во внешний сервис уходит обезличенный текст (правила 9.2); готовый текст утверждает человек до отправки семье. Чат-бот «обучения родственников уходу» и чат-бот, который «сам отвечает родным вместо смены», —

не этот сценарий (раздел 18). Подсветка дыр — после того как журналы уже электронные (квартал 2): иначе модель подсветит пустоту бумаги.

10. Правовая рамка: шесть опор и запретная зона

10.1. Шесть опор, на которых стоит законное внедрение

152-ФЗ «О персональных данных»¹ — базовый закон. Обработка данных жителей и сотрудников допускается на законных основаниях (договор о соцобслуживании, трудовые отношения, согласие); любая новая обработка — новая цель — требует оценки правомерности. **Специальные категории** (здоровье) и **биометрия** (лица) — под усиленным режимом: в общем случае требуется письменное согласие, а биометрия коммерческими и иными системами идентификации — с учётом 572-ФЗ о единой биометрической системе⁵. **Ст. 16 152-ФЗ** прямо запрещает принимать решения, порождающие юридические последствия для человека, **исключительно** на основании автоматизированной обработки его данных² — законодательное закрепление принципа «человек в контуре». **Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года** (указ Президента № 490)⁴ — программная рамка: она не регулирует учреждение, но определяет ожидания учредителей. **Локальные акты учреждения** — приказы и положения, которые превращают федеральные рамки в рабочие процедуры: регламент ИИ, положение о видеонаблюдении, приказ о пилоте. **Договор с вендором** — обязательный шестой элемент: без корректных пунктов о данных (раздел 17.5) самая безупречная внутренняя документация не защищает.

10.2. Ключевая развилка: биометрия или события

Самое дорогое правовое решение проекта принимается не юристом, а инженером — в техническом задании. Видеоаналитика бывает двух сортов. Первая распознаёт **события**: «человек упал», «кто-то пересёк линию», «скопление людей» — без установления, кто именно это сделал. Вторая распознаёт **лица**: система знает, кто перед камерой, — и это биометрические персональные данные со всем усиленным режимом: письменные согласия каждого жителя и сотрудника, требования к хранению, в перспективе — контур 572-ФЗ о единой биометрической системе⁵. Для задач дома социального обслуживания — падение, уход из зоны, ночное беспокойство — идентификация личности **не нужна**: дежурному важно, что событие произошло в коридоре третьего этажа, а личность он установит за секунды глазами. Поэтому доклад фиксирует правило: в техническом задании пишется «распознавание событий без идентификации личности»; вендор, который «не может без лиц», предлагает решение чужой задачи. Эта единственная

формулировка снимает самый тяжёлый правовой контур, согласия на биометрию и максимальные штрафные риски³.

10.3. Согласия: когда нужны и какие

Три ситуации, три режима. **Документы (направление А):** согласия не требуются — требуется обезличивание; согласие не заменяет обезличивание, потому что согласие на передачу данных внешнему сервису учреждение вправе не запрашивать вовсе, а запрещённый регламентом сценарий не легализуется никакой подписью. **Видеонаблюдение в общих помещениях:** индивидуальные согласия в общем случае не нужны (обработка на основании договора о соцобслуживании и трудовых отношений для целей безопасности), но обязательны положение и уведомления (приложения 6, 8); ваш юрист подтверждает контур для конкретного случая. **Датчики в комнате жителя (направление В):** нужно письменное согласие жителя — а при когнитивных нарушениях, препятствующих пониманию, законного представителя с учётом желания самого жителя (разделы 18.2, 20.3). Согласие всегда отзываемо, и отзыв исполняется немедленно.

10.3а. Языковые модели и 152-ФЗ: три рабочих контура

Факт. Если в языковую модель попадают сведения, по которым можно узнать жителя, это обработка персональных данных по 152-ФЗ — со всеми основаниями, целями и поручением обработчику. Публичные зарубежные API, как правило, не принимают поручение оператора в смысле российского закона. Три рабочих пути: российское облако с договором поручения; своё железо (открытые модели на площадке учреждения или учредителя); обезличивание текста до отправки — так, чтобы по оставшемуся нельзя было узнать человека²⁶. Вставка идентифицирующих сведений в зарубежный чат-бот — ещё и трансграничная передача: после факта отправки локализация уже не спасает³¹.

Рекомендация. Обезличивание — режим по умолчанию даже для российских моделей: согласие его не заменяет (раздел 10.3), а «свой» контур не отменяет журнала инцидентов. Если сотрудник пользуется публичным API из утверждённого списка (раздел 9.2), в настройках сервиса отключаются сохранение запросов и обучение на ваших текстах. Ранняя развёрнутая схема той же развилки (поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat или зарубежный API) дополняет источник²⁶ без смены контуров³⁴. Маскирование чувствительных полей до чата и прокси-фильтр персональных данных — техническая опора режима «обезличивание по

умолчанию», а не его замена: если сотрудник вставил фамилию «для качества», контур уже нарушен³⁹⁴⁰.

10.4. Экспериментальные правовые режимы и «песочницы»

Законодательство об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций позволяет отраслям тестировать технологии в особом регуляторном контуре — так работает московский эксперимент по компьютерному зрению в медицине⁸. Для типового учреждения соцобслуживания это фон, а не инструмент: своих «песочниц» у нас нет, и работаем мы в обычном режиме 152-ФЗ. Вывод практический: не позволяйте вендору аргументировать продажу «экспериментальными режимами» — то, что законно в московском медицинском эксперименте при его инфраструктуре и этических комитетах, не переносится автоматически на интернат в вашем регионе.

10.5. Пять вопросов юристу — до старта, а не после жалобы

Перед запуском любого направления, кроме обезличенных документов, юрист (свой или учредителя) получает пять вопросов письменно и отвечает письменно: (1) какое правовое основание обработки в нашем случае и достаточно ли его; (2) требуются ли согласия и в какой форме — пришлите проект; (3) нужно ли актуализировать уведомление Роскомнадзора (раздел 17.4); (4) соответствует ли договор с вендором чек-листу (приложение 5); (5) какие риски вы видите в нашем описании проекта. Письменное заключение — не формальность: при проверке оно показывает, что учреждение действовало добросовестно; а отрицательное заключение — легитимная точка остановки (раздел 25.4), а не «препятствие, которое надо обойти».

10.6. Что спросит надзор: восемь вопросов и где лежат ответы

Проверка (плановая или по жалобе родственника) задаст предсказуемые вопросы; ответы на все должны доставаться за пять минут. (1) «Какие системы обрабатывают персональные данные проживающих?» — реестр систем (раздел 17.2). (2) «На каком основании?» — договор о соцобслуживании, согласия (приложение 6), приказы. (3) «Кто имеет доступ к записям?» — положение + журнал доступа (приложения 8, 12.2). (4) «Где хранятся данные и как долго?» — реестр, договор с вендором, сроки из положений. (5) «Были ли инциденты и что вы сделали?» — журнал инцидентов (приложение 12.1) с разборами; отсутствие журнала подозрительнее записей в нём. (6) «Уведомляли ли Роскомнадзора?» — отметка в реестре; при инциденте — подтверждение уведомления за 24 часа³. (7) «Используете ли биометрию?» — «нет,

событийная аналитика» плюс формулировка из техзадания (раздел 10.2). (8) «Кто ответственный?» — приказ о назначении и подменяющий. Учреждение, отвечающее на восемь вопросов документами, а не словами, превращает проверку из угрозы в процедуру.

Правовая развилка: события или личности

Путь доклада: события

Система распознаёт «человек упал», «кто-то пересёк линию» — **без установления, кто именно.**

Это обычные персональные данные изображения толпы/фигур в общих помещениях: стандартный контур 152-ФЗ — положение, уведомления, журнал доступа, сроки хранения.

Задачи направления Б закрываются полностью.

Путь, который мы не выбираем: идентификация

Распознавание лиц: система знает, **кто** перед камерой.

Это биометрические персональные данные: усиленный режим 152-ФЗ, письменные согласия, требования 572-ФЗ о единой биометрической системе, максимальные штрафы за утечку³⁵.

Добавленной пользы для наших задач — ноль.

Развилка проходит в техническом задании, а не в договоре: формулировка «распознавание событий без идентификации личности» проверяется на пилоте — попросите вендора показать, что система не строит и не хранит цифровые слепки лиц (разделы 10.2, 17.5).

11. Направление Б. Видеоаналитика безопасности: падения и уход из зоны

11.1. Что это

Система анализирует видеопоток с камер и распознаёт события: человек упал и не поднимается; человек пересёк линию (выход из отделения, из здания); человек неподвижен необычно долго; скопление людей. Сигнал приходит дежурному — на монитор, планшет или рацию. Ключевое требование для нашего профиля: распознавание **событий, а не лиц** (правовая развилка — раздел 10.2). Это единственное направление с прямым отношением к жизни и здоровью: падение, обнаруженное через час, и падение, обнаруженное через минуту, — разные исходы.

11.2. Что подтверждено и что нет

В медицинских стационарах и учреждениях ухода за рубежом видеоаналитика и датчики падений показывали снижение времени обнаружения падения и, в ряде исследований, частоты тяжёлых последствий; в России работающие серийные решения есть в больницах и отдельных домах престарелых. Подтверждённых публикаций об измеренном эффекте именно в домах социального обслуживания и ПНИ нет — данных нет; международные обзоры эту пустоту не закрывают: доказательная база слабая и там⁴⁹⁵⁰. Профиль наших жителей (дезориентация, нарушения поведения, тяжёлая терапия) отличается, и эффект надо мерить самим. Второй подтверждённый факт — не про ИИ, а про людей: при высокой доле ложных тревог персонал перестаёт реагировать в течение нескольких недель. Технология, которая кричит «волк» десять раз в день, не повышает безопасность — она её снижает.

11.3. Пилот: конструкция

Пилот — на одном отделении с самым высоким риском падений, на 90 дней, с четырьмя заранее записанными метриками: число реальных событий, обнаруженных системой; число событий, пропущенных системой (по журналу смены); доля ложных тревог; время от сигнала до прихода сотрудника. К ним — три рабочие метрики смены, которые считает старшая, а не вендор: тревог на смену (alerts-per-shift), доля проигнорированных сигналов, медиана времени до рук у жителя (time-to-hands-on). До старта — замер базовой линии за месяц по тем же отделениям: сколько падений, как обнаруживались, за какое время. Без базовой

линии пилот превращается в впечатления. Критерии исхода записываются заранее (раздел 25): например, «ложных тревог больше пяти на отделение в день после четырёх недель настройки — пилот останавливается или перенастраивается». Паспорт пилота — приложение 7.

11.4. Правовой и человеческий контур

До включения камер: положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (приложение 8), уведомления жителям и представителям, инструктаж смен — что означает сигнал, кто и как реагирует, куда пишется результат. Камеры в комнатах жителей — отдельное решение с отдельным юридическим заключением; рабочий минимум — коридоры, холлы, выходы, лестницы. Сигнал системы — повод бежать к жителю, а не повод делать выводы; любое событие завершается записью человека в журнал, а не строкой в логе системы.

11.5. Деньги

Ориентировочная структура расходов (иллюстративная модель, пересчитать под своё здание): камеры и сервер либо подписка на облачную аналитику — основная статья; настройка и обучение — вторая; поддержка — регулярная. При облачной схеме критично: где обрабатывается видео, хранится ли оно у вендора, кто имеет доступ (чек-лист договора — приложение 5). Локальная схема дороже на старте, но снимает большинство вопросов о данных. Реалистичный порядок для отделения на 20–30 жителей — сотни тысяч рублей в первый год по любой схеме; решение принимается после пилота, на его числах, а не на презентации вендора.

11.6. Десять вопросов к вендору видеоаналитики

На демонстрации все системы выглядят одинаково убедительно; различия вскрываются вопросами. (1) Покажите распознавание падения на записи, где человек просто лёг отдохнуть на пол в гимнастическом зале, — сколько ложных тревог? (2) Как система ведёт себя в сумерках и ночью при дежурном свете? (3) Строит ли система цифровые слепки лиц и хранит ли их — покажите в интерфейсе, а не в письме. (4) Что происходит при пропадании интернета: локальный контур продолжает работать или тревоги молчат? (5) Как настраиваются зоны и пороги — вендором за отдельную плату или нами из интерфейса? (6) Какие метрики качества выдаёт система сама: долю ложных тревог вы сможете взять из неё или будете считать вручную? (7) Сколько учреждений нашего профиля используют систему больше года — дайте два контакта, мы позвоним. (8) Что входит в подписку, а что оплачивается отдельно: обновления модели, поддержка, замена камеры? (9) Как

выглядит выход: выгрузка событий и записей в открытом формате, акт об удалении данных? (10) Кто отвечает за ложное срабатывание, пропустившее падение, — и где это в договоре? Вендор, у которого готовы ответы на все десять, скорее всего, реально работал со стационарами; вендор, отвечающий «это технические детали», — нет.

11.7. Privacy-by-design и «падение со саундтреком»

Факт. Детекция падений возможна по силуэту, пикселизации или радару; сырое видео можно не хранить (схема AUGi / medRxiv — по описанию производителя)⁵².

Рекомендация. Вендору на демонстрации — не «есть ли камера», а «какой минимальный сенсор закрывает событие»: радар и обфускация предпочтительнее постоянного видео.

Интерпретация (язык практики, не рецензия). В обсуждениях медсестёр и семей (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving) камера без ответа смены называется «падением со саундтреком»: событие видно и слышно, помощи нет⁵³. Это операционный тезис для матрицы эскалации (раздел 19), а не научное доказательство.

12. Направление В. Наблюдение за состоянием: датчики и ранние сигналы

12.1. Что это

Класс решений, отслеживающих отклонения в повседневном состоянии жителя без медицинского вмешательства: датчики активности и сна (подматрасные, носимые), датчики открытия двери и посещения санузла, весы с автоматической записью, кнопки тревоги нового поколения. Модель строит индивидуальную «норму» жителя и сигнализирует об отклонении: спал ли, ел ли, выходил ли, не упал ли вес, не изменилась ли ночная активность (частый предвестник ухудшения). Это мягкая форма наблюдения, которая ловит то, что смена физически не может заметить у тридцати человек одновременно.

12.2. Граница с медициной — абсолютная

Сигнал датчика — не диагноз и не медицинское наблюдение. Всё, что делает система, — говорит смене и врачу «посмотрите на этого человека внимательнее». Интерпретация, осмотр, решение — только врач, по правилу, которое уже звучало в докладе о питании и здесь становится ещё жёстче: организационные решения принимает директор, клинические — врач. Любое вендорское предложение «система сама оценит состояние» отклоняется; любое внедрение датчиков без участия врача в проектировании порогов и маршрутов эскалации — ошибка. Тот же контур — для моделей недоедания: больничные AUC не переносятся в дом как диагноз; если сигнал появится — человек проводит скрининг, камера и урна диагноз не ставят (раздел 4.3)⁶²⁶³. Форма маршрута: сигнал → смена → запись в журнал наблюдений → врач при повторении или выраженности (приложение 9).

12.3. Что подтверждено

В зарубежных учреждениях ухода системы раннего выявления ухудшений показали сокращение госпитализаций и более раннее выявление инфекций и декомпенсаций; данные по российским соцучреждениям отсутствуют. Практически подтверждённый и у нас эффект — не предсказание, а документация: автоматическая запись сна, активности и веса снимает со смены часть журнальной работы и даёт врачу объективную динамику вместо «вроде стал хуже». Первый сценарий внедрения, который доклад рекомендует, — именно это: датчики веса и сна для ограниченной группы жителей по списку врача, как продолжение клинических минимумов из доклада о питании (вес и его триггеры).

12.4. Этика и приватность

Датчики в комнате — вопрос достоинства не меньше, чем медицины. Правила: житель и представитель информированы и согласны (форма — приложение б); данные — об активности, не о содержании жизни (датчик движения — да, микрофон и камера в комнате — нет без отдельного заключения); доступ к данным ограничен врачом, сменой и ответственным; житель может отказаться без последствий для ухода. Отказ от датчика — такое же право, как отказ от блюда: фиксируется и уважается.

12.5. С чего начать

Стартовый пакет, не требующий «умной» инфраструктуры: весы с автоматической передачей в простую таблицу + подматрасный датчик сна для 5–10 жителей по списку врача + еженедельный разбор сигналов на совете директора с врачом. Три месяца — и у учреждения есть собственные ответы: ловит ли это отклонения раньше жалобы, сколько сигналов ложных, сколько времени смены это стоит. Только после этого — разговор о масштабировании и о моделях риска.

12.6. Как говорить с жителем о датчике: три сценария беседы

Провал подключения чаще происходит в разговоре, а не в технике. **Сценарий «неправильный»:** «Вам поставят прибор, чтобы за вами следили, — распишитесь здесь». Всё в нём ошибочно: «следили» вместо «помогали», «поставят» без выбора, подпись до понимания. **Сценарий «рабочий»:** «Мария Ивановна, врач предлагает вам попробовать одну вещь: под матрас кладётся тонкий датчик — он не снимает и не слушает, только чувствует, как вы спите. Если ночью что-то пойдёт не так, медсестра узнаёт сразу, а не при обходе. Попробуете месяц? Не понравится — скажете любому из нас, уберём в тот же день, и это никак не изменит уход за вами». Здесь есть всё: кто предлагает (врач), что делает и чего не делает устройство, выгода для жителя, срок, свободный отказ. **Сценарий «для сомневающегося»:** не уговаривать, а предложить посмотреть: «Давайте я покажу, как это выглядит у Лидии Петровны — она пользуется второй месяц, расскажет сама». Свидетельство жителя для жителя сильнее любых слов персонала; заранее договоритесь с двумя-тремя жителями, готовыми так рассказать, — это часть дизайна пилота.

Маршрут эскалации тревожного события

Степень	Срок	Что происходит
0. Сигнал	—	Датчик передаёт сигнал на панель поста: нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью. Время сигнала фиксируется автоматически.
1. Проверка	0–5 минут	Медсестра или сиделка поста лично оценивает обстановку в комнате. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки.
2. Старшая смены	5–15 минут	При неясной ситуации — старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач. Формат сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.
3. Врач	немедленно — 30 минут	Осмотр жителя, решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).
4. Семья и документы	до 24 часов	Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция — в статистику пилота (приложение 7).

Еженедельно

Ответственный и врач разбирают все сигналы: доля ложных, время по ступеням, перенастройка.

Ежемесячно

Свод в паспорт пилота (приложение 7): метрики против критериев исхода.

Граница системы

Датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Схема печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте. Полный текст маршрута — приложение 9.

13. Направление Г. Голосовые помощники и умные устройства для жителей

13.1. Что это

Умные колонки и дисплеи (с голосовыми помощниками российских экосистем) в жилых и общих зонах: напоминания о приёме лекарств и распорядке, радио и музыка по запросу, связь с родственниками, ответы на вопросы, простые игры и тренировки памяти, управление светом или телевизором голосом для маломобильных жителей. Устройство стоит немного, требует только розетку и Wi-Fi — и потому соблазнительно для «быстрого внедрения». Именно поэтому здесь больше всего необдуманных решений.

13.2. Что подтверждено

Исследования в учреждениях ухода показывают умеренный положительный эффект голосовых помощников на одиночество, настроение и самостоятельность пожилых — в малых выборках и на горизонте нескольких месяцев; устойчивость эффекта не подтверждена. Подтверждён также риск разочарования: помощник, который «не понимает» речь жителя с дизартрией или не держит контекст, быстро забрасывается. Эффект зависит не от устройства, а от сопровождения: кто-то должен настроить сценарии под конкретного жителя и поддерживать первые недели. Российских измеренных данных по нашим учреждениям — нет.

13.3. Принципы внедрения

Четыре принципа. **Добровольность:** колонка появляется у жителя, который хочет её, и уходит по первому требованию. **Индивидуальная настройка:** сценарии под человека — его распорядок, его музыка, имена его родственников; настройку ведёт назначенный сотрудник (социальный работник или психолог). **Приватность:** устройство с микрофоном в жилой комнате требует информирования соседей по комнате и правила «колонка не в санузле, не в процедурной»; журналы запросов не анализируются без необходимости. **Реалистичность:** жителям и родственникам честно объясняют, что это — устройство с ограничениями, а не «электронный компаньон».

13.4. Рабочие сценарии

Пять сценариев с наилучшим соотношением пользы и риска: напоминания (лекарства по графику врача, прогулка, день рождения внука); аудиоконтент (радио, книги, музыка — для жителей со слабым зрением это часто главный канал к культуре); связь (видеозвонки родственникам через умный дисплей по расписанию); голосовое управление (свет, телевизор — самостоятельность маломобильных); когнитивные игры (викторины, «вспомни год» — как дополнение к занятиям, не замена). Сценарий «свободный разговор с ИИ» для жителей с психическими нарушениями требует оценки врача: для части жителей неограниченный диалог с моделью нежелателен.

13.5. Пилот и метрики

Пилот: 5–10 устройств у добровольцев, 60 дней. Метрики: доля жителей, пользующихся устройством ежедневно к концу пилота (честный порог успеха — больше половины); частота использованных сценариев (журнал устройства); субъективная оценка жителя и смены; число инцидентов приватности. Затраты — десятки тысяч рублей на весь пилот; решение о расширении — по метрикам, а не по энтузиазму первой недели, когда устройством пользуются все от новизны.

13.5. Настройка под конкретного жителя: чек-лист первой недели

Колонка, вынутая из коробки и включённая «как есть», разочарует за три дня. Рабочая неделя выглядит так. **День 1:** устройство ставится в выбранном жителем месте, громкость и скорость речи подбираются под слух (проверка: житель повторяет три услышанные фразы), язык обращения — «ты» или «вы» — по желанию жителя. **День 2:** настраиваются два-три личных сценария, а не все подряд: любимое радио, напоминание о прогулке, подкаст или чтение книги. **День 3–4:** житель пробует сам, сотрудник рядом, но не командует; записывается, какие команды не распознаются (речь, диалект, тихий голос) — команды переформулируются и записываются на карточку устройства. **День 5:** житель показывает соседу или родственнику — публичное «у меня получается» закрепляет навык. **Конец недели:** решение жителя — оставить или вернуть; возврат без вопросов. Три запрета первой недели: не подключать функции, требующие личных данных и подписок на имя жителя, без отдельного разговора с семьёй; не оставлять включённым микрофон «на всякий случай» в режиме записи разговоров в комнате (приватность — раздел 13.2); не превращать колонку в громкоговоритель распоряжений — напоминания от учреждения только по согласованному списку.

13.6. Границы разрешений «ассистента по умолчанию»

Факт. «Ассистент по умолчанию» на смартфоне — не полный доступ к устройству: контекст экрана он получает только после явного вызова пользователем, а микрофон, камера и контакты оформляются отдельными согласиями³⁰. Для дома это рабочий ориентир в двух бытовых сценариях — смартфон жителя или родственника и личные телефоны сотрудников (BYOD): в правилах размещения устройств и в разговоре с семьёй стоит проговаривать, что помощник отвечает на вызов, а не слушает комнату постоянно.

13.7. Где голос ломается: выдумка и 152-ФЗ

Факт. Голосовой агент со свободным разговором способен уверенно врать собеседнику; лечится это замкнутым сценарием и запретом на свободные обещания, а не более строгим промптом⁴⁵. Голос — запись речи и разрешения микрофона: контур 152-ФЗ тот же, что для любой обработки персональных данных⁴⁶.

Рекомендация. Колонка в комнате жителя не ведёт свободных переговоров о лечении, деньгах и правах — сценарии раздела 13.4 остаются замкнутыми. Журналы запросов не уходят во внешнюю модель и не разбираются «из любопытства» (раздел 13.3).

13.8. Реминисценция и персональная музыка — мягкий слой, не сиделка

Факт. В языке практики LTC News (не рецензия) среди инструментов домов ухода называют персонализированную музыку и реминисцентные подсказки — и тут же оговаривают: ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие человека⁵⁸. Рамка 4Ms ставит голосовых помощников и музыку в ряд когнитивной поддержки при сохранении достоинства, а не вместо персонала⁵⁹. Обзоры музыки при деменции описывают нефармакологическую поддержку настроения и поведения — это не лицензия обещать лечение⁶⁷. Прагматическое кластерное испытание персональной музыки в 54 домах ухода (976 жителей): возбуждение и психотропные препараты значимо **не** снизились⁶⁸.

Интерпретация. Это расширение направления Г, а не «лечение возбуждения плейлистом» и не «направление робот-компаньон». Плейлист «её песни 1960-х» и мягкий вопрос «помните этот двор?» работают только по согласию и только если рядом есть сотрудник, который видит реакцию и может выключить устройство.

Рекомендация. Только добровольно: согласие на плейлист и подсказки, отказ — без потери занятий и внимания смены. Не обещать семье, что музыка «снизит возбуждение» или заменит визит и разговор. Не подключать биометрию «чтобы узнать настроение по лицу» (разделы 18, 20, 23).

14. Направление Д. Обучение персонала: ИИ-тренажёры сложных ситуаций

14.1. Проблема, которую решаем

Новый сотрудник учреждения учится работать с тяжёлыми ситуациями — отказ от еды, агитация, конфликт между жителями, разговор с тревожным родственником — на живых людях. Ошибки этого обучения стоят дорого: и жителю, и сотруднику, который выгорает в первые месяцы. Классическое решение — наставничество, и оно незаменимо; но наставник не может проиграть с новичком тридцать вариантов одного диалога. Искусственный интеллект может: языковая модель играет роль жителя или родственника в тренажёре, сотрудник отвечает, тренер разбирает.

14.2. Как это устроено

Тренажёр — не продукт, который надо покупать: на первом этапе это набор сценариев, написанных из собственных кейсов учреждения, и инструкция для модели: «Ты — житель отделения милосердия, 74 года, дезориентирован по вечерам. Сотрудник предлагает тебе ужин. Отвечай коротко, по-человечески; если сотрудник говорит уважительно и предлагает выбор — постепенно соглашайся; если давит — упирайся». Сотрудник ведёт диалог, тренер наблюдает, потом разбирают вместе. Такой тренажёр поднимается на любом допущенном регламентом сервисе (раздел 9) за один вечер — без закупок. Серийные ИИ-тренажёры для социальной сферы существуют, но их содержимое далеко от нашей специфики; свои сценарии точнее.

14.3. Сценарная библиотека

Начальный набор — десять сценариев из реальных (обезличенных) ситуаций учреждения: отказ от еды и от лекарств; житель ищет «дом» вечером; конфликт за место в столовой; родственник требует «немедленно положить в больницу»; житель обвиняет сотрудника в краже; отказ от гигиенических процедур; новый житель первой недели; житель, который перестал выходить из комнаты; сообщение о смерти соседа по комнате; разговор о переходе на другое отделение. Каждый сценарий — карточка: роль модели, цель сотрудника, критерии успешного диалога, типовые ошибки (приложение 10). Библиотека пополняется из разборов реальных инцидентов — учреждение учится на собственном опыте, а не на учебнике.

14.4. Границы

Тренажёр учит диалогу, а не отношениям: он не заменяет наставничество, супервизию и психологическую поддержку персонала. Модель играет упрощённого жителя; реальный человек непредсказуем. Поэтому тренажёр — первый слой обучения новичка (до выхода к жителям) и тренировочный снаряд для опытных перед сложными разговорами, но оценка сотрудника по «диалогу с ботом» не проводится никогда — это учебный инструмент, а не аттестация.

14.5. Метрики

Измеряемое: доля новичков, прошедших базовый курс тренажёра до самостоятельной смены; самооценка готовности (опрос до/после); число инцидентов первых трёх месяцев работы новичков год к году (осторожно: малые числа, тренд важнее цифры); отзывы наставников. Не измеряйте «удовлетворённость тренингом» — она не коррелирует с навыком; измеряйте поведение: что сотрудник делает в разборе после тренажёра.

14.5. Полный цикл одного занятия с тренажёром (40 минут)

Чтобы тренажёр не превратился в «компьютерную игру для галочки», занятие имеет жёсткую структуру. **Минуты 0–5:** наставник задаёт сценарий (из приложения 10) и правила: «сегодня — жительница, которая обвиняет вас в краже очков; цель — не оправдаться, а помочь и зафиксировать». **Минуты 5–15:** сотрудник ведёт диалог с моделью вслух или письменно; наставник наблюдает и не вмешивается, отмечает два-три момента. **Минуты 15–20:** модель разбирает диалог по критериям сценария — сотрудник читает разбор сам. **Минуты 20–35:** живой разбор с наставником: что модель оценила верно, где она отстала от нашей реальности (например, не знает наших регламентов — и это иллюстрация правила «модель не знает вашего учреждения»), как сотрудник поступил бы вчера в реальной смене. **Минуты 35–40:** одна фраза-вывод записывается сотрудником в личную карту обучения. Следующий диалог по этому же сценарию — через месяц, для закрепления. Цикл показывает ключевое: тренажёр — повод для разговора о нашей работе, а не замена разговора; сорок минут, из которых тридцать — живые, и есть обучение.

15. Направление Е. Управленческая аналитика: от журналов к панели показателей

15.1. Что это и почему последнее в списке

Управленческая аналитика — сведение данных учреждения в живую картину: показатели отделений, динамика инцидентов, нагрузка смен, отходы кухни, жалобы, лекарственные назначения — с выявлением аномалий и трендов. Именно сюда вендоры продают «ИИ-платформы» дороже всего. Доклад ставит направление последним сознательно: аналитика имеет смысл только поверх данных, которые учреждение уже ведёт дисциплинированно. Там, где журналы ведутся «для проверки», ИИ-платформа автоматизирует мусор и выдаст уверенные выводы из него — хуже, чем отсутствие выводов. Сводка отходов кухни — тот же принцип: сначала ведомость, потом агрегированная панель кандидата М; не «диагноз недоедания с урны» (разделы 4.3, 7).

15.2. Честная диагностика исходных данных

Прежде чем говорить об аналитике, ответьте на четыре вопроса по главным журналам (питание, отказы, инциденты, вес, жалобы): ведутся ли они ежедневно, а не задним числом; записи — факты или «всё в порядке»; хранятся ли данные в машиночитаемом виде или в тетрадях; кто отвечает за качество записей. Если хотя бы два ответа отрицательные — первый проект не про ИИ: он про дисциплину данных. Хорошая новость: это тот же фундамент, что и в докладе о питании (ведомость остатков, журнал отказов, квартальная панель) — учреждение, прошедшее пилот питания, уже имеет рабочий минимум данных.

15.3. Ступени аналитики без «ИИ-платформы»

Первая ступень — таблица: те же журналы переводятся в простую электронную форму (одна таблица на отделение), сводная панель считается формулами — без всякого ИИ. Вторая ступень — правила: пороги, заданные людьми (три отказа подряд, рост жалоб, падение доли выбирающих вариант Б ниже порога), срабатывают автоматически — это уже «сигнальная система», и она надёжнее модной модели. Третья ступень — помощь генеративного ИИ в чтении данных: свести квартальные таблицы в текст для учредителя, сформулировать отклонения, подготовить вопросы к цифрам. И только четвёртая — предиктивные модели, когда накоплены годы чистых данных и есть аналитик. Большинству учреждений на

ближайшие два года хватит второй и третьей ступеней — и это правильная экономия.

15.4. Риск решений по плохим данным

Управленческий риск аналитики — не технический, а решительный: директор видит красивую панель и принимает решение по цифре, которая не измеряет то, что он думает. Классика: «число инцидентов выросло» — после того как начали честно записывать; «отделение А лучше отделения Б» — при разном профиле жителей; «система сработала: падений стало меньше» — после того как перестали записывать лёгкие. Правила защиты: каждый показатель имеет паспорт (что измеряет, как собирается, кто отвечает, какие искажения типичны); любой тренд сначала проверяется на изменение практики записи; сравнения между отделениями — только с поправкой на профиль. Форма паспорта показателя — приложение 11.

15.5. С чего начать в понедельник

Выбрать пять показателей, которые уже собираются (по итогам предыдущего пилота или действующих журналов), написать им паспорта, собрать квартальную панель в одной таблице и один раз в квартал разбирать её на совете директора. Через два квартала добавить пороговые сигналы. Через год — решать, нужна ли платформа, имея на руках данные, которым вы верите. Так аналитика строится снизу вверх — и любой вендор, приходящий с «ИИ-платформой», встречает директора, который знает свои числа лучше его.

15.5. Заполненный пример: паспорт показателя «время обнаружения падения»

Форма приложения 11 становится рабочей на примере. **Название:** Среднее время обнаружения падения, минуты. **Определение:** интервал от момента падения (по записи камеры или показаниям жителя) до момента, когда сотрудник вошёл в помещение; считается по всем зафиксированным падениям. **Формула:** сумма интервалов / число падений за квартал; единицы — минуты. **Источник:** журнал событий (время обнаружения) + время падения по видеозаписи или расспросу; вносит старшая смены в день события. **Ответственный за качество:** ответственный за цифровые проекты; проверка — выборочный аудит двух событий в месяц. **Известные искажения:** падения вне зон камер датируются приблизительно; падения без свидетелей могут не попасть в журнал — показатель

занижен, и это признаётся в отчёте. **Порог реакции:** любое событие дольше 10 минут разбирается отдельно; рост среднего два квартала подряд — повод для решения о видеопилоте. **Связанные решения:** запуск/расширение видеоаналитики, изменение графика ночных обходов. Показатель с таким паспортом выдерживает вопросы учредителя; показатель без паспорта — рисунок.

★ Часть III

Внедрение

Дорожная карта на двенадцать месяцев, правовой контур
пошагово, работа с жителями и персоналом, этика, безопасность
данных и экономика. Разделы 16–22.

16. Дорожная карта на 12 месяцев: четыре квартала, четыре ступени

16.1. Логика карты

Карта повторяет логику, доказавшую себя в вариативном питании: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждый квартал закрывает одну ступень и готовит следующую; каждая ступень имеет точку, в которой можно честно остановиться — и это будет результат, а не провал. Карта рассчитана на типовое учреждение без ИТ-специалиста в штате; сроки ориентировочные и сдвигаются вправо без катастрофы.

Параллель из регулируемой отрасли подтверждает ту же логику. **Факт.** В фармацевтических пилотах ИИ оставляют человека в контуре решения и фиксируют экономию времени на рутинных операциях — без изъятия решения у специалиста²⁹. Тот же язык чек-листа даёт методичка Банка России № 3-МР: категории риска и обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов — переносимо, без превращения дома в банк⁴⁸. Тот же язык oversight — доверие, данные, надзор — у OECD в докладе о масштабировании ИИ в здравоохранении: чеклист контроля, а не разовая закупка⁵¹. **Интерпретация.** Для двенадцатимесячной карты это означает то же, что и для питания: сначала регламент и обучение, затем замер, и только потом расширение; ускорение черновика не заменяет врача, старшую смены и директора.

16.2. Квартал 1. Фундамент и документы

Приказ о порядке использования генеративного ИИ (регламент, приложение 3); назначение ответственного за цифровые проекты и его подменяющего; список допущенных сервисов; первые пять сценариев из библиотеки промптов; обучение трёх-четырёх офисных сотрудников; журнал инцидентов. Замер: время на типовые документы до/после, инциденты обезличивания. Результат квартала: документная работа ускорена, правовой контур существует. Стоимость: нулевая или минимальная. Юридическое заключение — по вопросам из раздела 10.5, параллельно. Смежный ориентир — клинический пайплайн с обезличиванием персональных данных до модели⁴⁷: для квартала 1 важен не «медицинский ИИ», а та же привычка снимать ФИО и диагнозы до любого внешнего контура.

16.3. Квартал 2. Обучение персонала и дисциплина данных

Запуск ИИ-тренажёра для новичков (десять сценариев из своих кейсов); перевод трёх-пяти ключевых журналов в электронные таблицы; паспорта показателей; первая квартальная панель. Замер: доля новичков, прошедших тренажёр; качество записей (аудит выборки журналов). Результат квартала: новички учатся не на жителях; у учреждения появляются данные, которым можно верить. Стоимость: время тренера и ответственного.

16.4. Квартал 3. Пилот наблюдения (врач в контуре)

По решению совета директора с врачом — пилот направления В: датчики веса и сна для 5–10 жителей по списку врача, маршруты эскалации, информирование и согласия. Параллельно — подготовка пилота видеоаналитики (положение, уведомления, выбор отделения, конкурсная документация), если кварталы 1–2 закрыты. Замер: сигналы, ложные срабатывания, время смены, мнение врача. Результат квартала: первые собственные данные о наблюдении; документный пакет для видеопилота готов. Решение о видеопилоте принимается по итогам квартала, не раньше.

16.5. Квартал 4. Видеопилот и годовой отчёт

Пилот видеоаналитики на одном отделении (90 дней, паспорт пилота, критерии исхода — приложение 7); по завершении — разбор на совете с врачом и юристом: закрепить, перенастроить, расширить или закрыть. Годовой отчёт учредителю: что внедрено, что измерено, какие решения приняты и почему, план на следующий год. Этот отчёт — главный документ года: он переводит тему из «модной» в «управляемую» и защищает учреждение от навязанных сверху решений: у вас есть своя дорожная карта с числами.

16.6. Чего в карте нет

Нет платформ «под ключ», штатных программистов, биометрии, предиктивных моделей и закупок в первом квартале. Нет американского биллинга, реферала и MDS/PDPM — это не ступень карты, а чужая платёжная модель (разделы 4.2, 23). Нет автономной лечебной диеты и «диагноза недоедания с камеры» — кандидат М садится на журналы питания, не вместо них (раздел 4.3). Нет автолечения раны и закупки матраса/пластыря как первого шага — кандидат Н садится на график поворотов, не вместо него (раздел 4.4). Всё перечисленное появляется позже — или не появляется вовсе, если замеры покажут, что задача закрыта проще. Дорожная

карта — не обязательство купить всё перечисленное, а порядок, в котором учреждение учится принимать решения о технологиях на своих данных.

Факт. Европейский обзор цифровых технологий здорового старения (DHT: носимые датчики, ИИ, роботы, VR) фиксирует потенциал при хронических состояниях, мобильности, когнитивном снижении и одиночестве — и одновременно барьеры масштаба: дизайн под пользователя, полевая валидация, цифровая включённость, этика и регуляторика, оплата, модели доставки помощи. Шесть приоритетов обзора — про то, почему пилот не становится сетью, а не про закупку «под ключ»⁷⁹.

Интерпретация. Пилот в одном отделении не есть европейский «цифровой здоровый возраст». Карта этого раздела остаётся: замер → закрепление; чужой обзор — гипотеза, не разрешение масштабировать.

16.7. Риски карты по кварталам — и что с ними делать

У каждого квартала есть свой типовой провал, и он известен заранее. **Квартал 1:** регламент издан, но не читан — признак: журнал инцидентов пуст, потому что «инцидентов нет», а не потому что «не сообщают»; действие: один разбор реального (обезличенного) случая на планёрке показывает, зачем журнал. **Квартал 2:** дисциплина данных умирает на третьей неделе — таблицы перестают заполняться; действие: паспорта показателей с именем ответственного и выборочный аудит (приложение 11), иначе через квартал у вас снова «журналы как получится». **Квартал 3:** врач перегружен сигналами — маршрут эскалации оказался написан для идеального мира; действие: пересмотр ступеней с врачом (приложение 9), сокращение списка жителей пилота — меньше, но работает. **Квартал 4:** видеопилот начинается без завершённых кварталов 1–2 — соблазн «успеть в этом году»; действие: правило карты — ступень не начинается, пока предыдущая не замерена; перенос видеопилота на следующий год — штатная ситуация, а не срыв. Общий предохранитель один: квартальный разбор на совете с врачом по заранее написанным метрикам — он же и есть механизм, который не даёт карте стать декорацией.

16.8. Куда на карте садятся кандидаты Ж–Н

Семь строк разделов 4.2–4.4 не открывают «пятый квартал» и не сдвигают видеопилот вперёд документов. Они садятся на уже названные ступени.

Рекомендация. Лекарственная логистика (Ж) и расписание смен (З) — после пилота документов и появления электронных журналов (кварталы 1–2): иначе нечего сверять и не из чего собирать график. Список врача остаётся источником

истины: модель не меняет дозу, не назначает и не отменяет лекарство; график утверждает старшая смены, у сотрудника есть право обжаловать черновик. Доказательная база расписания — в основном больничная, не LTC⁵⁴⁵⁵⁵⁶⁵⁷⁶⁵⁶⁶. Реминисценция и персональная музыка (И) — мягкий слой направлений Г/Д, добровольно, без замены персонала и без обещания снизить возбуждение; можно пробовать параллельно голосу, не раньше регламента колонки (разделы 13.8, 18)⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Дайджесты родственникам (К) — только после правил обезличивания квартала 1: фиксированные поля из проверенной сводки, человек утверждает текст до отправки семье (разделы 9.8, 18). Подсветка дыр в журналах (Л) — расширение А и Е на дисциплине записей квартала 2: флаги пропуска/противоречия/просрочки, не автоподпись и не дописывание с датчиков; идея Chart Advisor, не Referral/Billing/MDS⁶⁰⁶⁹. Питание и кухня (М) — после журналов питания (ведомость остатков, журнал отказов): операционный рецептурник и панель отходов, не больничная модель недоедания и не «ИИ назначил диету» (раздел 4.3)⁶¹⁶²⁶³⁶⁴. Целостность кожи (Н) — после живого графика поворотов: фото → подсказка медсестре, не автолечение и не матрас/пластырь как пилот № 1 (раздел 4.4)⁷¹⁷²⁷³⁷⁴.

Интерпретация. Кандидат, который просит закупку раньше своей ступени, — это снова «успеть в этом году». Правило карты то же: ступень не начинается, пока предыдущая не замерена.

Дорожная карта на 12 месяцев

Квартал 1. Фундамент	Квартал 2. Люди и данные	Квартал 3. Наблюдение	Квартал 4. Видеопилот и отчёт
Приказ с регламентом ИИ (прил. 3); ответственный + подменяющий; список допущенных сервисов; 5 промптов (прил. 4); журнал инцидентов; замер времени на документы до/после.	ИИ-тренажёр для новичков (10 сценариев, прил. 10); три-пять журналов — в электронные таблицы; паспорта показателей (прил. 11); первая квартальная панель.	По решению совета с врачом: датчики для 5–10 жителей из списка врача; согласия (прил. 6); маршрут эскалации (прил. 9). Подготовка пакета видеопилота (прил. 5, 8).	Пилот видеоаналитики на одном отделении, 90 дней (паспорт — прил. 7). Разбор: закрепить / перенастроить / закрыть. Годовой отчёт учредителю с замерами.
Стоимость: нулевая или минимальная.	Стоимость: время тренера и ответственного.	Решение о видеопилоте — по итогам квартала.	Тема переведена из «модной» в «управляемую».

Логика карты — как в проекте вариативного питания: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Каждая ступень имеет точку честной остановки — и это результат, а не провал (разделы 16, 25).

17. Правовой контур внедрения: пошагово

Раздел 10 дал правовую рамку — что говорит закон. Этот раздел переводит её в последовательность управленческих действий: кто, что и в каком порядке оформляет, чтобы у учреждения не появилось ни одного «серого» контура. Схема — рекомендация, согласованная с логикой 152-ФЗ и практикой проверок; конкретные формулировки ваш юрист подгонит под учредителя и регион.

17.1. Нулевой шаг: назначить ответственного

До любой закупки и любого пилота приказом назначается ответственный за цифровые проекты (обычно заместитель по АХЧ или завхоз с грамотностью «выше среднего») и его подменяющий. Дальше все документы, согласия, журналы и контакты с вендором сходятся на нём. Опыт внедрений в социальной сфере показывает одно и то же: проекты без персонального ответственного умирают не от технологий, а от «мы думали, этим занимается кто-то другой». Это интерпретация, но она подтверждается почти каждым кейсом части пятой.

17.2. Реестр систем и данных

Первый документ — реестр: какие системы ИИ (и вообще ИТ-системы) работают или планируются, какие данные в каждой обрабатываются, где хранятся, кто оператор, кто имеет доступ. Одна таблица на один-два листа (шаблон — приложение 5, блок «реестр»). Реестр нужен не для отчётности, а чтобы в любой момент ответить на три вопроса проверяющего, родственника или учредителя: что у вас работает, где данные жителей, кто за это отвечает. Без реестра учреждение не знает собственный цифровой контур — а это и есть главный юридический риск.

17.3. Документный комплект по каждому направлению

Для каждого направления из разделов 9–15 существует минимальный комплект, без которого направление не запускается. **Документы (А):** приказ с регламентом (приложение 3), список допущенных сервисов, журнал инцидентов. **Видеоаналитика (Б):** положение о видеонаблюдении (приложение 8), уведомления жителей и персонала (приложение 6), договор с вендором по чек-листу (приложение 5), паспорт пилота (приложение 7). **Наблюдение за состоянием (В):** согласия жителей или законных представителей (приложение 6), маршрут эскалации (приложение 9), приказ о границах ответственности — кто и какие решения принимает по сигналам датчиков. **Голосовые помощники (Г):**

уведомление и добровольное согласие жителя, правила размещения устройств. **Обучение (Д) и аналитика (Е):** при обезличенных данных — решение руководителя; при персональных — те же требования, что к любой обработке персональных данных в учреждении.

17.4. Уведомление Роскомнадзора

Обработка персональных данных требует уведомления уполномоченного органа — для большинства учреждений соцобслуживания уведомление уже подано, но при появлении новых целей обработки (видеоаналитика, датчики состояния) его нужно актуализировать. Это недорогая и быстрая процедура, которую, однако, вспоминают обычно после начала пилота — и тогда она превращается в нарушение. Правило простое: изменился перечень систем или целей — проверь уведомление. Биометрия (распознавание лиц) — отдельная история: как сказано в разделе 10, доклад рекомендует строить системы так, чтобы биометрии не было вовсе.

17.5. Договор с вендором: семь пунктов, которые нельзя вычеркнуть

Чек-лист договора — приложение 5; здесь логика. Первое: данные жителей остаются собственностью учреждения, вендор — только обработчик по поручению. Второе: территория хранения — РФ, серверы названы. Третье: запрет использования данных для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия. Четвёртое: срок и порядок удаления данных после расторжения — с актом уничтожения. Пятое: ответственность за утечку — конкретная, а не «в пределах стоимости договора». Шестое: право аудита — учреждение может проверить, где и как хранятся его данные. Седьмое: условия выхода — выгрузка данных в открытом формате, а не «навсегда в нашей платформе». Вендор, отказывающийся от любого из семи пунктов, сообщил вам о себе всё необходимое.

17.6. Типовые провалы этого раздела

Три провала повторяются. Первый: «пилот без документов» — камеры уже висят, а положения и уведомлений нет; при любой жалобе родственника учреждение безоружно. Второй: «договор не читали» — через год выясняется, что данные хранятся у вендора, выгрузка платная, а расторжение означает потерю истории. Третий: «ответственный уволился» — вся экспертиза ушла с человеком; поэтому подменяющий и реестр обязательны. Все три провала бесплатны в профилактике и дороги в лечении.

17.7. Годовой цикл документов

Правовой контур — не разовый пакет, а годовой ритм, который полезно повесить в календарь ответственного. **Ежемесячно:** сверка реестра систем с фактом (нет ли «теневых» сервисов), просмотр журнала инцидентов. **Ежеквартально:** пересмотр списка допущенных сервисов ИИ, выборочный аудит доступов. **Раз в полгода:** пересмотр сроков хранения и удаление просроченного. **Ежегодно:** пересмотр согласий (раздел 20.3), инструктаж по безопасности (21.2), актуальность уведомления Роскомнадзора, ревизия договоров по чек-листу. Такой календарь занимает два-три часа в месяц — самая дешёвая страховка: проверяющий и родственник задают одни и те же вопросы, а ответы лежат по датам.

18. Жители и родственники: информирование, согласия, возражения

Технологии в доме социального обслуживания работают не в пустом пространстве, а в чужом доме — потому что для жителя учреждение и есть дом. Это меняет стандарт: недостаточно «не нарушить закон», нужно, чтобы житель и его семья понимали, что происходит, и имели реальную возможность отказаться. Раздел — рекомендация, построенная на правовых требованиях (разделы 10, 17) и на этическом принципе раздела 20.

18.1. Три уровня информирования

Первый уровень — общий: на информационном стенде и в договоре о предоставлении социальных услуг перечислено, какие технологии применяются в учреждении (видеонаблюдение в коридорах, регламент использования ИИ в документах, возможность датчиков). Это не согласие, а прозрачность: никто не должен узнавать о камере случайно. Второй уровень — персональный: перед установкой датчика в комнату или подключением жителя к пилоту — беседа и письменное согласие по форме приложения 6, простым языком, с правом отзыва в любой момент без объяснения причин и без последствий для объёма услуг. Третий уровень — событийный: если система сработала (тревога, падение, эскалация к врачу), житель или представитель узнаёт об этом и о том, какие данные при этом обрабатывались.

18.2. Согласие: как оформлять, чтобы оно было настоящим

Согласие по форме приложения 6 отвечает пяти требованиям: написано языком жителя, а не юриста («датчик под матрасом считает движение и сердцебиение, данные видит медсестра и врач» — а не «обработка физиологических параметров посредством...»); перечисляет конкретные данные и конкретных людей, которые их видят; содержит срок и порядок отзыва; подписывается добровольно — отказ не влечёт никаких минусов; для жителей с когнитивными нарушениями согласие даёт законный представитель, но желание самого жителя выясняется и уважается в пределах его возможностей. Хранится согласие в личном деле; отзыв оформляется заявлением — и датчик отключается в тот же день, а не «после согласования».

18.3. Работа с возражениями

Возражения делятся на три типа, и каждый требует своего ответа. **«За мной следят»** — ответ фактами: что именно видит система, что не видит, кто имеет доступ, где хранится; показать комнату с датчиком и панель медсестры — это снимает большинство страхов. **«Я не хочу»** — принимается без уговоров: право на отказ — часть дизайна системы, а не сбой внедрения; альтернатива (усиленные обходы) прописывается заранее. **Возражение родственника против желания жителя** (или наоборот) — решается в пользу жителя, если он дееспособен; семья получает разъяснение, а не право вето. Конфликтные случаи разбираются на совете с врачом — и документируются: через два года никто не вспомнит, почему датчик у жителя Петровой отключён, а запись в личном деле вспомнит.

18.4. Родственники как союзники

Опыт учреждений, внедрявших наблюдательные технологии, устойчив: когда семью информируют до запуска, родственники становятся главными защитниками проекта — потому что тревога «мама упала, и ей помогли за три минуты» убеждает сильнее любого буклета. Практический приём: один раз в квартал на родительском собрании (или в рассылке) — пять минут о технологиях учреждения: что работает, что измерено, что не внедряем и почему. Это те же слайды, что и для учредителя, — прозрачность в одну сторону почти невозможна.

Структурированный дайджест дня или недели и короткий FAQ («когда звонить», «что уже известно смене») — тот же союзник, что и квартальная рассылка, только чаще. Поля дайджеста берутся из **проверенной** сводки смены, а не из свободного рассказа модели. Это не чат-бот «обучения родственников уходу» и не бот, который «сам отвечает родным»: модель готовит каркас по обезличенным фиксированным полям, человек утверждает тон и факты до отправки, персональные данные не едут во внешний сервис «чтобы текст был живее» (разделы 9.2, 9.8). Семья получает согласованный канал, а не свободный диалог модели о диагнозе.

Факт. Позиционный доклад Eurocarers (июль 2024) называет применение ИИ в неформальном уходе и LTC ещё «эмбриональным»: координация и меньше стресса родственника возможны, но этика — приватность и данные; европейская стратегия ухода прямо говорит, что цифра не заменяет живого контакта. Три стороны — семья, смена, житель — это партнёрство, а не чат-бот вместо визита⁸⁰.

Рекомендация. Кандидат К остаётся проверенными полями; «ИИ научит родственников ухаживать» фильтр раздела 20.4 не проходит.

Реминисценция и персональная музыка для жителя — добровольно, по согласию и без лечебных обещаний: плейлист и мягкая подсказка не заменяют визит родственника, не «лечат возбуждение» и не включаются «всем отделением по приказу» (разделы 13.8, 20)⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Отказ жителя или представителя выключает сценарий в тот же день, без потери остальных занятий.

18.5. Чего не делать

Не устанавливать датчики и камеры «молча», рассчитывая, что никто не заметит, — заметят, и доверие будет потеряно на годы. Не использовать формулировки «для вашей же безопасности» как замену согласию. Не обещать семье «онлайн-доступ к видео из комнаты» — это создаёт круглосуточный надзорный запрос, который учреждение не вправе и не способно выполнять. И не считать подпись под согласием завершением работы: согласие — начало диалога, который продолжается всё время проживания жителя.

Факт. В обсуждениях семей и персонала (r/eldercare, r/AssistedLiving) повторяется срыв: камеру «разрешили» — потом выдернули, потому что сосед, угол обзора, звук или кто выключает не были проговорены заранее⁵³. Это язык практики, не рецензия. **Рекомендация.** Контракт на камеру в двухместной — отдельный разговор с обоими жителями и представителями: сосед (согласие обоих), угол (что в кадре), звук (пишет ли речь), кто выключает и когда. Без этих четырёх пунктов подпись «разрешили» неустойчива.

18.6. Регламент информирования семьи (сводка)

Отдельный продукт этого раздела — регламент информирования семьи, потому что половина конфликтов вокруг технологий вырастает не из самих технологий, а из тишины учреждения. Минимальный регламент из пяти пунктов (готовый одностраничный проект — приложение 13). (1) При поступлении: семья получает лист «Как мы информируем» — что сообщаем сразу (события, врач, госпитализация), что по расписанию (ежемесячный звонок или сообщение), что по запросу. (2) Событийное информирование: при любом срабатывании систем наблюдения — уведомление по форме 6.5 в течение суток; кто звонит (должность) и с какого номера — записано в регламенте, чтобы семья узнавала номер. (3) Плановое: раз в квартал — короткое сообщение о состоянии и делах жителя по согласованному каналу; раз в квартал на собрании/рассылке — пять минут о технологиях учреждения (раздел 18.4). (4) Запросное: ответ семье — не более трёх рабочих дней, с записью в журнале. (5) Эскалация: недовольна ответом — приём у

руководителя в течение недели. Подписанный семьёй при поступлении, он делает прозрачность обоюдной: семья знает, чего ждать, учреждение — что обещало.

19. Работа с персоналом: страхи, сопротивление, обучение

Главный риск внедрения — не техника и не закон, а люди. Персонал, который боится системы, обходит её; персонал, который не понимает систему, отключает её; персонал, которому система помогает, защищает её лучше любого приказа. Все три утверждения — интерпретация, но она подтверждается всей историей внедрения технологий в социальных учреждениях, включая наш проект вариативного питания: там повара и сиделки стали главным ресурсом проекта ровно тогда, когда перестали быть его объектом.

19.1. Чего боится персонал: честный список

Страхов четыре, и все рациональны. Первый: «нас заменят роботами» — особенно у младшего персонала, читающего новости об ИИ. Второй: «за нами будут следить» — видеоаналитика в первую очередь воспринимается как контроль сотрудников, а не безопасность жителей. Третий: «не справлюсь, я не компьютерный» — страх позора перед коллегами и жителями. Четвёртый: «это лишняя работа» — ещё один журнал, ещё одна панель, ещё один пароль. Внедрение, которое не отвечает на все четыре страха явно и публично, встретит сопротивление — тихое, грамотное и непобедимое.

19.2. Ответы, которые работают

На «заменяют» — правдой: ИИ в наших задачах не заменяет уход, он убирает бумажную и сторожевую работу; штат не сокращается, и это решение директора объявляется вслух до запуска. На «следят» — дизайном системы: видеоаналитика настраивается на события (падение, уход из зоны), а не на идентификацию сотрудников; доступ к записям ограничен и журналируется; правило «записи не используются для дисциплинарных взысканий вне ЧС» фиксируется в положении (приложение 8) — и нарушение этого правила директором разрушит проект целиком. На «не справлюсь» — обучением на своих сценариях (раздел 14) и принципом «три кнопки»: если рабочее место требует больше трёх действий, это ошибка внедрения, а не сотрудника. На «лишняя работа» — замером до/после: покажите смене, сколько минут обхода или заполнения журнала система реально экономит; если не экономит — вопрос к проекту, а не к смене.

19.3. Кто внедряет: роли внутри учреждения

Минимальный состав: ответственный за цифровые проекты (раздел 17.1), врач — для всего, что касается состояния жителей, и «первые пользователи» — два-три уважаемых сотрудника из смен, которые пробуют систему первыми и говорят коллегам правду о ней. Первые пользователи подбираются не по компьютерной грамотности, а по авторитету: одобрение старшей сиделки с двадцатилетним стажем стоит больше десяти инструкций. IT-специалист в штате не обязателен: сопровождение — у вендора по договору, но учреждение должно уметь формулировать задачу и проверять результат (чек-лист — приложение 5).

19.4. Обучение: формат, который успевает за смену

Обучение встраивается в существующий ритм: 20–30 минут на планёрке смены, практика на реальном рабочем месте, шпаргалка у монитора. Три правила: учит не вендор «по презентации», а свой первый пользователь; каждый сотрудник сам выполняет действие три раза (увидеть — повторить — сделать); через две недели — повторная мини-сессия по накопившимся ошибкам. Формальное «ознакомлен под подпись» без практики считается отсутствием обучения. Для генеративного ИИ в документах обучение — это регламент (приложение 3) плюс библиотека промптов (приложение 4) плюс один час практики на своих текстах.

19.5. Ложные тревоги и усталость: профилактика

Усталость от тревог — главный технический убийца проектов наблюдения: если система кричит десять раз в смену впустую, на одиннадцатый её игнорируют. Профилактика: порог срабатываний в паспорте пилота (приложение 7) — например, не более двух ложных тревог на устройство в неделю, превышение — повод перенастроить систему, а не пенять смене; еженедельный разбор тревог с сотрудниками, которые на них реагировали, — они знают причины лучше вендора; и честная статистика для коллектива: «сработало правильно 8 раз из 10» — это убедительнее обещаний. Сотрудник, сообщивший о ложной тревоге, благодарится, а не отчитывается: поток сообщений о ложных тревогах — это единственный способ настроить систему.

Интерпретация (обсуждения практиков, не наука). В тредах r/nursing и r/AssistedLiving ИИ без ответа персонала называют «падением со саундтреком»: событие записано, помощь не пришла⁵³. Telesitter и кроватный датчик помогают только если ясно, кто бежит в комнату. **Рекомендация.** До включения — матрица эскалации: remote (кто смотрит панель) и local (кто приходит, за сколько минут, что

если remote не отвечает). Работа и колонку считать в staff-minutes смены (зарядка, сопровождение, разбор сбоев) — иначе «бесплатный штат» съест ночную смену.

19.6. Роль совета учреждения и неформальных лидеров

Внедрение выигрывает или проигрывает не на планёрках, а в курилке и столовой персонала — там, где говорят без директора. Поэтому два инструмента вне линейной структуры. Первый — совет учреждения (директор, врач, старшие смен, специалист по социальной работе, при желании — представитель жителей): все решения о старте, расширении и закрытии пилотов проходят через него и протоколируются. Совет делит вес решения и даёт юридическое прикрытие: «решение совета от такого-то числа». Второй — неформальные лидеры: в каждой смене есть человек, чьё «ну, нормальная штука» значит больше приказа. Их привлекают первыми пользователями (раздел 19.3) и честно спрашивают мнение до запуска. Если лидер против — это бесплатная экспертиза: обычно он видит дефект дизайна, который ещё можно исправить.

19.7. Теневой ИИ и обучение, которое закрепляется

Факт. Пока регламент молчит, персонал несёт рабочие тексты в публичные модели — Shadow AI. Практичная матрица делит задачи на красные (запрещены), зелёные (можно в допущенном контуре) и серые (только с согласованием)³⁷. Команда становится «AI Native» не после разового тренинга, а за четыре этапа — от проб к закреплению в ритме смены³⁸.

Рекомендация. Красные задачи — любые тексты с персональными данными жителей и любые решения о жителях — фиксируются в приказе (приложение 3). Обучение (раздел 19.4) повторяется на своих сценариях; одна подпись «ознакомлен» обучение не закрывает.

19.8. Расписание смен: ИИ как инструмент времени старшей, не судья смены

Факт. В открытых больничных работах график смен собирали оптимизацией по ограничениям (часы, квалификация, предпочтения) и ИИ-черновиком: меньше «нездоровых» стыков, черновик за минуты, правки — у человека. Целочисленная оптимизация описана, в частности, для онкологического отделения — не для дома ухода⁵⁶⁵⁷⁶⁶. Это больничный, почти целиком **не-LTC** тренд, не замер по российским ДСО и не доказательство, что «модель знает потребность в штате».

Интерпретация. Для дома это управленческая, не клиническая задача: закрыть дыру в ночной смене и не нагрузить одну сиделку тремя «тяжёлыми» подряд. Алгоритм не определяет, сколько людей «нужно отделению» — это решение директора и старшей. Алгоритм, который ставит сотрудникам рейтинг дисциплины или «эффективности», в доклад не входит — это запретная зона раздела 20.2.

Рекомендация. Если фильтры раздела 7.3 пройдены, пилот — после электронных журналов и понятных правил учреждения (выходные, ночные, новички рядом с опытными). Старшая смены утверждает график вслух и вправе отменить черновик; у сотрудника есть понятный путь обжаловать смену. Непрозрачный «оптимум», который нельзя объяснить на планёрке, — повод выключить пилот, а не «доверить модели».

20. Этика и достоинство: где проходит граница

Все предыдущие разделы отвечали на вопрос «можем ли мы». Этот — на вопрос «должны ли мы». Юридически допустимое и человечески приемлемое в доме, где живут триста пожилых людей, — не всегда совпадает, и разница между ними — зона ответственности директора, которую не закрывает ни один закон. Раздел целиком — интерпретация и рекомендации; но именно здесь ломается репутация учреждений, которые «всё сделали по закону».

20.1. Четыре принципа

Первый — **принцип дома**: учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения. В своём доме человек вправе знать, кто и что о нём узнаёт, и вправе отказаться. Второй — **принцип человека в контуре**: ни одно решение о жителе не принимается алгоритмом; алгоритм сигнализирует, человек решает. Это не только этика, но и прямое требование закона о персональных данных². Третий — **принцип пропорциональности**: объём наблюдения соответствует реальному риску; датчики в комнате тяжёлого лежачего жителя и в комнате активной жительницы, выходящей на прогулки, — разные задачи, и «подключить всех одинаково» означает избыточный надзор для одних и недостаточный для других. Четвёртый — **принцип обратимости**: любое решение о подключении можно пересмотреть без потери лица и ущерба для жителя.

Практическая шкала того же принципа — HITL, HOTL и HOOTL. **Факт.** HITL (human-in-the-loop) — человек подтверждает действие до исполнения; HOTL (human-on-the-loop) — человек наблюдает и может вмешаться; HOOTL (human-out-of-the-loop) — решение исполняется без возможности отмены человеком²⁷. **Интерпретация.** Полный HOOTL неприемлем для решений, затрагивающих жителя: это прямо расходится со ст. 16 152-ФЗ и со вторым принципом этого раздела. Отрасли с жёстким регулятором, которые оставляют арбитраж человеку, сохраняют и объяснимость решения, и суждение персонала — то, без чего дом социального обслуживания не работает.

Факт. Подпись «human-in-the-loop» часто декоративна: человек видит решение, но не имеет реального права его остановить, а automation bias толкает подтверждать то, что уже «решила» модель³⁵. Смежная область — психологическая помощь — формулирует ту же границу: ИИ как копилот специалиста, не как замена³⁶. **Рекомендация.** Для решений о жителе HITL считается состоявшимся, только если сотрудник может отклонить сигнал без санкции и без обхода интерфейса.

20.2. Границы, которые доклад считает абсолютными

Доклад называет пять практик, которые не рекомендуются независимо от их юридической безупречности. Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия) — коридор да, спальня нет. Распознавание лиц жителей для любых целей — биометрический контур непропорционален задачам учреждения. Скрытое наблюдение — без ведома жителя и персонала, под любым предлогом. Оценка сотрудников алгоритмом (рейтинги, «скоринг дисциплины») — путь к фальсификации поведения и потере доверия. Использование данных жителей для любых целей вне учреждения — исследований, обучения моделей, «обезличенной» передачи партнёрам — без отдельного прозрачного решения совета учреждения.

20.3. Уязвимость жителя как попечителя

Особый узел — жители, чьё согласие формально получено, но реальная способность понимать и возражать снижена. Здесь работают три предохранителя: согласие законного представителя плюс учёт выраженного желания самого жителя (раздел 18.2); периодический пересмотр — согласие не вечно, раз в год врач и специалист по социальной работе подтверждают, что наблюдение по-прежнему в интересах жителя; и правило «в пользу жителя»: любое сомнение в трактовке сигнала, согласия или отказа толкуется в пользу жителя, а не системы. Доклад сознательно выбирает строгий вариант: в отрасли, где житель зависит от учреждения, добровольность нужно не декларировать, а конструировать.

20.4. Этический фильтр для новых предложений

Любое новое предложение — от вендора, учредителя, грантодателя — прогоняется через пять вопросов, и один неправильный ответ останавливает проект до переработки: знает ли житель, что происходит, и может ли отказаться без последствий? Кто-нибудь из живых людей принимает решение по сигналу системы — и успевает ли? Стал бы я спокойно объяснять эту практику семье жителя на собрании? Пропорционален ли объём данных реальной задаче? Что произойдёт с данными и с жителем, когда проект закроется? Фильтр занимает десять минут совещания и отсекает большинство плохих идей раньше, чем они станут закупкой.

Типичные предложения 2026 года этот фильтр уже отвечает заранее. Автоназначение, смена дозы или депрескрайбинг моделью — нет: сверка утверждённого списка, напоминание, штрихкод/идентификация и флаги взаимодействий/PIM идут медсестре; решение остаётся клиническим (кандидат Ж,

раздел 4.2)⁵⁴⁵⁵⁶⁵. Реминисценция и «умный» плейлист — да только как добровольный слой по согласию рядом с персоналом, без обещания снизить возбуждение; робот-сиделка и колонка вместо обхода фильтр не проходят (разделы 13.8, 23)⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Пакет skilled nursing США с Referral Advisor, Billing Advisor и MDS/PDPM — нет для российских ДСО: чужая платёжная логика, даже если в том же прессе удачно названа подсветка дыр в журнале⁶⁰. Автономная лечебная диета, «текстура/аспирация по фото» и диагноз недоедания с камеры или урны — нет: кухня работает утверждённым рецептурником и полями ограничений; модель недоедания, если есть, — только алерт на скрининг человеком (кандидат М, раздел 4.3)⁶¹⁶²⁶³⁶⁴. Автолечение раны и «ИИ закрыл пролежень» — нет: фото → подсказка медсестре, лечение назначает врач; матрас и пластырь — не первый пилот (кандидат Н, раздел 4.4)⁷¹⁷²⁷³⁷⁴. Робот-сиделка — нет: голландские HI-SAR остаются исследованием потенциала, не ставкой вместо обхода (раздел 23.5)⁸¹. Eurocarers добавляет ту же границу для семьи: ИИ в неформальном уходе ещё эмбрионален, цифра не заменяет визит (раздел 18.4)⁸⁰. Европейский ориентир тот же: системы ИИ медицинского назначения относят к высокорисковым и требуют человеческого надзора — это не наш закон, но тот же принцип «человек в контуре»⁷⁰.

20.5. Дилемма для разбора: безопасность против приватности

Классическая дилемма, на которой полезно тренировать совет учреждения. Житель 84 лет, лёгкая дезориентация, дважды уходил с территории — находили на остановке. Врач предлагает датчик на дверь его комнаты ночью. Житель формально согласен, но дочь требует «поставить камеру прямо в комнате, и точка». Разбор по принципам раздела 20.1: принцип дома — камера в комнате вторгается в последнее приватное пространство жителя; пропорциональность — риск реален (уходы были), но датчик двери закрывает тот же риск без видео; человек в контуре — любое решение всё равно принимает смена по сигналу; обратимость — датчик снимается за минуту. Вывод совета: датчик — да, камера — нет; дочери — объяснение через интересы её же матери: запись спальни матери в архиве учреждения — это то, чего дочь, подумав, не захочет сама. Дилемм такого рода в практике десятки, и у них нет ответов в законе: ответы вырабатываются повторяемой процедурой разбора — поэтому доклад настаивает на совете и протоколе, а не на «здравом смысле дежурного руководителя».

20.6. Лестница достоинства: от присутствия к короткому видео события

Факт. В обсуждениях практиков и семей (r/nursing, r/AssistedLiving, r/eldercare) непрерывный livestream в комнате читается как слежка и провоцирует отзыв

согласия — даже когда камеру «разрешили»⁵³. Это живой язык практики, не рецензируемое доказательство. **Рекомендация.** Лестница наблюдения: сигнал присутствия → аномалия режима → короткое видео события. Continuous livestream на эту лестницу не ставится: он ломает принцип дома (20.1) и даёт повод к отказу.

Четыре принципа и пять абсолютных границ

Принцип дома

Учреждение — дом жителя, а не объект наблюдения: житель знает, что происходит, и может отказаться без последствий.

Человек в контуре

Ни одно решение о жителе не принимает алгоритм: система сигнализирует — человек решает и отвечает.

Пропорциональность

Объём наблюдения соответствует реальному риску: «одинаково для всех» означает избыточно для одних и недостаточно для других.

Обратимость

Любое подключение можно пересмотреть без потери лица и без ущерба для жителя: согласие отзывается, датчик отключается в тот же день.

Пять практик вне границ — независимо от юридической безупречности:

Практика	Почему вне границ
Видеонаблюдение в комнатах проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача с согласия)	Комната — последнее приватное пространство жителя; коридор — да, спальня — нет
Распознавание лиц жителей	Биометрический контур непропорционален задачам учреждения (раздел 10.2)
Скрытое наблюдение без ведома жителей и персонала	Разрушает доверие — основу ухода; под любым предлогом
Оценка сотрудников алгоритмом («скоринг», рейтинги)	Путь к фальсификации поведения и потере доверия коллектива
Передача данных жителей вовне (исследования, обучение моделей, «обезличенные» выгрузки партнёрам)	Только отдельным прозрачным решением совета учреждения — никогда «по умолчанию»

Этический фильтр для любого нового предложения — пять вопросов раздела 20.4; один неверный ответ останавливает проект до переработки.

21. Безопасность данных и инциденты

Учреждение социального обслуживания — не банк и не дата-центр, но данные, которые оно собирает о жителях, чувствительнее банковских: здоровье, поведение, распорядок, иногда — биометрия. Утечка здесь бьёт не по абстрактной репутации, а по конкретным пожилым людям и их семьям. Раздел — практический минимум безопасности для учреждения без ИТ-отдела: что сделать, чего не делать и как действовать, когда что-то пошло не так.

21.1. Три реальных угрозы

Первая угроза — не хакеры, а **случайность**: письмо со списком жителей, отправленное не тому адресату; таблица с диагнозами в общем доступе; текст с фамилией и диагнозом, вставленный в чат-бот. Профилактика — регламент (приложение 3), обезличивание по умолчанию, запрет личных почт и мессенджеров для рабочих данных. Вторая — **вендор**: данные остаются у подрядчика после расторжения, используются для обучения его моделей, хранятся за рубежом. Профилактика — семь пунктов договора (раздел 17.5) и выгрузка данных при выходе. Третья — **целевая атака**: вымогательство через шифрование файлов; реже — целенаправленная кража данных. Профилактика — резервные копии по правилу «3-2-1» (три копии, два носителя, одна вне площадки), обновления, отдельные учётные записи, двухфакторная аутентификация там, где она доступна.

21.2. Минимальный контур безопасности

Восемь мер закрывают большую часть риска и не требуют программиста. (1) У каждого сотрудника — своя учётная запись, общих паролей «на смену» не существует. (2) Права доступа по роли: сиделке не нужны финансовые таблицы, бухгалтеру — видеозаписи. (3) Пароли — длинные и разные; менеджер паролей для руководителей. (4) Резервные копии — автоматически, еженедельно, с ежеквартальной проверкой восстановления (копия, которую не пробовали восстановить, не копия). (5) Рабочие данные — только на рабочих носителях и в утверждённых сервисах; личные флешки и личная почта — вне контура. (6) Увольнение сотрудника = отключение доступов в тот же день. (7) Антивирус и обновления — на всех рабочих машинах, включая «тот старый компьютер у медсестры». (8) Ежегодный часовой инструктаж: фишинг, пароли, что делать при подозрении на инцидент. Всё перечисленное фиксируется одним приказом и одной страницей регламента.

21.3. Инцидент: план на первые 24 часа

Когда инцидент случился — утечка, шифровальщик, потерянный ноутбук с файлами — скорость важнее идеальности. План из пяти шагов (должен висеть у ответственного). Первый час: изолировать — отключить поражённую машину от сети, не выключая её; зафиксировать время и что известно. Первые четыре часа: оценить масштаб — какие данные, чьи, сколько людей; привлечь вендора по каналу сопровождения. Первые сутки: уведомить руководство и юриста; при утечке персональных данных — уведомление Роскомнадзора: первичное в течение 24 часов, отчёт о внутреннем расследовании — в течение 72 часов (обязанность оператора, введённая в 152-ФЗ; за неуведомление — отдельный штраф³¹¹). Далее: уведомление затронутых людей — если утечка создаёт риск для них, семьи узнают об этом от учреждения, а не из новостей. И последний шаг: разбор без поиска виноватых — что в контуре позволило инцидент, и какая одна мера закрывает повторение. Разбор, заканчивающийся наказанием сообщившего, гарантирует, что о следующем инциденте вы узнаете последним.

21.4. Что доклад не рекомендует

Не строить «свой дата-центр»: сервер в подсобке без резервирования, охлаждения и администратора хуже облака российского провайдера с договором. Не покупать «комплексную систему кибербезопасности» — восьми мер из 21.2 достаточно на первые годы. Не хранить данные «про запас»: каждый лишний год хранения — лишний объём утечки; сроки хранения назначаются в положении и исполняются удалением. И не считать безопасность разовым проектом: это режим, как санитарный, — его не «внедряют», его соблюдают.

21.5. Фишинг: три письма, которые придут к вам

Самый вероятный вектор атаки на учреждение — не взлом, а письмо. Три типовых. **«Учредитель просит срочно»:** письмо с адреса, отличающегося одной буквой, — «к 12:00 предоставить списки проживающих». Правило: запросы списков — только после звонка по известному номеру, никогда — по номеру из письма. **«Ваш договор расторгнут»:** письмо «от вендора» с вложением «акт» — при открытии шифрует файлы. Правило: вложения открываются после проверки по телефону; макросы не включаются никогда. **«Родственник жителя»:** просьба «переслать выписку из карты на почту — я сын». Правило: сведения о жителе — только через каналы, записанные в регламенте информирования семьи (приложение б и раздел 18.6), личность звонящего подтверждается по записанным данным. Часовой

инструктаж в год с этими тремя письмами дешевле любого антивируса: большинство инцидентов начинается с того, что человеку было неудобно переспросить.

21.6. Цепочки «безопасных» шагов и недоверие к отчёту модели

Факт. Агентная система с инструментами умеет сложить несколько по отдельности «безопасных» действий в компрометацию: модель получает доступ, забирает содержимое, передаёт его дальше — и каждый шаг в журнале выглядит безобидно. Текст, которым модель описывает, «что она сделала», — не журнал аудита: его можно сфабриковать так же легко, как любую другую галлюцинацию²⁸. Тот же предел описывают иначе: промпт-инъекцию нельзя закрыть более строгой инструкцией — это свойство архитектуры агента⁴¹; ограничения в промпте создают иллюзию контроля и обходятся цепочкой легитимных шагов⁴². Для документного помощника отдельный удар — отравление базы: несколько недоверенных файлов ломают RAG, потому что модель принимает найденный фрагмент за факт⁴³.

Рекомендация. Учреждению не обязательно запускать агентов для программистов, чтобы этот урок был рабочим. Любой сервис, который сам ходит на внешние страницы, вызывает инструменты или действует «по цепочке» рядом с таблицами жителей и сменами, — тот же класс риска. Инструменты изолируются; содержимое с внешних страниц и вложений считается недоверенным; в индекс документного помощника попадают только утверждённые локальные файлы; необратимые действия (отправка, удаление, публикация) — только после явного подтверждения человеком. Бытовой контур той же угрозы — вставка персональных данных в чужой чат-бот: это трансграничная передача без поручения, а не «просто черновик» (разделы 9.2, 10.3а, 21.1)³¹.

22. Экономика и закупки: сколько это стоит на самом деле

Директору нужен не прейскурант вендора, а полная стоимость владения: что проект стоит учреждению за три года, включая всё, о чём продавец не упоминает. Раздел — методика расчёта плюс иллюстративные модели; все суммы — порядки, а не предложения, и пересчитываются на ваши условия. Подтверждённых данных о стоимости внедрений именно в домах социального обслуживания в открытом доступе нет — поэтому здесь нет «средних цен по отрасли», есть рамка, в которую вы подставляете свои числа.

22.1. Полная стоимость владения: шесть строк

Любой проект раскладывается на шесть строк, и забытая строка — обычно самая дорогая. **Оборудование:** устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. **Программы и подписки:** лицензии, облако, тариф на количество камер или жителей. **Внедрение:** настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё. **Эксплуатация:** сопровождение, замена батарей и вышедших из строя устройств (закладывайте 10–15 % парка в год), интернет-канал. **Люди:** время ответственного, обучение смен, разборы тревог — переведите в часы и в ставки, это реальные деньги бюджета. **Выход:** выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению — строка, которую считают последней и которая кусается первой. Проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза — это интерпретация, но проверьте её на любом завершённом внедрении, к которому у вас есть доступ.

22.2. Иллюстративные модели по направлениям

Документы (А): подписка на корпоративный сервис генеративного ИИ для 3–5 пользователей — порядок нескольких тысяч рублей в месяц; время ответственного — два-три часа в неделю первый квартал; итог — самое дешёвое направление и единственное, где полная стоимость сопоставима с одной ставкой. **Видеоаналитика (Б):** иллюстративно для одного отделения (8–12 камер): оборудование и монтаж — основная разовая строка; подписка на аналитику — ежемесячная; сопровождение — ежегодная; трёхлетняя стоимость сопоставима с годовым фондом оплаты одной-двух ставок. **Наблюдение (В):** комплект датчиков на 10 жителей плюс подписка — раз в несколько лет меняется парк; скрытая строка — время медсестры и врача на разбор сигналов. **Голосовые помощники (Г):**

устройства недорогие, дорогое — настройка и поддержка сценариев. **Обучение (Д) и аналитика (Е):** стоят почти одно время — своё или купленное. Общий вывод моделей: порог входа различается на два порядка — от тысяч рублей (А, Г) до сумм, требующих решения учредителя (Б). Дорожная карта раздела 16 построена именно по этому градиенту.

22.3. Закупка: как не купить обещание

Правила закупки ИИ-решений совпадают с правилами любой закупки, но имеют четыре специфических дополнения. Требуйте пилот до контракта: вендор, уверенный в продукте, согласен на 60–90 дней проверки на вашей площадке с вашими метриками (паспорт пилота — приложение 7); отказ от пилота — информация. Покупайте по результату пилота, а не по презентации: в техзадание идут ваши измеренные цифры (ложные тревоги, время реакции), а не маркетинговые. Сравнивайте трёхлетнюю стоимость, а не цену входа: дешёвое оборудование с дорогой подпиской проигрывает за три года. И держите выход открытым: формат выгрузки данных и условия расторжения — в договоре до подписания (раздел 17.5). Для госучреждения всё это укладывается в стандартные процедуры закупок — специфика только в содержании техзадания, и оно пишется по материалам этого доклада. Европейский обзор DHT добавляет ту же оговорку к смете: барьеры масштаба (включённость, регуляторика, оплата, модели доставки) не закрываются удачным пилотом в одном отделении — трёхлетняя стоимость пилота кожи или датчика не доказывает готовность сети домов⁷⁹.

22.4. Откуда деньги: честный разговор с учредителем

У типового учреждения нет свободных средств на «цифровизацию» — и ожидать их появления не стоит. Реалистичные источники три: перераспределение внутри года (направление А окупается временем офисных сотрудников уже в первый квартал — эти часы и есть ресурс на следующие ступени); целевые программы и конкурсы (региональные программы развития соцобслуживания, гранты — заявка пишется по дорожной карте раздела 16, у которой есть замеры, а не обещания); и аргумент избегаемых потерь для учредителя: стоимость одного тяжёлого падения с поздним обнаружением — медицинская, репутационная, иногда судебная — сопоставима со стоимостью пилота, который такие случаи выявляет за минуты. Этот аргумент работает только в связке с замерами: «мы измерили, сколько тревог и сколько ложных» убеждает там, где «это современная технология» не убеждает.

22.5. Иллюстративный расчёт: полная стоимость видеопилота за 90 дней

Модель для разговора с учредителем; все числа — порядки для пересчёта, не смета. **Оборудование:** 10 камер, серверный блок, монтаж и сеть — разовая строка, сопоставимая с несколькими месячными фондами оплаты труда сотрудника. **Подписка на аналитику:** ежемесячная строка за 10 каналов. **Внедрение:** настройка зон и порогов, обучение двух смен, интеграция с постом медсестры — разовая строка плюс 40–60 часов своих людей. **Эксплуатация за 90 дней:** время смены на реакцию (при грамотной настройке — минуты в сутки), еженедельные разборы тревог (час в неделю), время ответственного (2–3 часа в неделю). **Выход:** выгрузка событий, акт об удалении, демонтаж или перенос камер в другие зоны. **Итог:** главная строка — разовое оборудование; главная скрытая — свои часы; главный вопрос — что с оборудованием при закрытии пилота (перепрофилирование в обычное видеонаблюдение — нормальный исход, запишите его в паспорт). Сравнение с альтернативой — не «ноль рублей», а избегаемые потери (раздел 22.4): стоимость одного поздно обнаруженного тяжёлого падения — медицинская, репутационная, юридическая — сопоставима со всей разовой строкой. Этот расчёт на ваших числах — документ для учредителя; маркетинговый буклет вендора — нет.

Полная стоимость владения: шесть строк, которые считают честно

1. Оборудование

Устройства, сервер или его отсутствие, монтаж, сеть. Разовая строка — и обычно единственная, которую называет продавец.

2. Программы и подписки

Лицензии, облако, тариф за камеры или жителей. Ежемесячная строка, которая за три года обгоняет оборудование.

3. Внедрение

Настройка, интеграция с вашими журналами, обучение — у вендора и своё, в часах сотрудников.

4. Эксплуатация

Сопровождение, замена устройств (10–15 % парка в год), интернет-канал, обновления.

5. Люди

Время ответственного, разборы тревог, обучение смен — переведите часы в ставки: это реальные деньги бюджета.

6. Выход

Выгрузка данных, демонтаж, переход к другому решению. Строка, которую считают последней, — а кусается она первой.

Правило: проект, у которого посчитаны только первые две строки, недооценён в полтора-два раза. Сравнивайте варианты по трёхлетней стоимости, а не по цене входа (раздел 22); условия выхода фиксируйте в договоре до подписания (раздел 17.5).

Честные ограничения

Где искусственный интеллект не нужен, типовые ошибки, запретная зона и критерии отказа — части доклада, которые экономят бюджет и репутацию. Разделы 23–25.

23. Где искусственный интеллект не нужен

Самая полезная часть доклада для бюджета — эта. Тема ИИ устроена так, что продавать решения выгодно всем: вендорам, консультантам, авторам программ «цифровизации». Невыгодно одно — честно сказать, где технология не нужна. Доклад называет семь таких мест; всё нижесказанное — интерпретация и рекомендация, проверяемые здравым смыслом и вашими журналами.

23.1. Там, где задача не существует

Первый и главный случай: внедрение без боли. Если смена успевает заполнить журналы, падения обнаруживаются быстро, а жалоб на документы нет — ИИ не нужен, нужна планёрка. Проверка проста: назовите измеримую проблему, которую решает проект, и число, по которому вы узнаете, что она решена. Не называется — проекта нет, есть покупка. Фильтры отбора задачи из раздела 7 работают и в обратную сторону: задача, не прошедшая четыре фильтра (боль, измеримость, обратимость, правовая чистота), не становится лучше от приставки «искусственным интеллектом».

23.2. Там, где проще без технологий

Значительная часть «задач для ИИ» в учреждении решается дешевле и надёжнее простыми средствами. Напоминание о приёме лекарств лежащему жителю — это расписание на стене и дисциплина смены, а не колонка. Учёт продуктов на складе и отходов кухни — это электронная таблица и ответственный, а не «предиктивная платформа питания»; операционная панель кандидата М появляется только когда эта таблица уже живёт. Противопрележневый уход — это график поворотов и контроль старшей сиделки; кандидат Н (фото → медсестре) садится на этот график, не вместо него (раздел 4.4). Правило: если задачу закрывает лист бумаги, таблица или регламент — сначала лист, таблица и регламент. Технология оправдана, когда простое средство уже работает и упёрлось в предел: людей не хватает, ночь длинная, журналов слишком много.

23.3. Там, где решение принимает человек по долгу службы

Медицинские решения, решения о переводе жителя, о применении ограничительных мер, о хозяйственных тратах — зона человека, закреплённая законом (ст. 16 закона о персональных данных)²¹⁰ и здравым смыслом. ИИ здесь может подготовить сводку, но не рекомендацию-вердикт. Граница простая: чем

ближе решение к судьбе конкретного человека, тем меньше в нём места алгоритму. Это не техноскепсис, а распределение ответственности: алгоритм не сидит на ковре у учредителя и не отвечает перед семьёй жителя. Лекарственная логистика (кандидат Ж) эту границу не сдвигает: сверка утверждённого списка, напоминание, идентификация дозы и флаги взаимодействий — к медсестре; автономного «ИИ назначил, сменил дозу или отменил таблетку» в доме нет⁵⁴⁵⁵⁶⁵. Питание (кандидат М) — тот же контур: текстуру и лечебные ограничения назначает клиника; программа не ставит диагноз недоедания по фото или урне и не подбирает терапевтическую диету сама⁶¹⁶²⁶³⁶⁴. Целостность кожи (кандидат Н) — фото и подсказка стадии или «пролежень / IAD» идут медсестре; модель не лечит и не «закрывает рану»⁷¹⁷²⁷³.

23.4. Там, где нет данных и не будет

Предиктивная аналитика («модель предскажет ухудшение за две недели») требует лет качественных записей, которых у типового учреждения нет — журналы ведутся на бумаге, неполно и разными почерками в переносном смысле. Покупать модель ради данных, которые появятся «потом», — это покупать кровать в дом без фундамента. Сначала — дисциплина данных (квартал 2 дорожной карты), потом, через годы, — разговор о моделях. До тех пор честный ответ на предложение предиктивной аналитики — «нам рано».

23.5. Там, где технология заменяет внимание

Последняя запретная зона не техническая, а человеческая: ИИ не должен становиться способом сократить живое общение с жителем. Колонка, отвечающая на вопросы, не заменяет сиделку, которая спросила, как спалось; панель с «зелёными статусами» не заменяет обход; реминисцентный плейлист и «умный» диалог не делают робота сиделкой и не лечат возбуждение (разделы 13.8, 20)⁵⁸⁵⁹⁶⁷⁶⁸. Голландские HI-SAR («обнимаемые» соцроботы) — исследование потенциала и барьеров в LTC (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг активности), не лицензия сократить ставку сиделки; реальный европейский масштаб ограничен, в карту кандидатов робот не входит⁸¹. То же читаем в обзоре ВМС: относительно лучшие данные по настроению и одиночеству — при высоком риске смещения, не замена персонала⁴⁹. Учреждение, где технологии используются для уменьшения контакта с жителями, экономит на главном — и рано или поздно платит за это всем остальным. Технология в этом докладе везде понимается одинаково: она освобождает время человека для человека, а не от человека.

Отдельно — то, что продают как «полный Advisor Suite» американского skilled nursing: скоринг входящего реферала, биллинг и MDS/PDPM. Это не наша боль и не наша отчётность. Из того пресса берём только идею подсветки дыр в журнале человеку на разбор; остальное в карту ДСО не кладём (разделы 4.2, 9.8)⁶⁰.

23.6. Доказательная скромность

Факт. Даже на Западе систематические обзоры не дают консенсуса по эффективности ИИ в LTC: BMC — слабая доказательная база и высокий риск bias; JMIR — качество первичных обзоров низкое или критически низкое, барьеры те же (ложные тревоги, приватность, ломка смены)⁴⁹⁵⁰. **Интерпретация.** Нет подтверждённых данных по российским ДСО — не провинциальность отрасли, а норма поля. **Рекомендация.** Честность разделов 6.3 и 11.2 усиливается, не ослабляется: пилот и свой замер обязательны; чужие обзоры — гипотеза, не разрешение закупать.

24. Чего делать не надо: типовые ошибки и запретная зона

Раздел собирает воедино ошибки, разбросанные по главам, и добавляет те, что не вошли ни в одну. Формат — «ошибка → чем кончается → что вместо». Часть ошибок — обобщение опубликованных провалов внедрений в социальной и медицинской сферах, часть — опыт смежного проекта вариативного питания; вместе они образуют карту минного поля, которую можно повесить в кабинете ответственного.

24.1. Ошибки замысла

Купить, потом понять. Закупка до формулировки задачи кончается оборудованием на складе; вместо — фильтры раздела 7 и пилот до контракта (22.3). **Начать с самого сложного.** Видеоаналитика первым проектом — это провал по всем осям сразу; вместо — дорожная карта от простого к сложному (раздел 16). **Сделать «для отчёта».** Внедрение ради галочки в отчёте учредителю кончается мёртвой системой и компроматом на учреждение при первой же проверке факта работы; вместо — проект только под измеримую боль. **Переписать чужой успех.** Практика московской больницы или казанского дома-интерната не переносится копированием — переносится метод (пилот, замер, критерии), а не решение.

24.2. Ошибки данных и права

Вставить персональные данные в чат-бот. Одна вставка — и у учреждения утечка спецкатегории данных во внешний сервис; вместо — регламент и обезличивание (приложение 3), обучение, журнал инцидентов. **Поверить тексту модели.** Модель уверенно сочиняет номера статей и реквизиты; каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику — правило без исключений. **Камеры без положения.** Видеонаблюдение без положения, уведомлений и журнала доступа — самостоятельное нарушение, даже если камеры «помогли»; вместо — комплект раздела 17.3 до монтажа. **Биометрия «потому что умеет».** Распознавание лиц добавляет самый тяжёлый правовой контур при нулевой добавленной пользе для наших задач; событийная аналитика без идентификации закрывает те же задачи дешевле во всех смыслах (раздел 10).

24.3. Ошибки людей

Не сказать персоналу правду. Слух «нас заменят» бежит быстрее любой рассылки; вместо — четыре страха и четыре ответа раздела 19 до запуска. **Использовать записи против сотрудников.** Один дисциплинарный разбор по записи видеоаналитики — и система становится врагом смены навсегда; положение запрещает такое использование (приложение 8). **Обучение под подпись.** «Ознакомлен» без практики равен «не обучен»; вместо — три повторения на рабочем месте (19.4). **Игнорировать ложные тревоги.** Десять ложных тревог в смену убивают систему за месяц; порог и еженедельный разбор — в паспорте пилота (приложение 7).

24.4. Запретная зона: семь «никогда»

Сводка для быстрой проверки любого предложения. Никогда: (1) не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома; (2) не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы; (3) не принимать решения о жителях по выводу алгоритма; (4) не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения; (5) не использовать распознавание лиц; (6) не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы; (7) не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5. Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает.

24.5. Чек-лист «не является ли это ошибкой» (для совещания)

Десять утверждений-лакмусов; каждое «да» — повод остановиться и вернуться к разделу, указанному в скобках. (1) Решение о закупке принято до формулировки измеримой задачи (7). (2) В техзадании есть слова «распознавание лиц» (10.2). (3) Пилот начался без подписанного паспорта с критериями (25.1). (4) Хотя бы один сотрудник использует для рабочих текстов сервис вне списка (9.2). (5) В договоре нет пункта об удалении данных при расторжении (17.5). (6) Записи хоть раз использовались для разбора работы сотрудника вне ЧС (19.2). (7) Житель узнал о датчике в своей комнате постфактум (18). (8) Метрика эффекта взята из презентации вендора, а не из нашего замера (22.3). (9) Ответственный за проект один, подменяющего нет (17.1). (10) О проекте учредитель узнает из годового отчёта, а семья жителя — случайно (18.4). Чек-лист читается на каждом совете о цифровых проектах — две минуты, которые стоят дешевле любой экспертизы.

Запретная зона: семь «никогда»

1

Не запускать системы, влияющие на жителей, без их ведома.

2

Не отправлять необезличенные данные жителей во внешние сервисы.

3

Не принимать решения о жителях по выводу алгоритма.

4

Не устанавливать камеры в комнатах проживания вне палат интенсивного наблюдения.

5

Не использовать распознавание лиц.

6

Не покупать предиктивные модели без собственных данных за годы.

7

Не подписывать договор без семи пунктов раздела 17.5.

Проверка

Любое новое предложение прогоняется через этот список за десять минут совещания. Одно «никогда» — и проект останавливается до переработки (разделы 20.4, 24.4).

Список короткий специально: запретная зона, которую нельзя запомнить целиком, не работает. Печатается отдельным листом для кабинета ответственного.

25. Критерии отказа и остановки проекта

Умение остановиться — часть внедрения, а не его провал. Доклад о вариативном питании говорил то же о ступенях: ступень, которая не подтвердилась замером, не закрепляется. Здесь тот же принцип переведён на язык технологий: у каждого проекта заранее, до старта, написаны условия, при которых он останавливается. Это и есть главная разница между пилотом и «мы уже купили».

25.1. Критерии пишутся до старта

В паспорте пилота (приложение 7) есть блок «критерии исхода»: три исхода — закрепить, перенастроить и повторить, закрыть. Критерии формулируются числами: доля ложных тревог, время реакции смены, доля жителей, отзывавших согласие, время персонала на систему в сутки, стоимость месяца эксплуатации. Правило одно: критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Поэтому паспорт подписывается директором и врачом до первого включения системы.

25.2. Стоп-сигналы: остановка немедленная

Пять сигналов останавливают проект в тот же день, без совещаний. Утечка данных — по плану раздела 21.3. Системный вред жителю: тревога, которую смена не услышала из-за ложных срабатываний; решение, принятое по ошибочному сигналу. Массовый отзыв согласий жителями — система потеряла легитимность, техника не виновата и не поможет. Отказ врача работать с сигналами направления В — без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). И тихий сигнал, который опаснее всех громких: система работает, но ей не пользуются — панель не открывается, сводки не читаются; неиспользуемая система — это затраты без пользы, и честный ответ на неё — закрытие или перезапуск с другой задачей.

25.3. Остановка по замеру: как закрывать правильно

Остановка по итогам пилота — штатная процедура из четырёх шагов. Первый: разбор результатов на совете с врачом и первыми пользователями — что показали числа против критериев. Второй: письменное решение — закрыть, перенастроить (один раз, с новыми критериями и сроком) или закрепить; решение фиксируется, чтобы через год не начать тот же пилот заново под другим названием. Третий: выход по договору — выгрузка данных, акт об удалении у вендора, демонтаж (здесь

окупаются семь пунктов раздела 17.5). Четвёртый: сообщение людям — жителям, родственникам, сменам: что пробовали, что измерили, почему закрыли. Закрытый с таким разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад.

25.4. Отказ до старта: это тоже результат

Доклад считает нормальным отказ на любом фильтре: задача не найдена (раздел 7), отрицательное заключение юриста (10.5), пилот не подтвердил эффект, нет средств под трёхлетнюю стоимость. Учреждение, проводшее такой разбор и отказавшееся, защищено лучше внедрившего наугад: у него документированное решение, а тема остаётся в управляемом контуре. Отказ по критериям — управленческая зрелость; именно так его и формулируют учредителю и коллективу.

Критерии остановки: когда проект закрывают в тот же день

Утечка данных

Действия по плану первых 24 часов (раздел 21.3): изолировать, оценить, уведомить Роскомнадзора за 24 часа, отчёт за 72 часа³.

Вред жителю

Тревога, не услышанная из-за ложных срабатываний; решение по ошибочному сигналу. Стоп, разбор, перенастройка или закрытие.

Массовый отзыв согласий

Система потеряла легитимность. Техника здесь не виновата и не поможет — остановка и разговор с жителями.

Отказ врача

Без врача в контуре наблюдение за состоянием не существует (раздел 12). Проект не запускается или останавливается.

Тихий сигнал

Система работает, но ей не пользуются: панель не открывается, сводки не читаются. Неиспользуемая система — затраты без пользы.

Критерии — до старта

Критерии, написанные после получения результатов, — не критерии, а оправдание. Паспорт пилота подписывается до первого включения (раздел 25.1).

Закрытый с разбором проект оставляет учреждению опыт и документы; тихо брошенный — слухи и склад (раздел 25.3). Отказ по критериям — управленческая зрелость.

Частые вопросы директоров: короткие ответы

Раздел собран из вопросов, которые задают на семинарах и в переписке после знакомства с темой. Ответы даны в сжатой форме со ссылками на разделы — здесь нет нового материала, есть быстрый доступ к уже изложенному.

«С чего начать, если нет ни денег, ни ИТ-специалиста?» С регламента использования генеративного ИИ (приложение 3) и одного измеримого сценария в документах — это нулевые вложения и эффект в первую неделю (разделы 9, 16.2).

«Законно ли вообще использовать чат-боты в госучреждении?» Да — при соблюдении трёх условий: обезличенные тексты, утверждённый список сервисов, проверка человеком. Запрета нет; есть требования к персональным данным (разделы 9.2, 10).

«А если учредитель требует “внедрить ИИ к отчёту”?» Показать дорожную карту с замерами (раздел 16) и предложить закрыть квартал 1–2 к отчёту: это реальный, документируемый результат вместо покупки ради галочки (кейс 12).

«Персонал боится, что под видеоаналитикой будут следить за сменами.» Это решается не разговорами, а конструкцией: событийная аналитика без идентификации, запрет дисциплинарного использования записей в положении (приложение 8), журнал доступа (раздел 19.2).

«Житель/семья против любых датчиков. Насильно?» Нет. Отказ принимается без последствий; альтернатива — усиленные обходы (раздел 18.3). Системы наблюдения — для тех, кто согласен.

«Вендор обещает “снижение падений на 40 %”. Верить?» Просите методику: на каких учреждениях, какой период, что было контролем. Падения нельзя «предотвратить» камерой — можно сократить время обнаружения; путаница этих метрик — признак рекламы (разделы 11, 22.3).

«Сколько стоит “нормальное внедрение” целиком?» Неправильный вопрос: правильный — полная стоимость каждого направления по шести строкам (раздел 22.1). Разброс — от тысяч рублей (документы) до решений уровня учредителя (видеоаналитика).

«У нас бумажные журналы и старые компьютеры. Нам рано?» Для направления А — нет, для предиктивной аналитики — да. Дисциплина данных (квартал 2) — это и есть подготовка, без неё дорогие системы бесполезны (раздел 15).

«Можно ли использовать распознавание лиц на входе?» Доклад рекомендует нет: биометрический контур несопоставим с задачей (раздел 10.2). Контроль входа решается обычным СКУД и дежурным.

«Что будет, если мы ничего не будем внедрять?» Формально — ничего. По сути — накопленный разрыв: соседние учреждения вернут персоналу часы живой работы, а ожидания учредителей (стратегия ИИ до 2030 года⁴) придут к вам без вашего плана (раздел 3).

«Кто отвечает, если алгоритм ошибся и жителю навредили?» Человек, принявший решение, и учреждение. Алгоритм субъектом ответственности не является — поэтому и существует принцип «человек в контуре» (разделы 5, 20).

«Нужно ли согласие жителей на видеонаблюдение в коридорах?» Индивидуальное согласие на коридоры обычно не требуется при законных основаниях обработки, но информирование обязательно — уведомление, стенд, положение (приложения 6, 8); юрист подтвердит контур для вашего случая (раздел 17.4).

Заключение: что делать в понедельник

Доклад написан против двух крайностей, которые одинаково дорого обходятся отрасли. Первая — «ИИ решит всё»: закупки под обещания, платформы без задач, биометрия без нужды. Вторая — «это всё не про нас»: упущенные годы, в которые соседние учреждения уже освободили смены от бумажной работы и научились находить упавшего жителя за минуты. Между ними — рабочая полоса, и она не требует ни программистов, ни миллионов.

Она начинается с четырёх действий, доступных любому учреждению в ближайшую неделю. Первое: издайте приказ с регламентом использования генеративного ИИ (приложение 3) — страница текста, которая превращает стихийное использование чат-ботов в управляемый инструмент и закрывает главную дыру утечек. Второе: назначьте ответственного за цифровые проекты и заведите реестр систем — теперь у темы есть хозяин. Третье: выберите одну измеримую боль по фильтрам раздела 7 и замерьте её до любых закупок. Четвёртое: поставьте в план совета с врачом разбор дорожной карты раздела 16 — с правом сказать «нам рано» по любой ступени.

Всё остальное — пилоты датчиков, видеоаналитика, тренажёры, аналитика — придёт в своём квартале, на своих замерах и с вашими критериями остановки. Искусственный интеллект в этом докладе — не цель и не угроза, а инструмент, который в грамотном учреждении освобождает время человека для человека. Тем, кто прошёл с нами проект вариативного питания, логика знакома: ступень → замер → закрепление → следующая ступень. Технологии меняются, логика остаётся.

★ Часть V

Учебные кейсы

Четырнадцать кейсов с вопросами для разбора и опорными ответами — материал для семинара и внутреннего обучения персонала.

Учебные кейсы. Часть 1

Двенадцать кейсов собраны для разбора на семинаре и для внутреннего обучения. Все кейсы — **иллюстративный материал**: они построены на типовых ситуациях, обобщённых из публикаций и практики внедрений в социальной и медицинской сферах; имена, названия учреждений и числа вымышлены, если не сказано иное. К каждому кейсу — вопросы для разбора; «правильного ответа» у большинства нет, есть решения с разной ценой.

Кейс 1. Письмо в чат-бот

Ситуация. Специалист по социальной работе готовит ответ на жалобу родственницы жителя. Чтобы «сделать текст вежливее», она вставляет в бесплатный чат-бот письмо целиком: фамилия жителя, диагноз, номер комнаты, конфликт с соседом. Через месяц на планёрке выясняется, что так делают трое сотрудников «уже давно».

Вопросы для разбора. Когда именно произошло нарушение — в момент вставки текста? Чьи данные утекли и какой категории? Что должен сделать директор в первую неделю: наказать, обучить, издать приказ — в каком порядке? Как объяснить коллективу разницу между «проверить орфографию» и «передать данные оператору сервиса»?

Опорный разбор. Нарушение состоялось в момент передачи персональных данных третьему лицу без правового основания. Разбор без поиска виноватых (иначе практика уйдёт в тень), регламент (приложение 3) и час практики на своих текстах закрывают проблему за неделю; наказание — нет. Связь: разделы 9, 21, 24.2.

Кейс 2. Сто одиннадцать ложных тревог

Ситуация. Видеоаналитика падений на отделении (12 камер) в первый месяц дала 111 тревог, из которых 2 — реальные падения. Смена начала игнорировать звук панели; на втором месяце реальное падение заметили через 40 минут — по счастью, без тяжёлых последствий.

Вопросы для разбора. Кто виноват в пропущенном падении: смена, вендор, директор? Какие три действия по паспорту пилота (приложение 7) должны были произойти ещё в первый месяц? Какой порог ложных тревог вы бы записали в критерии исхода?

Опорный разбор. Система с долей ложных тревог 98 % — не работающая система, и вина смены вторична: усталость от тревог — прогнозируемый эффект. Немедленная перенастройка с вендором (зоны, пороги, повторная валидация), недельный разбор со сменой, перезапуск пилота с новым сроком. Если после перенастройки ложных тревог больше двух на устройство в неделю — закрытие по критериям. Связь: разделы 11, 19.5, 25.

Кейс 3. «Мама не хочет, а мы хотим»

Ситуация. Дочь жительницы просит установить в комнате матери датчик сна и камеру: «Мы за неё боимся, а она упрямится». Жительница дееспособна, категорически против, считает, что «за ней шпионят». Дочь звонит директору еженедельно, намекает на жалобы выше.

Вопросы для разбора. Чьё решение решающее и почему? Как построить разговор с дочерью, чтобы она стала союзником, а не источником жалоб? Есть ли компромисс, уважающий обе стороны?

Опорный разбор. При дееспособной жительнице решает она (раздел 18.3); камера в комнате — вне допустимого вообще (раздел 20.2). Компромиссный контур: усиленные обходы, кнопка вызова, информирование дочери о регламенте реагирования. Дочери — фактами: что видит учреждение, как быстро реагирует, что будет при ухудшении. Связь: разделы 12, 18, 20.

Кейс 4. Врач против датчиков

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты закупил 20 комплектов датчиков сна «по хорошей цене, пока были средства». Врач узнала постфактум и отказалась работать с сигналами: «Я не подписывалась отвечать за пицание коробок под матрасами — мне и так некогда». Оборудование лежит на складе.

Вопросы для разбора. В каком месте цепочки решений произошёл сбой? Как теперь выводить проект из склада: уговорить врача, заменить её решение приказом, вернуть оборудование? Что должно было предшествовать закупке?

Опорный разбор. Сбой на нулевом шаге: направление В существует только «в связке с врачом» (раздел 12), а решение принято по логике «успеть потратить». Выход: совет директор—врач, совместный список жителей (5–10), маршрут эскалации (приложение 9) с внятной нагрузкой врача, паспорт пилота — и только потом монтаж. Если врач не включается после честного разговора о нагрузке — проект не запускается; оборудование возвращается или перепрофилируется. Связь: разделы 12, 16.4, 22.

Кейс 5. Вендор и семь пунктов

Ситуация. Поставщик видеоаналитики — «лучшая цена на рынке» — направил типовой договор. Юрист учреждения внёс семь пунктов из чек-листа (приложение 5): данные — собственность учреждения, хранение в РФ, запрет обучения моделей на данных учреждения, акт об удалении при расторжении, ответственность за утечку, право аудита, выгрузка в открытом формате. Вендор согласен на три из семи и предлагает скидку 15 % «за простоту».

Вопросы для разбора. Какие из четырёх отвергнутых пунктов можно компенсировать иначе, а какие — нет? Чем опасна скидка в этом контексте? Как оформить отказ, чтобы сохранить конкуренцию на будущее?

Опорный разбор. Отказ от удаления данных и запрета обучения моделей означает, что данные жителей становятся активом вендора, — цена вопроса не 15 %, а весь смысл договора. Отказ (или ожидание другого поставщика) документируется служебной запиской: учреждение защищено уже тем, что решение принималось по чек-листу, а не по цене. Связь: разделы 17.5, 22.3.

Кейс 6. Тренажёр, который «прокликали»

Ситуация. Учреждение внедрило ИИ-тренажёр сложных диалогов для новых сотрудников (раздел 14). Через квартал отчёт красив: 100 % новичков «прошли» 10 сценариев. Наставник замечает: в реальных конфликтах с жителями новички повторяют те же ошибки, что раньше. Выясняется: сценарии проходились «для галочки» на скорость, обратная связь не читалась.

Вопросы для разбора. Что в дизайне обучения пригласило к «прокликиванию»? Какие метрики тренажёра измеряют обучение, а какие — только активность? Кто и как должен использовать результаты?

Опорный разбор. Метрика «прошёл сценарий» — метрика активности; метрики обучения — качество ответов по разбору тренера, поведение наставника в реальных ситуациях, повторное прохождение через месяц. Тренажёр работает в связке с живым разбором (15 минут на планёрке), а не как самодостаточная программа. И повторить главное из раздела 14: тренажёр — не инструмент аттестации, иначе его будут обманывать. Связь: разделы 14, 19.4.

Учебные кейсы. Часть 2

Кейс 7. Ночь, шифровальщик, понедельник

Ситуация. В понедельник утром бухгалтерия обнаруживает: файлы зашифрованы, на экране — требование выкупа. Зашифрованы: расчётные файлы, электронные журналы, архив сканов личных дел за пять лет. Резервные копии делались «на тот же сервер» и зашифрованы вместе с оригиналами. Последняя внешняя копия — девятимесячной давности, на флешке в сейфе директора.

Вопросы для разбора. Разложите первые 24 часа по плану раздела 21.3: кто что делает, кого уведомляют? Что из потерянного восстановимо и какой ценой? Какие две меры из восьми (21.2) стоили бы учреждению меньше всего — и не были выполнены?

Опорный разбор. Копия «на том же сервере» не является копией вне площадки — правило 3-2-1 нарушено ровно в той части, которая и нужна против шифровальщика. Уведомление Роскомнадзора об инциденте с персональными данными обязательно; выкуп не платится (нет гарантий, есть поощрение следующей атаки). Восстановление: с внешней копии + повторный ввод за девять месяцев — недели ручной работы. Цена двух пропущенных мер (внешняя копия еженедельно, проверка восстановления ежеквартально) — порядка часа в неделю. Связь: раздел 21.

Кейс 8. Колонка для Марии Ивановны

Ситуация. В рамках пилота голосовых помощников (раздел 13) колонку поставили жительнице 86 лет, активной, но плохо видящей. Через месяц: напоминания о занятиях она слушает, радио включает голосом, «поговорить» с колонкой пыталась дважды и бросила — «она глупая и не слышит». Внучка жительницы просит поставить такую же соседке по комнате, которая колонку боится.

Вопросы для разбора. Пилот удался или нет — по каким метрикам вы ответите? Что ответить внучке и как оформить позицию соседки? Какие выводы для масштабирования направления Г?

Опорный разбор. По метрикам паспорта пилота (использование в неделю, доля отказов, жалобы) — частичный успех: утилитарные сценарии работают, «компаньон» — нет, и это совпадает с разделом 13: реалистичность ожиданий. Соседке — без колонки: добровольность не имеет исключений «по просьбе родных». Масштабирование: только по списку добровольцев, с настройкой под слух и речь каждого. Связь: разделы 13, 18.

Кейс 9. «Мы купили предиктивную платформу»

Ситуация. Учредитель выделил целевые средства на «платформу предиктивной аналитики здоровья проживающих» — региональный проект, отчётность квартальная. Платформа установлена; для работы ей нужны структурированные данные наблюдений за 12 месяцев минимум. У учреждения — бумажные журналы и электронные таблицы за полгода, заполняемые «как получится». Вендор предлагает «загрузить ретроспективу из журналов силами персонала».

Вопросы для разбора. Как оценить трудоёмкость «загрузки ретроспективы» и качество полученных данных? Что честно доложить учредителю и когда? Можно ли вывести проект в полезное русло, не признавая его провалом?

Опорный разбор. Классическая подмена: платформа куплена под данные, которых нет (раздел 23.4). Ручная ретроспектива из неполных журналов даст мусор на входе — и красивые, ложные выводы. Честный маршрут: доложить учредителю проблему данных с планом (квартал дисциплины записей, паспорта показателей — приложение 11), перевести платформу в режим накопления, отчётность строить на плане, а не на «выводах модели». Связь: разделы 15, 22.4, 25.4.

Кейс 10. Пилот, который остановили

Ситуация. Пилот датчиков активности для 8 жителей завершён. Замеры: сигналов немного, ложных — умеренно; два сигнала помогли врачу скорректировать наблюдение. Но: время медсестры на систему — 40 минут в сутки, двое жителей отозвали согласие («некомфортно»), стоимость продления — выше ожиданий. Критерии паспорта пилота выполнены наполовину.

Вопросы для разбора. Закрепить, перенастроить или закрыть — и как аргументировать каждое решение? Как подать остановку коллективу и учредителю, чтобы она не читалась как «провал»? Что сохранить из проекта в любом случае?

Опорный разбор. По критериям — закрытие или перенастройка с узкой задачей (оставить датчики только у жителей из списка врача, где уже был эффект). Подача: «мы измерили, получили два клинических результата при высокой цене эксплуатации, оставляем точно» — это язык управления, а не оправдания. Сохранить: маршрут эскалации, опыт согласий, реестр и ответственного — актив на следующий пилот. Связь: разделы 12, 25.

Кейс 11. Родственник требует доступ к видео

Ситуация. Сын жителя требует онлайн-доступ к камере коридора у комнаты отца: «Я плачу за содержание, я должен видеть, как за ним ухаживают». После отказа прислал жалобу в надзор: «учреждение скрывает условия проживания».

Вопросы для разбора. Какие интересы сталкиваются в этой просьбе? Почему «разрешить одному» ломает весь контур? Из чего состоит ответ, который закрывает тему без врага в лице семьи?

Опорный разбор. Против просьбы: права других жителей в кадре, персонала, и сама логика положения о видеонаблюдении (доступ — у ограниченного круга, под журнал, по событию). Доступ родственнику = превращение наблюдения в надзорное окно для внешних лиц — недопустимо (разделы 18.5, 20.2). Ответ: письменно — правовые основания и порядок доступа к записям по событию; лично — предложить то, что решает настоящую боль: регламент информирования семьи, звонок по расписанию, участие в совете. На жалобу — тем же пакетом документов. Связь: разделы 17.3, 18, 20.

Кейс 12. Слишком хороший отчёт

Ситуация. Ответственный за цифровые проекты готовит учредителю годовой отчёт о внедрении. Данные скромные: направление А работает, пилот В закрыт по критериям, видеопилот перенесён. Председатель совета просит «усилить позитивом: напишите, что пилот показал эффективность, — нам ещё год отстаивать эту тему». Красивую формулировку уже подготовил чат-бот.

Вопросы для разбора. Чем опасен «усиленный» отчёт — назовите три последствия в горизонте года? Как сформулировать отчёт, который и честен, и защищает тему? Какая фраза из доклада — готовый ответ председателю?

Опорный разбор. Отчёт с приукрашиванием уничтожает главный актив — доверие к замерам: следующий пилот будет оцениваться по «эффективности», которой не было. Отчёт по факту читается сильнее: «направление А закреплено, экономия времени измерена; пилот В закрыт по критериям — решение документировано; видеопилот перенесён по причинам данных» — это и есть «управляемая тема» (раздел 16.5). Готовая фраза: «Учреждение, которое провело разбор и отказалось, защищено лучше учреждения, которое внедрило наугад» (раздел 25.4). Связь: разделы 15, 16, 25.

Учебные кейсы. Часть 3

Кейс 13. «Нам рано» — отказ, который сэкономил год

Ситуация. Директор психоневрологического интерната после семинара «загорелся» видеоаналитикой: готов проект, посчитана смета, найден грант. На совете с врачом выясняется: журналы событий ведутся нерегулярно, число «до» (сколько падений и как быстро их находят сейчас) назвать никто не может; врач занят и в проект «не вписывается»; половина смен не знает о планах. Грант «горит» — решение нужно за месяц.

Вопросы для разбора. Перечислите, какие фильтры раздела 7 не пройдены. Что директору ответить грантодателю? Как использовать «горящий» срок как ресурс, а не как давление?

Опорный разбор. Не пройдены измеримость (нет числа «до» — эффект пилота будет недоказуем) и обратимость в части людей (смена не готова к тревогам). Решение: отказ от гранта под видеоаналитику и — важно — встречное предложение грантодателю под то, что учреждению реально по силам (документы, обучение, дисциплина данных). Год уходит на кварталы 1–2 дорожной карты; за этот год появляются: реестр, журналы с регулярными записями, число «до» по падениям, врач, видевший маршрут эскалации на бумаге. Через год та же заявка пишется на данных — и защищается вдвое сильнее. «Нам рано» в срок — это инвестиция, а не упущенная возможность. Связь: разделы 7, 16, 25.4.

Кейс 14. Обычная победа: направление А за квартал

Ситуация. Учреждение на 300 мест, без ИТ-специалиста. Директор издаёт приказ с регламентом (приложение 3), назначает ответственным заместителя по АХЧ, выбирает два сервиса в список допущенных, собирает четырёх офисных сотрудников на час практики на своих документах. Замер «до» за неделю: типовой ответ на обращение — 40–60 минут, сводка месяца — полдня. Через квартал: ответ на обращение — 15–20 минут с проверкой, сводка — час; библиотека выросла до 14 промптов; журнал инцидентов содержит две записи (обе — необезличенные вставки, разобраны на планёрке, повтора нет).

Вопросы для разбора. Что в этом кейсе решающее: сервисы, регламент, замер или журнал инцидентов? Как директору представить результат учредителю, не преувеличивая? Почему две записи в журнале — признак здоровья, а не слабости?

Опорный разбор. Решающее — связка: регламент без замера дал бы «бумажное внедрение», замер без регламента — утечку. Представление учредителю — часы и инциденты: «освобождено ~N часов в месяц на документной работе, два инцидента обезличивания выявлены и закрыты обучением» — это язык управления. Журнал с записями говорит, что сотрудники не боятся сообщать об ошибках — значит, контур живой (раздел 9.4). Кейс эталонный не потому, что эффект велик, а потому, что он измерен и воспроизводим: так выглядит квартал 1 дорожной карты. Связь: разделы 9, 16.2.

Приложения

Семнадцать приложений с формами документов: приказы, регламенты, согласия, паспорта пилота и показателя, журналы, сценарии тренажёра, шаблоны отчётов. Все формы — проекты для адаптации: реквизиты учреждения и региональные требования подставляет ваш юрист.

Приложение 1. Глоссарий (рабочий, для приказов и совещаний)

Искусственный интеллект (ИИ) — технологии, выполняющие задачи, ранее требовавшие человеческого восприятия или речи: распознавание, прогноз, генерация текста. В документах учреждения термин применяется без оценки «умности» системы.

Большая языковая модель (LLM) — модель, обученная на массивах текстов и генерирующая связный текст по запросу. Пример применения: черновик ответа на обращение. Ограничение: может уверенно излагать неверные факты.

Галлюцинация модели — правдоподобное, но ложное утверждение в сгенерированном тексте (несуществующая статья закона, вымышленный реквизит). Правило учреждения: каждый факт из текста ИИ проверяется по источнику.

Промпт — текстовый запрос к модели. Проверенные промпты хранятся в библиотеке учреждения (приложение 4).

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому человеку. Фамилия + диагноз, номер комнаты + состояние — персональные данные даже без паспортных данных.

Специальные категории персональных данных — данные о здоровье, инвалидности и ряде иных; обрабатываются по усиленным правилам закона.

Биометрические персональные данные — данные, устанавливающие личность по физиологическим признакам (лицо для идентификации). В учреждении не используются (раздел 10).

Обезличивание — удаление из текста сведений, позволяющих определить человека. Минимум: фамилии, даты рождения, номера документов, номера комнат в связке с состоянием.

Компьютерное зрение (видеоаналитика) — распознавание событий в видеопотоке: падение, пересечение линии, скопление. В учреждении — только событийная, без идентификации личности.

Ложная тревога — срабатывание системы без реального события; порог фиксируется в паспорте пилота (приложение 7).

Пилот — опытное внедрение с заранее записанными метриками, сроком и критериями исхода.

Человек в контуре (human-in-the-loop) — решения о людях принимает человек; система лишь сигнализирует и готовит материалы.

Приложение 2. Карта шести направлений (одна страница для совещания)

Направление	Первая задача	Кто в контуре	Документы	Когда
А. Документы	Регламент + 5 промптов	Директор, секретарь	Прил. 3, 4	Квартал 1
Д. Обучение	Тренажёр на своих кейсах	Наставник, ответственный	Прил. 10	Квартал 2
Е. Аналитика	3 журнала в таблицы, паспорта показателей	Ответственный, старшие смен	Прил. 11	Квартал 2
В. Наблюдение	Датчики для 5–10 жителей по списку врача	Врач — обязательно	Прил. 6, 7, 9	Квартал 3
Г. Голосовые помощники	3–5 добровольцев	Специалист по соц. работе	Прил. 6	Квартал 3–4
Б. Видеоаналитика	Пилот на одном отделении, 90 дней	Ответственный, смена, юрист	Прил. 5, 6, 7, 8	Квартал 4

Правило карты: направление не начинается раньше своего квартала и не начинается вообще без своих документов. Направление Е (аналитика) идёт не «после данных», а для их создания: дисциплина записей — часть ступени.

Семь кандидатов за пределами А–Е (лекарственная логистика, график смен, реминисценция/музыка, дайджесты семье, подсветка журналов, питание и кухня, целостность кожи) — разделы 4.2–4.4; на дорожную карту они садятся после своих фильтров, не вместо этой таблицы. Робот-сиделка в эту строку не входит (раздел 23.5).

Приложение 3. Проект приказа «О порядке использования сервисов генеративного ИИ»

ПРИКАЗ № ____ от «» ____ 20__ г.

О порядке использования сервисов генеративного искусственного интеллекта

В целях повышения эффективности документной работы и недопущения разглашения персональных данных проживающих и работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить, что сервисы генеративного ИИ (далее — сервисы) применяются в учреждении для подготовки черновиков документов, сводок, планов и ответов на обращения.
2. Утвердить перечень допущенных сервисов: [наименования, выбранные учреждением]. Использование иных сервисов для рабочих задач не допускается.
3. Запретить передачу в сервисы персональных данных проживающих и работников: фамилий, инициалов в связке с состоянием или должностью, дат рождения, номеров документов, сведений о здоровье, номеров комнат в связке с проживающими. Тексты перед отправкой обезличиваются.
4. Установить, что документ, подготовленный с использованием сервиса, проверяется должностным лицом до подписания. Ответственность за содержание документа несёт подписавший. Ссылки на нормы права, реквизиты и факты из текста сервиса подлежат проверке по официальным источникам.
5. Запретить использование сервисов для: подготовки медицинских заключений и рекомендаций; решений, затрагивающих права проживающих; текстов, где фактическая ошибка способна причинить вред.
6. Назначить ответственным за ведение библиотеки проверенных промптов и журнала инцидентов [должность, ФИО]. Инциденты (отправка необезличенных данных, использование непроверенного текста) фиксируются и разбираются без применения дисциплинарных мер к сообщившему.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ / _____ /

Приложение 4. Библиотека проверенных промптов

Промпт — рабочий инструмент; каждый из десяти ниже проверяется на своих документах, после чего заносится в библиотеку с датой проверки и именем проверившего. Общая форма: роль → задача → исходный материал → формат результата → ограничения.

4.1. Сводка журнала смены. «Ты — помощник руководителя социального учреждения. Сведи следующий текст в 10 строк: что произошло за смену, что сделано, что требует решения руководства. Не добавляй фактов, которых нет в тексте. Текст: [обезличенный текст]».

4.2. Ответ на обращение гражданина. «Подготовь каркас официального ответа на обращение: подтверждение получения и регистрационный номер; суть ответа по пунктам обращения; сроки исполнения; контакт для вопросов. Тон — уважительный, без канцеляризмов. Обращение: [обезличенный текст]».

4.3. План занятий. «Составь план недельного цикла занятий для отделения: 5 дней по 2 занятия продолжительностью 30–40 минут; учитывай проживающих с нарушениями слуха и зрения; укажи необходимые материалы. Направления: лёгкая гимнастика, творчество, память и внимание, музыка».

4.4. Разбор протокола. «Из текста протокола совещания выдели три списка: принятые решения; поручения с ответственными и сроками; открытые вопросы. Не придумывай ответственных, которых нет в тексте. Протокол: [текст]».

4.5. Упрощение текста для семьи жителя. «Перепиши следующий служебный текст для родственника проживающего: сохрани все факты, убери канцеляризмы, объем — не более 150 слов, тон спокойный и уважительный. Текст: [обезличенный текст]».

4.6. Проверка письма. «Проверь письмо на канцеляризмы, длинные предложения (более 25 слов) и неясные места. Предложи правки списком: исходный фрагмент → правка → причина. Письмо: [текст]».

4.7. Каркас отчёта учредителю. «Составь структуру квартального отчёта учреждения социального обслуживания учредителю: разделы, ключевые показатели в каждом, места для таблиц и выводов. Не пиши сам отчёт — только структуру с пояснениями, что включить».

4.8. Сценарий беседы с новым сотрудником. «Подготовь план вводной беседы руководителя с новым сотрудником отделения: 10 вопросов и тем, порядок

знакомства с регламентами, типичные ошибки новичков, к кому обращаться. Объём — одна страница».

4.9. Сравнение вариантов. «Сравни два варианта решения задачи [описание задачи] по критериям: стоимость, сроки, риски, обратимость, влияние на проживающих. Вариант 1: [описание]. Вариант 2: [описание]. Сделай таблицу и вывод, каких данных не хватает для решения».

4.10. Инструкция по одному действию. «Напиши инструкцию из 5–7 шагов для сотрудника: [действие, например “как зафиксировать инцидент в журнале”]. Каждый шаг — одно действие, начинается с глагола. Добавь строку “частые ошибки” и строку “кому сообщить при проблеме”».

Правило библиотеки: промт, давший плохой результат дважды, переписывается — рядом хранятся старая версия и причина замены.

Приложение 5. Чек-лист договора с вендором + реестр систем

5.1. Чек-лист договора (проверяет юрист до подписания)

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
1	Данные — собственность учреждения	Вендор обрабатывает данные только по поручению; права на данные не переходят	
2	Территория хранения	Серверы на территории РФ; адреса/операторы названы	
3	Запрет обучения моделей	Данные учреждения не используются для обучения моделей вендора без отдельного письменного согласия	
4	Удаление при расторжении	Срок, порядок и акт об уничтожении данных после окончания договора	
5	Ответственность за утечку	Конкретная, не ограниченная стоимостью договора	
6	Право аудита	Учреждение вправе проверить условия хранения и обработки	
7	Условия выхода	Выгрузка всех данных в открытом формате (CSV/PDF), срок выгрузки, стоимость (ноль)	
8	Уровень сервиса	Время реакции на инцидент, канал поддержки, часы работы	

№	Пункт	Суть, которую должна содержать формулировка	Есть / нет
9	Изменение тарифов	Уведомление за 60 дней; право расторжения без штрафа при росте цены	

Строки 1–7 неснимаемые: отказ от любой — основание не заключать договор (раздел 17.5).

5.2. Реестр систем и данных (ведёт ответственный, пересмотр раз в квартал)

Система	Направление	Какие данные и где хранятся	Оператор, договор № / дата	Доступ (роли)	Срок хранения / проверено

Система, которой нет в реестре, работает вне правового контура.

Приложение 6. Формы уведомлений и согласий

Формы написаны языком, понятным жителю и семье; юрист адаптирует реквизиты. Каждая форма — один лист: длинное согласие не читают, а значит, оно не информированное.

6.1. Уведомление о видеонаблюдении (стенд + лист ознакомления)

«В общих помещениях учреждения (коридоры, холлы, столовая, входная группа) работает видеонаблюдение. Цель — безопасность проживающих: помощь при падениях, контроль входов, разбор происшествий. В комнатах проживания, санузлах и процедурных камер не установлены. Записи хранятся [срок] дней, доступ к ним имеют [должности], каждый просмотр фиксируется в журнале. По событию, касающемуся вас или вашего родственника, вы вправе запросить сведения о записи в порядке регламента. Ответственный: [должность, телефон]».

6.2. Согласие на установку датчика наблюдения (для жителя)

«Я, [ФИО], проживающий(ая) в комнате № __, соглашаюсь на установку в моей комнате датчика [тип: датчик движения под матрасом / датчик открытия двери / иной]. Датчик считает: [простыми словами — движение и сон; не снимает видео, не записывает звук]. Данные видят: медсестра смены и врач учреждения. Данные хранятся [срок] и затем удаляются. Я понимаю, что датчик не заменяет обходы и уход. Я могу отказаться в любой момент, сказав любому сотруднику или подав заявление, — датчик отключат в тот же день, и это никак не изменит мои услуги и отношение ко мне. Дата, подпись».

6.3. Согласие законного представителя (для жителя с когнитивными нарушениями)

Тот же текст плюс два пункта: «Желание проживающего выяснено: [не возражает / возражает — тогда установка не производится]» и «Пересмотр согласия — ежегодно, с участием врача». Подписи: представитель, врач, специалист по социальной работе.

6.4. Отзыв согласия

«Я, [ФИО], отзываю согласие на работу датчика [тип] в моей комнате. Прошу отключить датчик и удалить накопленные данные. Дата, подпись». *Регистрация:*

входящий номер, дата отключения, отметка об удалении данных — на том же листе.

6.5. Уведомление о событии (для жителя / представителя)

«[Дата, время] системой наблюдения зафиксировано событие: [падение / выход из зоны / сигнал датчика]. Принятые меры: [кто пришёл, что осмотрено, вызван ли врач]. Состояние оценено: [заключение]. Запись хранится [срок]. Разъяснения — у [должность, телефон]».

Приложение 7. Паспорт пилотного проекта (форма)

1. Задача. Какая измеримая боль решается (число «до»: например, среднее время обнаружения падения — 25 минут по журналам за 3 месяца).

2. Решение. Что именно тестируется: система, охват (отделение, число жителей/камер/устройств), вендор.

3. Люди. Ответственный; первые пользователи (2–3 человека из смен); врач (для направления В — обязательно); кто информирует жителей.

4. Документы до старта. Перечень по разделу 17.3 со ссылками на даты и номера: положение, согласия, договор, приказ. *Пилот без закрытого перечня не стартует.*

5. Срок. Даты начала и разбора (обычно 60–90 дней).

6. Метрики (записать до старта).

Метрика	«До»	Цель	Факт
[например, ложные тревоги на устройство в неделю]		≤ 2	
[время реакции смены, мин]			
[время персонала на систему, мин/сутки]			
[число отозванных согласий]	0	0	

7. Критерии исхода (подписываются до старта). Закрепить: [условия по метрикам]. Перенастроить и повторить один раз: [условия]. Закрыть: [условия, включая стоп-сигналы раздела 25.2].

8. Бюджет пилота. Разовые и ежемесячные расходы; источник.

9. Разбор. Дата, участники, решение (закрепить / перенастроить / закрыть), подписи директора и врача.

Архив: паспорт каждого пилота хранится независимо от исхода — это память учреждения о своих решениях (раздел 25.3).

Приложение 8. Положение о видеонаблюдении и видеоаналитике (проект)

1. Общие положения. Настоящее положение определяет цели, границы и порядок работы системы видеонаблюдения и видеоаналитики в учреждении. Положение размещается на информационном стенде.

2. Цели. Быстрое обнаружение падений и выхода проживающих из безопасной зоны; контроль входной группы; разбор происшествий. Использование системы для контроля труда работников не допускается, за исключением разбора чрезвычайных происшествий по решению директора с письменным оформлением.

3. Границы размещения. Камеры устанавливаются в общих помещениях: коридоры, холлы, столовая, входная группа. Не устанавливаются: комнаты проживания (кроме палат интенсивного наблюдения по решению врача и с согласия), санузлы, душевые, процедурные и перевязочные, помещения для переодевания персонала.

4. Режим аналитики. Система настраивается на распознавание событий (падение, пересечение линии, скопление) без идентификации личности. Функции распознавания лиц не подключаются.

5. Доступ и журнал. Доступ к просмотру в реальном времени — пост медсестры [дополняется]; доступ к архиву — директор, ответственный за цифровые проекты. Каждый просмотр архива фиксируется в журнале: дата, время, кто, основание, что просмотрено. Журнал хранится [срок] и доступен для проверки учредителем.

6. Хранение. Записи хранятся [30] дней, после чего удаляются автоматически. Фрагменты, относящиеся к происшествиям, изымаются на отдельный носитель актом и хранятся до завершения разбора.

7. Информирование. Проживающие, их представители и работники уведомляются при поступлении / приёме на работу по форме приложения 6.1; уведомление размещается на стендах.

8. Ответственность. Ответственный за систему — [должность]; за журнал доступа — [должность]. Нарушение настоящего положения (просмотр без основания, передача записей) — основание для служебного разбирательства.

Приложение 9. Маршрут эскалации тревожных событий (направление В)

Схема реакции на сигнал датчика наблюдения. Печатается на посту каждой смены, участвующей в пилоте.

Ступень 0. Сигнал. Датчик передаёт сигнал на панель поста: [тип сигнала — нет движения N часов / резкое изменение сна / выход из комнаты ночью]. Панель фиксирует время сигнала автоматически.

Ступень 1. Проверка (0–5 минут). Медсестра или сиделка поста подходит к комнате и оценивает обстановку лично. Сигнал никогда не «снимается» с панели без личной проверки. Исходы: всё в порядке (ложная тревога — фиксация в журнале одним касанием); ситуация неясна; есть проблема.

Ступень 2. Старшая смены (5–15 минут). При неясной ситуации вызывается старшая смены; при подтверждённой проблеме — немедленно врач или дежурный медработник по графику. Содержание сообщения: кто, комната, что показал датчик, что увидели глазами.

Ступень 3. Врач (немедленно — 30 минут). Врач осматривает жителя и принимает решение: наблюдение на месте / вызов скорой / уведомление семьи. Решение и основания фиксируются в листе события (форма 6.5).

Ступень 4. Семья и документы (до 24 часов). Уведомление представителя жителя по форме 6.5; запись в журнале событий и личном деле; сигнал и реакция заносятся в статистику пилота (паспорт — приложение 7).

Еженедельно. Ответственный и врач разбирают все сигналы недели: доля ложных, время реакции по ступеням, нужна ли перенастройка. Ежемесячно — свод в паспорт пилота.

Граница системы (печатается крупно под схемой): датчик не ставит диагнозов и не заменяет обходы. Любое решение о жителе принимает человек.

Приложение 10. Десять сценариев ИИ-тренажёра для персонала

Сценарии используются с любой доступной языковой моделью (регламент — приложение 3). Механика: сотрудник ведёт диалог, модель играет роль; после диалога модель по запросу разбирает диалог по критериям сценария. Данные жителей не используются — все персонажи вымышлены.

Стартовый промпт (общий): «Ты играешь роль [персонаж]. Отвечай коротко и естественно, как реальный человек в этой ситуации: можешь перебивать, обижаться, молчать. Не выходи из роли. Сцена: [ситуация]. Я — сотрудник учреждения. Начни первой репликой».

1. Отказ от еды. Персонаж: житель 82 лет, третий день «не хочет есть, оставьте». Критерии разбора: сотрудник выяснял причины, а не уговаривал; не давил; назвал следующий шаг (сообщить медсестре/врачу).

2. «Мне украли вещи». Персонаж: жительница с когнитивными нарушениями обвиняет сиделку в краже очков. Критерии: не спорил с обвинением, не обещал; помог искать; зафиксировал и сообщил старшей смены.

3. Родственник с претензией. Персонаж: взрослый сын жителя, громко требует «положить отца в отдельную комнату, я плачу». Критерии: спокойствие; перевод разговора к регламенту и записи на приём к руководству; без обещаний вне компетенции.

4. Ночной стук в дверь. Персонаж: жительница ночью «не пускает спать»: просит позвонить умершему мужу. Критерии: участие без лжи («сейчас позвоним») и без грубой правды; успокоил, остался рядом, сообщил смене.

5. Отказ от гигиены. Персонаж: житель неделю отказывается от мытья, на предложения отвечает грубо. Критерии: искал причину (боль, страх, холод); предлагал выбор и участие; не применял давление; передал врачу.

6. Конфликт соседей по комнате. Персонаж: жилица просит «убрать эту» соседку, которая «всю ночь стонет». Критерии: выслушал обе стороны (второй диалог); не пообещал невозможного; предложил варианты и сообщил руководству.

7. «Я хочу домой». Персонаж: недавно поступивший житель плачет и требует отпустить домой. Критерии: признал чувства; не читал нотаций о «тут же лучше»; выяснил, кого можно позвать; сообщил психологу/соцработнику.

8. Скрытое недомогание. Персонаж: житель отрицает плохое самочувствие («нормально всё»), но бледен и держится за бок. Критерии: заметил и назвал наблюдение; не принял отказ как финальный; вызвал медика несмотря на «не надо».

9. Просьба нарушить правило. Персонаж: житель просит вынести ему «одну сигаретку на веранду, никто не узнает». Критерии: отказал без нравоучений; предложил допустимую альтернативу по регламенту; сохранил отношения.

10. Смерть соседа. Персонаж: жительница спрашивает, где её соседка по комнате (та ночью умерла). Критерии: не солгал; сказал правду бережно и по возрасту/состоянию собеседника; остался рядом; привлёк психолога.

Правило: после каждого диалога — живой разбор 15 минут с наставником (раздел 14); тренажёр не заменяет наставничество и не служит аттестации.

Приложение 11. Паспорт показателя (форма)

Заполняется на каждый показатель, попадающий в панель управления или отчёт учредителю. Показатель без паспорта в отчёт не идёт — это защита от решений по «числам, которые все понимают по-разному».

1. Название показателя. Как в отчёте, дословно.

2. Определение. Что именно считается, словами: «число падений проживающих, зафиксированных в журнале событий, на 1000 койко-дней».

3. Формула и единицы. Числитель, знаменатель, период.

4. Источник данных. Документ/журнал, кто вносит, когда.

5. Ответственный за качество. Фамилия и должность — кто проверяет полноту и достоверность, и как (выборочный аудит: 10 записей в месяц).

6. Известные искажения. Что портит показатель: сезонность, изменение контингента, недозаполнение журнала в праздники.

7. Порог реакции. При каком значении/изменении показатель разбирается на совете (не «стало хуже», а «выше N или рост на M% два периода подряд»).

8. Связанные решения. Какие решения принимаются по этому показателю и кем.

Пример — показатель «время обнаружения падения»: источник — журнал событий и панель видеоаналитики; искажение — падения вне зон камер; порог реакции — превышение 10 минут.

Приложение 12. Формы журналов цифрового контура

Три журнала, которые ведёт ответственный. Форма — электронная таблица; бумажный дубль не нужен, если есть резервная копия (раздел 21.2).

12.1. Журнал инцидентов генеративного ИИ

№	Дата	Сотрудник (роль)	Что произошло	Обезличивание нарушено? (да/нет)	Что сделано	Правка в регламент/библиотеку
1						

Правило: заполнение журнала не влечёт дисциплинарных мер к сообщившему (приказ — приложение 3, п. 6). Пустой журнал при живом использовании сервисов — тревожный признак, а не хороший.

12.2. Журнал доступа к видеозаписям

№	Дата и время	Кто просматривал	Основание (событие, заявление, № обращения)	Что просмотрено	Результат	Подпись
1						

Каждый просмотр архива фиксируется — это требование положения о видеонаблюдении (приложение 8) и главный ответ на вопрос «кто смотрит записи».

12.3. Журнал сигналов систем наблюдения

№	Дата, время	Житель (код, без ФИО)	Тип сигнала	Проверка (время, кто)	Исход (ложный / событие / эскалация)	Время реакции, мин	Комментарий врача
1							

Из этого журнала автоматически считаются метрики паспорта пилота (приложение 7): доля ложных, время реакции, отозванные согласия.

Приложение 13. Регламент информирования семьи (проект, один лист)

«Как мы информируем вас» — выдаётся семье при поступлении жителя, подписывается обеими сторонами.

- 1. Сразу сообщаем:** событие со здоровьем (вызов врача, скорой, госпитализация), травма, уход с территории, срабатывание систем наблюдения (форма 6.5) — звонок в течение суток с номера [номер].
- 2. По расписанию:** раз в месяц — короткое сообщение о делах и настроении жителя по выбранному каналу: [звонок / мессенджер / письмо]. Раз в квартал — встреча или рассылка о жизни учреждения, включая технологии.
- 3. По запросу:** на ваши вопросы отвечаем не более чем за три рабочих дня; ответственный — [должность, телефон, часы].
- 4. Если ответ не устроил:** приём у руководителя — в течение недели по записи через [телефон].
- 5. Чего мы не делаем:** не передаём сведения о жителе по неподтверждённым каналам и не предоставляем онлайн-доступ к видеозаписям — это защищает самого жителя (раздел 18.5). Записи по событию доступны в порядке положения о видеонаблюдении.

Контакт семьи для срочных сообщений: [ФИО, телефон, канал]. Подписи сторон, дата.

Приложение 14. Проект приказа о пилотном проекте

ПРИКАЗ № ____ от «» ____ 20__ г.

О проведении пилотного проекта [название]

В целях проверки эффективности [система] для решения задачи [измеримая боль, число «до»], на основании решения совета учреждения от [дата]

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести пилотный проект в период с [дата] по [дата] на [охват: отделение, число жителей/устройств] в соответствии с паспортом пилотного проекта (приложение к приказу).
2. Назначить ответственным за пилот [должность, ФИО]; первыми пользователями — [ФИО]; куратором от медицинской службы — [ФИО].
3. Утвердить паспорт пилотного проекта с метриками и критериями исхода (приложение 7 к докладу — применяется как форма).
4. Ответственному: до старта — обеспечить документный комплект по разделу 17.3 (положение, согласия, уведомления, договор); в период пилота — вести журналы (приложение 12), еженедельные разборы; по завершении — представить результаты совету в течение 14 дней.
5. Решение о закреплении, перенастройке или закрытии принимается советом на основании метрик против критериев и оформляется протоколом.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор _____ / _____ /

Приложение 15. Годовой отчёт учредителю о цифровых проектах (шаблон)

Шаблон из восьми разделов — по итогам года работы дорожной карты (раздел 16.5). Два правила: только измеренное и оба знака результата (что сработало и что закрыто).

1. Что внедрено. Перечень направлений со статусом: работает / пилот / закрыто по критериям / отложено с основанием.

2. Что измерено. Таблица: метрика — «до» — «после» — период — источник данных. Числа без источника не приводятся.

3. Эффект в часах и деньгах. Освобождённое время персонала (часы/месяц по направлениям); расходы по шести строкам полной стоимости (раздел 22.1); избегаемые потери — только там, где есть задокументированные случаи.

4. Правовой контур. Реестр систем, изданные приказы и положения, согласия (число действующих/отозванных), инциденты и их разбор, уведомления Роскомнадзора (были/не было).

5. Люди. Обучение: кто прошёл, что измерено; мнение смен (короткий опрос: помогает/мешает); первые пользователи.

6. Что закрыто и почему. Пилоты, завершённые закрытием: метрики против критериев, решение совета, что сохранено. Этот раздел — не «провалы», а доказательство управляемости (кейс 12).

7. Риски и ограничения. Честный список: слепые зоны, зависимость от вендоров, кадровые риски (единственный носитель экспертизы), что по этим рискам делается.

8. План на следующий год. Ступени с метриками и точками остановки; потребность в средствах — с трёхлетней стоимостью, а не ценой входа.

Приложение 16. Повестка планёрки запуска направления А (60 минут)

Готовая повестка первого совещания по внедрению — чтобы первый шаг не превратился в «поговорили и разошлись».

Минуты 0–5. Зачем собрались. Директор: одна измеримая боль (назвать число «до» — часы на типовые документы), решение о старте, кто ответственный.

Минуты 5–15. Показ. Ответственный на живом примере: тот же документ — вручную и с сервисом; разница во времени; сразу показана «галлюцинация» на заведомо проверочном вопросе — коллектив должен увидеть ошибку модели своими глазами.

Минуты 15–25. Регламент. Чтение приложения 3 по пунктам с примерами: что можно, что нельзя, что с персональными данными. Вопросы — фиксируются, ответы дополняют регламент в течение недели.

Минуты 25–40. Практика. Каждый участник на своём документе: обезличить текст, провести через проверенный промпт, проверить результат. Два человека показывают всем — обучение через показ.

Минуты 40–50. Замер. Договорённость: кто и как мерит время на типовые документы две недели «после»; дата промежуточного разбора.

Минуты 50–60. Журнал инцидентов и страхи. Как сообщать об инциденте и почему сообщивший не наказывается; прямой ответ на «нас заменят?» — решение директора вслух (раздел 19.2).

Итог планёрки (пишется в протокол одной строкой): ответственный, список сервисов, четыре человека обучены, замер запущен, дата разбора.

Приложение 17. Опрос смены после пилота (десять вопросов)

Короткий анонимный опрос проводится через 30 и 90 дней пилота среди всех сотрудников, контактировавших с системой. Десять утверждений — оценка от 1 («совсем нет») до 5 («полностью да») плюс одно открытое поле. Опрос занимает три минуты и заполняется на планёрке.

1. Я понимаю, для чего работает эта система.
2. Мне объяснили мои действия по её сигналам — и я эти действия выполнял(а).
3. Система не мешает моей обычной работе.
4. Сигналы системы в основном приходят «по делу».
5. Когда я сообщал(а) о ложной тревоге, это было принято без упрёка.
6. Я вижу, что система помогла хотя бы одному жителю.
7. Записи и данные системы не используются против сотрудников.
8. Если завтра систему выключат, мне будет её не хватать.
9. Я бы посоветовал(а) коллегам с другого отделения такую же.
10. Я понимаю, к кому идти, если система работает странно.

Открытое поле: «Что вы бы изменили в первую очередь?» — самые ценные строки опроса читаются на совете вслух.

Интерпретация: средние ниже 3 по пунктам 2, 4, 6 — сигнал остановиться и разобраться до продления пилота; пункт 7 ниже 3 — аварийный сигнал доверия, разбор немедленно (раздел 19.2). Результаты прикладываются к паспорту пилота (приложение 7) — мнение смены является метрикой исхода.

Список источников

Ссылки в тексте доклада даны верхними индексами. Все источники — открытые; проверены по состоянию на июль 2026 года. Нормативные акты приводятся в действующих редакциях — перед использованием формул в приказах сверьте редакцию по официальному portalу правовой информации.

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (действующая редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
2. Статья 16 Закона № 152-ФЗ: права субъекта при решениях на основе исключительно автоматизированной обработки персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/22e884a41450dcb5cb62d956583ad32abe2bbbe9/
3. Федеральный закон от 30.11.2024 № 420-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ»: штрафы за утечки персональных данных, в том числе оборотные; обязанность уведомления Роскомнадзора об инцидентах (24 часа — первичное, 72 часа — отчёт). URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/87300.html>
4. Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» с Национальной стратегией развития ИИ на период до 2030 года (в редакции Указа от 15.02.2024 № 124). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
5. Федеральный закон от 29.12.2022 № 572-ФЗ о единой биометрической системе и обработке биометрических персональных данных. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_436110/
6. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/
7. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
8. Московский эксперимент по применению компьютерного зрения в лучевой диагностике: описание и первые результаты (научная публикация; портал эксперимента — mosmed.ai). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/moskovskiy-eksperiment-po-primeneniyu-kompyuternogo-zreniya-v-luchevoy-diagnostike-vovlechenost-vrachey-rentgenologov>

9. Социальный фонд России: проактивное (беззаявительное) назначение пенсий и мер социальной поддержки. URL: https://sfr.gov.ru/about/union_pfr_fss_page/
10. Права субъектов персональных данных при автоматизированных решениях: разъяснение условий ч. 2–4 ст. 16 Закона № 152-ФЗ (Гарант). URL: <https://www.garant.ru/actual/persona/prava/>
11. Практика применения норм об уведомлении Роскомнадзора об утечках: порядок, сроки, штрафы, судебная практика 2025–2026 годов (обзор). URL: <https://www.klerk.ru/user/2689193/698844/>
12. Российские генеративные модели, доступные учреждениям: GigaChat (Сбер) — <https://developers.sber.ru/portal/products/gigachat>; YandexGPT (Яндекс Облако) — <https://cloud.yandex.ru/services/yandexgpt>

Дополнение августа 2026: научные публикации 2024–2026 годов

Рецензируемые источники, подтверждающие выводы доклада (добавлены при обновлении; проверены 02.08.2026).

13. [S045] Ronan I., Tabirca S., Murphy D., Cornally N. et al. «Artificially intelligent nursing homes: a scoping review of palliative care interventions» — *Frontiers in Digital Health*, 2025. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/digital-health/articles/10.3389/fdgth.2025.1484304/full> — скопинг-обзор ИИ-вмешательств в домах ухода; подтверждает классификацию направлений доклада.
14. [S046] Wong K.L.Y., Hung L., Wong J., Park J., Alfares H., Zhao Y. et al. «Adoption of artificial intelligence-enabled robots in long-term care homes by health care providers: scoping review» — *JMIR Aging*, 2024. URL: <https://aging.jmir.org/2024/1/e55257/> — барьеры внедрения: регламент, обучение, доверие персонала, а не техника.
15. [S047] Gorce P., Jacquier-Bret J. «Fall detection in elderly people: a systematic review of ambient assisted living and smart home-related technology performance» — *Sensors*, 2025. URL: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6540> — разброс точности и доля ложных срабатываний ambient-систем; обоснование порога ложных тревог в паспорте пилота.
16. [S048] Mess S.A., Mackey A.J. et al. «Artificial intelligence scribe and large language model technology in healthcare documentation: advantages, limitations, and recommendations» — 2025. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11737491/> — ИИ-секретари в клинической документации; обязательность проверки человеком (принцип «человек в контуре»).

17. [S049] Kim Y., Jeong H., Chen S., Li S.S., Park C., Lu M. et al. «Medical hallucination in foundation models and their impact on healthcare» — medRxiv, 2025. URL: <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.02.28.25323115.abstract> — самая цитируемая свежая работа о галлюцинациях медицинских моделей; обоснование мер «подпись человека» и «обучение на своих сценариях».

Дополнение сентября 2026: инженерия генеративного ИИ (опора для терминов, рисков и внедрения)

Отобраны из курируемого списка Awesome Artificial Intelligence как источники, полезные докладу об ИИ в домах социального обслуживания: риски, этика, агентные паттерны, RAG и объяснимость для персонала. Глубокий MLOps и coding agents намеренно не включены — они не соответствуют аудитории семинара. Проверены 05.09.2026.

18. [S050] OWASP Top 10 for Large Language Model Applications — OWASP GenAI Security Project. URL: <https://genai.owasp.org/llm-top-10/> — чеклист рисков LLM-приложений (утечки промпта, отравление данных, чрезмерная автономия); опора для разделов о безопасности, типовых ошибках и критериях отказа.
19. [S051] Anthropic. «Building Effective Agents» — engineering guide. URL: <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents> — практические паттерны агентных систем и компромиссы; когда нужен управляемый workflow, а не «умный чат»; опора для классов ИИ, дорожной карты и прикладных направлений.
20. [S052] OpenAI. «A Practical Guide to Building Agents» — business guide (PDF). URL: <https://cdn.openai.com/business-guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-agents.pdf> — модели, инструменты, инструкции, оркестрация и guardrails; язык для паспорта пилота и сценариев обучения персонала.
21. [S053] Lewis P. et al. «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks» — arXiv:2005.11401. URL: <https://arxiv.org/abs/2005.11401> — сочетание языковой модели с внешним поиском по документам; обоснование схемы «ИИ + локальные регламенты учреждения», а не «модель всё знает».
22. [S054] Yao S. et al. «ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models» — arXiv:2210.03629. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.03629> — цикл «рассуждение → действие» для инструментных ассистентов; опора для терминов и голосовых/документных помощников.
23. [S055] Ouyang L. et al. «Training Language Models to Follow Instructions with Human Feedback» (InstructGPT) — arXiv:2203.02155. URL: <https://arxiv.org/abs/2203.02155>

— instruction tuning и RLHF; почему чат-модели слушаются инструкций и где граница доверия; опора для FAQ и раздела «что такое ИИ».

- 24. [S056]** Bai Y. et al. «Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback» — arXiv:2212.08073. URL: <https://arxiv.org/abs/2212.08073> — обучение помощника по явным принципам; близко к логике доклада «факт / интерпретация / рекомендация» и к этическому контуру.
- 25. [S057]** Anthropic. Prompt Engineering overview — документация Claude. URL: <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview> — критерии успеха, тестирование промптов, улучшение поведения модели; практическая опора для обучения персонала и сценариев тренажёра.

Дополнение сентября 2026: материалы Хабра (канал @habr_ai)

Отобраны из публичной ленты Telegram-канала «Хабр / ML & AI» как первоисточники, полезные докладу. Проверены 05.09.2026. Остальная лента канала (MLOps, железо, узкий код, хайп моделей) намеренно не включена.

- 26. [S058]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078722/> — практическая схема: зарубежные публичные LLM без поручения; российский контур с договором поручения или своё железо; обезличивание как основной приём.
- 27. [S059]** «Цифровая амнезия: почему ИИ-стратегия тотального исключения человека в банках может завести в тупик?» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078718/> — классификация HITL / HOTL / HOOTL и риски полной автономии для сервиса и персонала; опора для принципа «человек в контуре».
- 28. [S060]** «Claude Code взломали просьбой пересказать сайт» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1078702/> — многошаговая атака на агента: цепочка «безопасных» шагов и композиционный риск; урок для изоляции и недоверия к отчёту модели как аудиту.
- 29. [S061]** «Как AI меняет фарму: опыт «АстраЗенека» в России и в мире» — Хабр / AstraZeneca, 2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/astrazeneca/articles/1078636/> — внедрение ИИ в регулируемой отрасли при human-in-the-loop; параллель для соцобслуживания.
- 30. [S062]** «Что умеет ассистент по умолчанию на Android — на примере Алисы AI» — Хабр / Яндекс, 2026. URL: <https://habr.com/ru/companies/yandex/articles/1078580/> — границы системных разрешений голосового ассистента; контекст экрана только после явного вызова пользователем.

- 31. [S063]** «Сотрудники сливают данные в чужой ИИ...» — Хабр, 2026. URL: <https://habr.com/ru/articles/1057128/> — трансграничная передача и локализация при вставке ПД в зарубежный чат-бот; усиление раздела про случайные утечки.

Дополнение сентября 2026: углублённый отбор Хабра (@habr_ai + хабы ИИ/ML)

Отобраны после полного прохода публичной ленты канала и хабов; чистая LTC-тематика на Хабре редка, поэтому включены прямые кейсы ПНИ и переносимые источники по ПДн, HITL, Shadow AI, голосу, RAG и регуляторам РФ. Проверены 05.09.2026.

- 32. [S064]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 1: Mattermost + ИИ-ассистент» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/940540/> — on-prem ассистент для персонала ПНИ: локальная сеть, без публичных портов, запрет отправки ПДн во внешнюю модель.
- 33. [S065]** «Как я внедрял ИИ в психоневрологическом интернате. Часть 2: RAG на документах организации» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/941296/> — RAG по локальным приказам/отчётам для ответов на запросы надзора.
- 34. [S066]** «LLM, персональные данные и 152-ФЗ» (ранняя развёрнутая версия) — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1048334/> — дополняет S058: поручение, локализация, Yandex Cloud / GigaChat / зарубежный API.
- 35. [S067]** «Вы уверены, что знаете, что такое human-in-the-loop?» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1050556/> — декоративный HITL vs реальное право остановить систему; automation bias.
- 36. [S068]** «Какую роль должен играть ИИ в психологической помощи?» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1067568/> — ИИ как копилот, не замена; HITL в уходе/поддержке.
- 37. [S069]** Shadow AI: красные / зелёные / серые задачи — Хабр / Alpina Digital. URL: <https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1039346/> — governance теневого использования публичных LLM персоналом.
- 38. [S070]** «Как команда становится AI Native: методология из 4 этапов» — Хабр / Alpina Digital. URL: <https://habr.com/ru/companies/alpinadigital/articles/1040754/> — обучение и закрепление, а не разовый тренинг.
- 39. [S071]** «Маскируем чувствительные данные при отправке в ИИ-чат» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1071398/> — практическое обезличивание перед чатом.

- 40. [S072] Cloud.ru Guardrails Filter — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/cloud_ru/articles/1061546/ — прокси-маскирование ПДн к LLM.
- 41. [S073] «Почему промпт-инъекцию нельзя починить» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1031542/> — архитектурные пределы безопасности агентов.
- 42. [S074] «Иллюзия контроля: почему промпты не защищают ИИ-агентов» — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1050772/> — обход ограничений цепочками легитимных действий.
- 43. [S075] «Пять документов ломают ваш RAG» — Хабр / OTUS. URL: <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/1029742/> — отравление базы знаний / недоверенный контекст.
- 44. [S076] Hybrid RAG без облака — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1024696/> — поиск по документам с контролем данных.
- 45. [S077] Голосовой ИИ-агент врал клиентам — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1053502/> — риски голосовых агентов; лечится структурой, не промптом.
- 46. [S078] Безопасность и приватность голосового управления (152-ФЗ) — Хабр. URL: <https://habr.com/ru/articles/1023434/> — голос + разрешения + 152-ФЗ.
- 47. [S079] НМИЦК Чазова + ИИ + обезличивание — Хабр / Yandex Cloud. URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_cloud_and_infra/articles/1042516/ — клинический пайплайн с обезличиванием ПДн.
- 48. [S080] Методические рекомендации Банка России № 3-МР по безопасности ИИ — Хабр. URL: https://habr.com/ru/companies/swordfish_security/articles/1063648/ — категории рисков + обязательная человеческая валидация высокорисковых процессов (переносимо).

Дополнение сентября 2026: международные обзоры LTC и практика

Рецензируемые обзоры и политический доклад — опора для доказательной скромности. Пункт 53 — не научное доказательство, а живой язык практики (обсуждения медсестёр и семей). Проверены 05.09.2026.

- 49. [S081] Imran R., Khan S.S. «A systematic review on the efficacy of artificial intelligence in geriatric healthcare» — BMC Geriatrics, 2025;25:248. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12877-025-05878-w> — систематический обзор ИИ в LTC: слабый консенсус по эффективности; соцроботы — лучшие данные по настроению/одиночеству; высокий риск bias.
- 50. [S082] «Artificial Intelligence in Nursing Care for Older Adults in Long-Term Care Facilities: An Umbrella Review» — JMIR Preprints #96479. URL: <https://preprints.jmir.org/preprint/96479>

rg/preprint/96479 — umbrella-обзор: 5 классов применений; барьеры — ложные тревоги, приватность, ломка workflow; качество первичных обзоров низкое/критически низкое.

- 51. [S083] OECD. «Scaling Artificial Intelligence in Health» — 2026. URL: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/04/scaling-artificial-intelligence-in-health_77610b12/a436e12d-en.pdf — политика масштабирования ИИ в здравоохранении: доверие, данные, oversight.
- 52. [S084] medRxiv / fall documentation with obfuscated CV (AUGi) — <https://doi.org/10.1101/2025.10.10.25337770> — детекция падений с силуэтом/пикселизацией; сырое видео не хранится (по описанию производителя).
- 53. [S085] Обсуждения практикующих медсестёр и семей на Reddit (r/nursing, r/eldercare, r/AssistedLiving, 2019–2026) о камерах, telesitter, кроватных датчиках и роботах в уходе — см. подборку тезисов в главах; не рецензируемый источник, а живой язык практики. Примеры тредов: <https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1vxbhmm/> ; <https://www.reddit.com/r/AssistedLiving/comments/1m4ydbk/> ; <https://www.reddit.com/r/nursing/comments/1ujj7fq/> ; <https://www.reddit.com/r/eldercare/comments/1lwrieg/>

Дополнение сентября 2026: пробелы применений для ДСО

Пять направлений, которых нет в карте А–Е, но которые встречаются в открытых источниках по домам ухода и смежным стационарам. Не шестая строка «американский биллинг / реферал». Проверены 05.09.2026. Пункты 58 и 60 — язык практики и пресс вендора, не рецензируемые обзоры.

- 54. [S086] Au-Doung P.L.W., Chau H.C., Wong C.H., Lau K.C., Chan Y.Q., Yip H.L., Hung C.N., Tai B.-W.B., Lam T.T.-N., Lee C.P., Chiang S.C., Cheung Y.T. «Implementation of an Electronic Medication Management System in 41 Residential Care Homes in Hong Kong: Pre-Post Interventional Study» — JMIR Aging, 2025;8:e79262. URL: <https://aging.jmir.org/2025/1/e79262/> — doi:10.2196/79262. Электронная раскладка, сверка и выдача доз в 41 RCHE (3911 жителей); рост числа обработанных доз на единицу времени и самооценки компетенций персонала. Это лекарственная логистика, не «ИИ-врач».
- 55. [S087] Das D.C., Rony M.K.K., Dutta S. et al. «The Role of Artificial Intelligence in Medication Management for Older Adults: A Systematic Review» — Aging Medicine, 2026;9(2):196–213. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13163944/> — doi:10.1002/agm2.70074. 29 исследований: умные напоминания, подсказки по

полипрагмазии и сложным схемам — к специалисту; этика, доверие и человеческий надзор; гибридные модели, а не автономное назначение.

- 56. [S088]** Kang H.W., Kim J., Kim K.J. et al. «Shift nurses' work quality and job satisfaction after implementing the Inha University hospital nursing AI scheduling system (IH-NASS)» — BMC Nursing, 2025;24:792. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12210576/> — doi:10.1186/s12912-025-03470-6. Открытый больничный кейс ИИ-расписания смен (14 отделений, 253 медсестры): меньше «нездоровых» стыков смен, больше спаренных выходных; график утверждает человек.
- 57. [S089]** Leung F., Lau Y.C., Law M., Djeng S.K. «Artificial intelligence and end user tools to develop a nurse duty roster scheduling system» — International Journal of Nursing Sciences, 2022;9(3):373–377. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9305000/> — doi:10.1016/j.ijnss.2022.06.013. Открытый контур составления дежурного графика по жёстким и мягким ограничениям; черновик за минуты, правки — у старшей смены.
- 58. [S090]** Thomas J. «How AI Is Changing Dementia Care and Long-Term Care Services» — LTC News, 26.05.2026. URL: <https://www.ltcnews.com/articles/how-ai-is-changing-dementia-care-and-long-term-care-services> — язык практики (не рецензия): персонализированная музыка и реминисцентные подсказки; ИИ не заменяет уход, суждение и присутствие персонала.
- 59. [S091]** Abadir M., Dineen W., Myers D., Yu S., Phan P. «Navigating the future of artificial intelligence technologies for improving the care of older adults» — Innovation in Aging, 2025;9(Suppl 1):S24–S32. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12742854/> — doi:10.1093/geroni/igaf092. Рамка 4Ms (What Matters, Medication, Mentation, Mobility): голосовые помощники, музыка, когнитивная поддержка; достоинство и человеческий уход — условие, а не опция.
- 60. [S092]** PointClickCare. «PointClickCare Launches Advisor Suite, Expanding AI-Native Workflow Automation Solutions for Skilled Nursing» — пресс-релиз, 02.06.2026. URL: <https://pointclickcare.com/press-releases/pointclickcare-launches-advisor-suite-expanding-ai-native-workflow-automation-solutions-for-skilled-nursing/> — отраслевой пресс, не рецензия. Берём идею Chart Advisor (дыры в документации и ситуации высокого риска — человеку на разбор). Referral Advisor, Billing Advisor и MDS/PDPM-скоринг для российских ДСО не рекомендуются.

Дополнение сентября 2026: Parallel — питание и усиление Ж–Л

Рецензируемые источники по операционной кухне, моделям недоедания (больница ≠ дом ухода), текстуре при дисфагии и уточнению кандидатов Ж–Л. Aging

Medicine 2026 по лекарственному сопровождению уже есть как пункт 55 / [S087] — не дублируем, перекрёстно цитируем. Проверены 05.09.2026.

- 61. [S093]** Liu Z., Satyanarayana K.C., Chaitanya Koppisetty A.K., Rousta K., Brancoli P. «Tackling food waste in nursing homes: A measurement method using smart bins» — *Waste Management*, 2025;203:114858. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40328146/> — doi:10.1016/j.wasman.2025.114858. Дом ухода в Буресе (Швеция): «умный» контейнер измеряет и характеризует пищевые отходы. Обед в среднем 78 г/порция (52 % с тарелки, 48 % с раздачи), ужин 58 г (68 % / 31 %). Операционный учёт, не клинический диагноз недоедания.
- 62. [S094]** Mancin S., Ferrara G., Lopane D., Cangelosi G., Petrelli F., Morales Palomares S., Sguanci M. «Artificial intelligence in the management of hospital malnutrition: A systematic review» — *Clinical Nutrition ESPEN*, 2025;70:542–553. URL: [https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577\(25\)02960-2/fulltext](https://www.clinicalnutritionespen.com/article/S2405-4577(25)02960-2/fulltext) — doi:10.1016/j.clnesp.2025.10.002. 12 больничных работ; в части исследований AUC выше 90 %. Это стационар, не дом ухода; внедрение требует данных, обучения персонала и этики. Модели — кандидат в алерты, не в диагноз.
- 63. [S095]** Janssen S.M.W., Bouzembrak Y., Tekinerdogan B. «Artificial Intelligence in Malnutrition: A Systematic Literature Review» — *Advances in Nutrition*, 2024;15(9):100264. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S216183132400098X> — doi:10.1016/j.advnut.2024.100264. Открытый доступ. Больше 90 % ИИ-моделей недоедания не входят в повседневную клиническую практику.
- 64. [S096]** Raheem D., Carrascosa C., Ramos F., Saraiva A., Raposo A. «Texture-Modified Food for Dysphagic Patients: A Comprehensive Review» — *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021;18(10):5125. URL: <https://www.mdpi.com/1660-4601/18/10/5125> — doi:10.3390/ijerph18105125. Текстура при дисфагии — клиническая и пищевая задача (безопасность глотка, нутриенты), не решение камеры по фото тарелки.
- 65. [S097]** Bringhurst K., Jones T., Runko G. et al. «Artificial Intelligence in the Management of Polypharmacy Among Older Adults: A Scoping Review» — *Cureus*, 2025;17(8):e90867. URL: <https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review> — doi:10.7759/cureus.90867. PDF: <https://www.cureus.com/articles/393794-artificial-intelligence-in-the-management-of-polypharmacy-among-older-adults-a-scoping-review.pdf>. 5 работ: флаги взаимодействий и PIM, напоминания — к специалисту; рекомендации модели требуют врачебной валидации. Усиливает кандидата Ж; не отменяет пункт 55 / [S087].

66. [S098] Mystakidis A., Koukaras C., Koukaras P., Kaparis K., Stavrinides S.G., Tjortjis C. «Optimizing Nurse Rostering: A Case Study Using Integer Programming to Enhance Operational Efficiency and Care Quality» — Healthcare, 2024;12(24):2545. URL: <http://www.mdpi.com/2227-9032/12/24/2545> — doi:10.3390/healthcare12242545. Целочисленная оптимизация графика медсестёр в онкологическом отделении: ограничения, черновик, человек утверждает. Доказательная база не-LTC — так и читаем для кандидата З.
67. [S099] Shirsat A., Jha R.K., Verma P. «Music Therapy in the Treatment of Dementia: A Review Article» — Cureus, 2023;15(3):e36954. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10151115/> — doi:10.7759/cureus.36954. Обзор музыки как нефармакологической поддержки при деменции; не лицензия обещать лечение возбуждения плейлистом.
68. [S100] McCreedy E.M., Sisti A., Gutman R. et al. «Pragmatic Trial of Personalized Music for Agitation and Antipsychotic Use in Nursing Home Residents with Dementia» — Journal of the American Medical Directors Association, 2022;23(7):1171–1177. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9256757/> — doi:10.1016/j.jamda.2021.12.030. Кластерное прагматическое испытание в 54 домах ухода (976 жителей): персональная музыка значимо не снизила возбуждение и психотропные препараты. Для кандидата И — без лечебных обещаний.
69. [S101] Perkins S.W., Muste J.C., Alam T., Singh R.P. «Improving Clinical Documentation with Artificial Intelligence: A Systematic Review» — Perspectives in Health Information Management, 2024;21(2):1d. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11605373/> — PMID:40134899. Обзор ИИ-документации в клинике: качество и время черновика, не автоподпись карты и не дописывание журнала с датчиков/аудио. Усиливает кандидата Л.
70. [S102] European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. «Artificial Intelligence in healthcare» — официальная страница. URL: https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/artificial-intelligence-healthcare_en — высокорисковые системы ИИ медицинского назначения: качество данных, понятная информация пользователю, человеческий надзор (AI Act). Европейский ориентир, не российский закон; тот же принцип «человек в контуре».

Дополнение сентября 2026: зарубежный LTC — кожа, DHT, Eurocarers, соцработы

Переносимый зарубежный опыт для кандидата Н (целостность кожи), европейской рамки DHT / healthy aging и этики семьи; голландские HI-SAR — только в раздел «где ИИ не нужен», не в карту кандидатов. Проверены 05.09.2026. Пункты 71 и 72–73 — одна линия «фото → медсестре», не автолечение. Пункт 76 — страница института, не рецензия.

- 71. [S103]** Lau C.H., Yu K.H.-O., Yip T.F., Luk L.Y.F., Wai A.K.C., Sit T.-Y., Wong J.Y.-H., Ho J.W.K. «An artificial intelligence-enabled smartphone app for real-time pressure injury assessment» — *Frontiers in Medical Technology*, 2022;4:905074. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9541137/> — тот же текст: <https://www.frontiersin.org/journals/medical-technology/articles/10.3389/fmedt.2022.905074/full> — doi:10.3389/fmedt.2022.905074. Смартфонная постановка стадии пролежня для carer дома ухода, когда раневой эксперт не на площадке. Валидация 144 фото: общая точность 63,2 %; специфичность 85,1–100 %; чувствительность стадии 2 — 37 %. Пилот классификации, не лечение.
- 72. [S104]** Majjouti K., Priester V., Tapp-Herrenbrueck M., Brehmer A., Pinnekamp H., Aleithe M., Fischer U., Kleesiek J., Hosters B. «Nursing-centered development of an AI-based decision support system in pressure ulcer and incontinence-associated dermatitis management — a mixed methods study» — *BMC Nursing*, 2025;24. URL: <https://link.springer.com/article/10.1186/s12912-025-03448-4> — doi:10.1186/s12912-025-03448-4. Проект KIADEKU: снимок + сестринский минимум данных (18 раневых и 4 этиологических категории) + DSS медсестре. Это не американский MDS/PDPM. Регистрация разработки: DRKS00029961.
- 73. [S105]** Pinnekamp H., Priester V., Steidle J., Majjouti K., Brehmer A., Tapp-Herrenbrück M., Aleithe M., Kleesiek J., Hosters B., Fischer U. «Effects of a transformer-based AI-based application to support incontinence-associated dermatitis and pressure injury assessment, nursing care and documentation: Controlled pilot intervention study» — *International Journal of Nursing Studies Advances*, 2026;10:100479. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666142X26000019> — doi:10.1016/j.ijnsa.2026.100479. Контролируемый пилот KIADEKU (88 сеансов, семь отделений LMU): время ухода и документации 12,84 против 9,20 мин; соблюдение гайдлайна выше; нагрузка NASA-TLX без статистически значимого снижения. Регистрация: DRKS00031355. Автолечения нет.
- 74. [S106]** Lavallée J.F., Gray T.A., Dumville J., Cullum N. «Preventing pressure ulcers in nursing homes using a care bundle: A feasibility study» — *Health & Social Care in the*

Community, 2019;27(4):e417–e427. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6618244/> — doi:10.1111/hsc.12742. Пакет профилактики в одном доме ухода на севере Англии: осмотр кожи, опорные поверхности, повороты; в материалах внедрения — питание и обучение семьи. Feasibility, не масштаб; сначала дисциплина ухода, потом цифра.

75. [S107] Ni T.F., Wang J.-L., Chen C.K., Shih F., Wang J. «Can a prolonged healing pressure injury be benefited by using an AI mattress? A case study» — BMC Geriatrics, 2024;24. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38566023/> — doi:10.1186/s12877-024-04900-x. Один кейс в доме ухода на Тайване: матрас с картой давления. Железо позже, не пилот № 1 кандидата Н.
76. [S108] Fraunhofer EMFT. «AI-assisted prophylaxis of pressure ulcers» / Sorala (KIPRODE) — страница проекта. URL: <https://www.emft.fraunhofer.de/en/projects-fraunhofer-emft/AI-assisted-prophylaxis-pressure-ulcers.html> — сенсорные пластыри раннего предупреждения; feasibility, разработка / планируемый spin-off. Не рецензия; железо позже, не пилот № 1.
77. [S109] Freeman S., Sargent M.J., Rodriguez Galarza L., McAloney R., Rossnagel E. «Use of Artificial Intelligence-Driven Wound Care Management to Enhance Access to Care Rural and Northern Communities» — International Wound Journal, 2025;22(10):e70767. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12457695/> — doi:10.1111/iwj.70767. Сельский канадский воркшоп (N = 11) с демонстрацией Swift Skin and Wound: готовность персонала, не масштаб внедрения.
78. [S110] Kitamura A., Ando A., Nakagami G., Sanada H. «An Expert Knowledge Algorithm and Model Predicting Wound Healing Trends for a Decision Support System for Pressure Injury Management in Home Care Nursing: Development and Validation Study» — JMIR Nursing, 2025;8:e65716. URL: <https://nursing.jmir.org/2025/1/e65716/> — doi:10.2196/65716. CDSS для патронажных медсестёр: тяжесть по DESIGN-R®2020 и рекомендации человеку, не вместо него.
79. [S111] Armeni P., Polat I., De Rossi L.M., Diaferia L., De Padova S., Gatti A., Meregalli S. «Promoting healthy aging in a digital world: leveraging technology for enhanced elderly care and wellbeing» — Frontiers in Aging, 2026;7:1687784. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12913556/> — doi:10.3389/fragi.2026.1687784. Европейский обзор DHT: носимые датчики, ИИ, роботы, VR; барьеры масштаба (дизайн, полевая валидация, цифровая включённость, этика, оплата, модели доставки). Пилот ≠ масштаб.
80. [S112] Nilsson M., Hanson E. et al. / Eurocarers. «Integrating Artificial Intelligence within Informal Care and Long-Term Care: Enhancing Opportunities while Mitigating Threats» — позиционный доклад, июль 2024. URL: <https://eurocarers.org/wp-conte>

nt/uploads/2024/07/Eurocarers-AI_pp.pdf — страница публикации: <https://eurocarers.org/publications/integrating-artificial-intelligence-within-informal-care-and-long-term-care-enhancing-opportunities-while-mitigating-threats/> — применение ИИ в неформальном уходе и LTC ещё «эмбриональное»; этика (приватность, данные); цифра не заменяет живого контакта.

- 81. [S113]** Hofstede B.M., Ipakchian Askari S., van Hoesel T.R.C., Cuijpers R.H., de Witte L.P., IJsselsteijn W.A., Nap H.H. «Huggable integrated socially assistive robots: exploring the potential and challenges for sustainable use in long-term care contexts» — *Frontiers in Robotics and AI*, 2025;12:1646353. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/robotics-and-ai/articles/10.3389/frobt.2025.1646353/full> — doi:10.3389/frobt.2025.1646353. Голландские HI-SAR: потенциал и барьеры (гигиена, слабая интерактивность, мониторинг) в LTC; не замена персонала и не кандидат карты.